LAPORAN KEBIDANAN (ASKEB) PADA CONTINUITY OF CARE
PADA NY. C DI KLINIK PRATAMA GITA
TAHUN 2024

Disusun untuk Memenuhi Tugas Praktik Profesi Bidan
Di Institut Kesehatan Deli Husada Delitua

DISUSUN
OLEH :

JOUWITA OBRIANA ZEGA, S.Keb
NPM : 24.23.144

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA
T.A 2024/2025

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diperiksa, dievaluasi dan disetujui oleh pembimbing praktek dan pembimbing akademik Di Klinik Pratama Gita

Medan, 20 November 2024

Mahasiswa

Jouwita Obriana zega

Npm : 24.23.144

Pembimbing praktik

Bd. Gita Novarina, Str.Keb

Pembimbing Akademik

Septa Dwi Insani,S.Keb,Bd,MMRS

Npp : 19920905 201710 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Bd.G.F.Gustina Siregar, SST, M.Kes

NPP: 19880808.201109.2.002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kasus yang berjudul Asuhan Kebidanan yang berkesinambungan (*continuity care*) pada Ny. A Di Klinik Pratama Gita .

Asuhan Kebidanan ini merupakan salah satu tugas dalam rangkaian Pendidikan Profesi Kebidanan Program Pendidikan Profesi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terulin S. Meliala, AM.Keb, SKM,. M.Kes, selaku ketua Yayasan RSU Sembiring.
2. Drs. Johanes Sembiring, M.Pd,. M.Kes, selaku rector Institut Kesehatan Deli Husada Delitua.
3. Bd. Peny Ariani, SST.,M.Keb, Selaku Dekan Fakutas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Delitua
4. Bd. GF Gustina Siregar, SST.,M.Kes, selaku koordinator program studi Pendidikan profesi bidan program Profesi Institut Kesehatan Deli Husada Delitua.
5. Septa Dwi Insani,S.Keb,Bd, MMRS, selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta pengaruh positif kepada saya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bantuan kepada kami dalam penyelesaikan asuhan kebidanan ini. Kami sadari betul bahwa asuhan kebidanan ini masih kurang sempurna, maka dari itu kami berharap kritik dan saran dari pembaca dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 20 November 2024

Mahasiswa

Jouwita Obriana zega

Npm : 24.23.144

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I viii
PENDAHULUAN viii
1.1. LATAR BELAKANG viii
1.1.1. Identifikasi Ruang Lingkup Asuhan 3
1.2. Tujuan Penyusunan 3
1.2.1. Tujuan Umum 3
1.2.2. Tujuan Khusus 3
1.3. Sasaran 3
1.4. Manfaat 4
1.4.1. Bagi Penulis 4
1.4.2. Bagi Tempat Penelitian 4
1.4.3. Bagi Institusi Pendidikan 4
1.4.4. Bagi Responden 4
1.4.5. Bagi Peneliti Selanjutnya 4
BAB II 2
TINJAUAN PUSTAKA 2
2.1. Kehamilan 2
2.1.1. Konsep Dasar Kehamilan 2
2.1.2. Asuhan Kehamilan 10
2.2. Persalinan 17
2.2.1. Konsep Dasar Persalinan 17
2.2.2. Asuhan Persalinan 27
2.3. Nifas 36
2.3.1. Konsep Dasar Masa Nifas 36
2.3.2. Asuhan Nifas 41

2.4. Bayi Baru Lahir 46
2.4.1. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir 46
2.4.2. Asuhan Bayi Baru Lahir 48
2.5. Keluarga Berencana 52
2.5.1. Konsep Dasar Keluarga Berencana 52
BAB III 60
TUJUAN KASUS 60
3.1. KEHAMILAN 60
3.1.1. CATATAN PERKEMBANGAN KEHAMILAN TM III 66
3.1.2. CATATAN PERKEMBANGAN KEHAMILAN TM-III 71
3.2. PERSALINAN 73
3.2.1. CATATAN PERKEMBANGAN PERSALINAN 81
3.3. MASA NIFAS 95
3.3.1. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas Pertama (6 Jam Postpartum) 98
3.3.2. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas (3 Hari Post Partum) .. 100
3.3.3. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas Ketiga (2 Minggu Postpartum) 102
3.3.4. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas Keempat (6 Minggu Postpartum) 103
3.4. BAYI BARU LAHIR 104
3.4.1 Catatan Perkembangan Kunjungan Bayi Baru Lahir Pertama (6 Jam) 109
3.4.2. Catatan Perkembangan Kunjungan Neonatal Kedua (6 Hari) 110
3.4.3 Catatan Perkembangan Kunjungan Neonatal Ketiga (28 Hari) 111
3.5. KELUARGA BERENCANA 113
3.5.1. CATATAN PERKEMBANGAN KB 116
BAB IV 6
PEMBAHASAN 6
4.1. Masa Kehamilan 6
4.2. Asuhan Masa Persalinan 6
4.3. Asuhan Masa Nifas 121
4.4. Bayi Baru Lahir 126

4.5. Keluarga Berencana 128
BAB V 130
KESIMPULAN DAN SARAN 130
5.1. Kesimpulan 130
5.2. Saran 130
DAFTAR PUSTAKA 132

DAFTAR TABEL

Tebel 2. 1. Pengukuran Tinggi Fundus Uteri dari Simfisis menurut Spiegelberg .. 6
Tebel 2. 2. Tinggi Fundus Uteri Menurut Leopold 6
Tebel 2. 3. Perhitungan Berat Badan Berdasarkan Indeks Masa Tubuh 9
Tebel 2. 4. Kunjungan Pemeriksaan Antenatal 10
Tebel 2. 5. Riwayat Medis Untuk dimiliki Pada Kunjungan Pertama 11
Tebel 2. 6. Pemberian Vaksin TT untuk Ibu yang belum pernah imunisasi (DPT/TT/Td) atau Tidak Tahu Status Imunisasi 15
Tebel 2. 7. Pemberian Vaksin Tetanus untuk Ibu yang sudah pernah dimunisasi (DPT/TT/Td)..... 15
Tebel 2. 8. TFU dan Berat Uterus Menurut Masa Involusi 37
Tebel 2. 9. Perbedaan Masing-masing Lokhea 38
Tebel 2. 10. Jenis-Jenis ASI 41
Tebel 2. 11. Kunjungan Masa Nifas..... 42
Tebel 2. 12. Anamnesis Pada Ibu Nifas 43
Tebel 2. 13. Pemeriksaan Pada Ibu Nifas Pada Ibu Nifas 44
Tebel 2. 14. Tindakan yang baik untuk masa Nifas 44
Tabel 3. 1 Penilaian Bayi dengan Metode APGAR 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seorang ibu dapat meninggal tiap menit dalam sehari yang disebabkan oleh komplikasi persalinan. Menurut *Word Health Organization* (WHO) memperkirakan sebanyak 37 juta kelahiran hidup dkikawasan Asia Tenggara setiap tahunnya, sementara total kematian ibu dan bayi baru lahir dikawasan ini diperkirakan berturut-turut 170.000 dan 1,3 juta pertahun, kematian ibu sebanyak 99% akibat masalah persalinan dan kelahiran, terjadi dinegara-negara berkembang (Prawirohardjo, 2012).

Penyebab tingginya AKI di Indonesia adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai (Nurasiah dkk, 2014). Secara langsung penyebab tingginya AKI adalah perdarahan post partum, infeksi dan eklampsi. Dari 5.600.000 wanita hamil di Indonesia, sejumlah 27% akan mengalami kompliksi atau masalah yang bisa berakibat fatal (Hutari, 2012). Sedangkan AKB disebabkan oleh kelainan kongenital, asfiksia neonatorum dan lain-lain (Prawirohardjo, 2012).

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, rata-rata kematian Ibu tercatat mencapai 359/100.000 KH. Rata-rata AKI meningkat dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228/100.000 KH. Angka kematian bayi tahun 2012 mencapai 32/1.000 KH, terjadi peningkatan AKB pada tahun 2007 yaitu 34/1.000 KH, dengan penyebab kematian ibu 28% karena perdarahan, eklampsi 24%, infeksi 11%, abortus 5%, partus lama/macet 5%, emboli obstetri 5%, komplikasi masa puerperium 8%, lain-lain 11%. Engan meningkatnya AKI dan AKB tentu pemerintah harus lebih meningkatkan lagi daya kerja yang sebelumnya bertekad akan menurunkan AKI hingga 102/100.000 KH dan AKB diperkirakan target 23/1.000 KH pada tahun 2015 sesuai dengan target MDGs (*Millenium Development Goals*) dapat tercapai.

Upaya untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015 dengan meningkatkan kualitas pelayanan ANC oleh tenaga kesehatan profesional, cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih. Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu diantaranya pelayanan kesehatan dasar (*primary health care), safe motherhood initiative*, bidan di desa, gerakan sayang ibu (GSI), gerakan pembangunan berwawasan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010, *making pregnancy safer*, PONED dan PONEK serta desa siaga (Prawirohardjo, 2013). Upaya pemerintah dalam rangka memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu melalui System Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Wibowo, 2014).

Berdasarkan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan kualitas kesehatan di Sumut juga terlihat dari angka kematian bayi yang turun menjadi 25,7 per 1.000 kelahiran, dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001. Selain itu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi (Susenas) yang dilaksanakan BPS, usia harapan hidup di Sumut juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 yakni 68,15 tahun. Sedangkan pada tahun 2013 hanya 67,98 tahun. Dalam laporan tersebut juga tercatat prevelensi gizi kurang dan gizi buruk di Sumut juga mengalami penurunan dari 21,05 % pada tahun 2013 menjadi 19,7 % pada tahun 2014 (Anonim, 2014).

Guilliland dan Pairman (2010), menjelaskan bahwa asuhan kebidanan berkesinambungan adalah asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan (dan tim nya) kepada perempuan sepanjang keseluruhan pengalaman persalinannya. Asuhan ini menitikberatkan pada hubungan satu-satu, antara pasien dan pemberi asuhan, dengan harapan dapat terbangun “parnership” yang baik dengan pasien, sehingga terbina hubungan saling percaya. Upaya tersebut dapat dimulai dari kehamilan dan seterusnya (bersalin dan postpartum, serta masa menyusui), yang juga merupakan waktu yang paling tepat untuk bidan bekerja bersama setiap perempuan untuk mendiskusikan harapannya dan ketakutannya akan proses kelahiran dan proses menjadi ibu, serta membangun kepercayaan dirinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Asuhan Kebidanan yang berkesinambungan (*continuity care*) pada Ny. A Di Klinik Pratama Gita .

1.1.1. Identifikasi Ruang Lingkup Asuhan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa interval dan asuhan bayi baru lahir serta melakukan pendokumentasian kebidanan yang telah dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB yang Di Desa Candirejo Dusun 1.

1.2. Tujuan Penyusunan

1.2.1. Tujuan Umum

Memberikan asuhan kebidanan secara *continuity care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.

1.2.2. Tujuan Khusus

2. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil
3. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin
4. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas
5. Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir
6. Melakukan asuhan kebidanan pada keluarga berencana
7. Mendokmentasikan asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB

1.3. Sasaran

Memberikan asuhan kebidanan secara *continuity care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengalaman, wawasaan dan pengetahuan mahasiswi, dalam memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan (*continuity care)* dan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana.

1.4.2. Bagi Tempat Penelitian

Sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkesinambungan (*continuity care).*

1.4.3. Bagi Institusi Pendidikan

Agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang lebih luas dalam penelitian.

1.4.4. Bagi Responden

Untuk meningkatkan pengetahuan pada ibu dan keluarga pada masa hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan KB.

1.4.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk meningkatkan pengalaman dan wawasan dalam melakukan penelitian serta dapat memahami tentang asuhan kebidanan secara berkesinambungan (*continuity care)* pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kehamilan

2.1.1. Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Walyani dan Purwoastuti, 2015).

Kehamilan ialah peristiwa yang didahului bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma dan akan berlangsung selama kira-kira 10 bulan lunar atau 9 bulan kalender atau 40 minggu atau 280 hari yang dihitung dari hari pertama periode menstruasi terakhir (Bobak, Lowdermilk dan Jensen, 2016).

Definisi dari masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalh 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Rukiyah, 2013).

b. Fisiologi Kehamilan

Pada kehamilan terdapat perubahan pada seluruh tubuh wanita, khususnya pada alat reproduksi serta pada payudara (mammae). Menurut Rukiyah dkk (2013) perubahan yang terdapat pada ibu hamil trimester III antara lain, yaitu :

1. Uterus

Pada akhir kehamilan cukup bulan, ukuran uterus adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4.000 cc hal ini memingkinkan bagi adekuatnya akomodasi pertumbuhan janin. Pada bulan-bulan pertama kehamilan, bentuk uterus seperti buah alpukat agak gepeng.Frekuensi dan kekuatan kontraksi otot segmen atas rahim semakin meningkat. Oleh karena itu segmen bawah uterus berkembang lebih cepat dan meregang secara radial, yang jika terjadi bersamaan

dengan pembukaan *serviks* dan pelunakan jaringan dasar *pelvis*, akan menyebabkan presentasi janin memulai penurunannya ke dalam *pelvis* bagian atas. Hal ini disebabkan oleh kepala janin yang pada primigravida turun dan masuk kedalam rongga panggul.Pada trimester III , istmus uteri lebih nyata menjadi corpus uteri dan berkembang menjadi segmen bawah uterus atau segmen bawah rahim (SBR).

Tebel 2. 1. Pengukuran Tinggi Fundus Uteri dari Simfisis menurut Spiegelberg

No	Usia Kehamilan	Tinggi Fundus Uteri
1	**22-28 minggu**	**24-25 cm di atas simfisis**
2	**28 minggu**	**26,7 cm di atas simfisis**
3	**30 minggu**	**29,5-30 cm di atas simfisis**
4	**32 minggu**	**29,5-30 cm di atas simfisis**
5	**34 minggu**	**31 cm di atas simfisis**
6	**36 minggu**	**32 cm di atas simfisis**
7	**38 minggu**	**33 cm di atas simfisis**
8	**40 minggu**	**37,7 di atas simfisis**

Sumber : Rustam, M. 2013.

Tebel 2. 2. Tinggi Fundus Uteri Menurut Leopold

No	Usia Kehamilan	Tinggi Fundus
1	28	2-3 jari diatas pusat
2	32	Pertengahan pusat – px
3	36	3 jari dibawah px atau sampai setinggi pusat
4	40	Pertengahan pusat – px, tetapi melebar kesamping

Sumber : Sofian, A. 2012

2. Serviks Uteri

Serviks akan mengalami perlunakan atau pematangan secara bertahap akibat bertambahnya aktivitas uterus selama kehamilan, dan akan mengalami dilatasi sampai pada kehamilan trimester III.

3. Vagina dan Vulva

Terjadi peningkatan rabas vagina.Peningkatan cairan vagina selama kehamilan adalah normal, cairan biasanya jernih.

4. Payudara

Keluarnya cairan berwarna kekuningan dari payudara ibu yang disebut dengan kolostrum.Hal ini tidak berbahaya dan merupakan pertanda bahwa payudara sedang menyiapkan Air Susu Ibu (ASI) untuk menyusui bayi nantinya.

5. Kulit

Perubahan warna kulit menjadi lebih gelap terjadi pada 90% ibu hamil.Hiperpigmentasi terlihat lebih nyata pada wanita berkulit gelap dan terlihat di area seperti aerola mammae, perineum, dan umbilikus juga di area yang cenderung mengalami gesekan seperti aksila dan paha bagian dalam.Hal ini disebabkan karena peningkatan hormon penstimulasi (melanosit stimulating hormone–MSH), estrogen dan progesteron.

6. Sistem Kardiovaskular

Kondisi tubuh dapat memiliki dampak besar pada tekanan darah.Posisi telentang dapat menurunkan curah jantung hingga 25%.Kompresi vena cava inferior oleh uterus yang membesar selama trimester ketiga mengakibatkan menurunnya aliran balik vena.Sirkulasi uteroplasenta menerima proposi curah jantung yang terbesar, dengan aliran darah meningkat dari 1-2% pada trimester pertama hingga 17% pada kehamilan cukup bulan.Hal ini diwujudkan dalam peningkatan aliran darah maternal ke dasar plasenta kira – kira 500 ml/menit pada kehamilan cukup bulan.

Menurut Irene M. Bobak peningkatan volume darah terjadi selama kehamilan, mulai pada 10-12 minggu usia kehamilan dan secara progresif sampai dengan usia kehamilan 30-34 minggu. Anemia adalah suatu kondisis dimana terdapat kekurangan sel darah merah atau haemoglobin. Kadar Hb < 11 gr/dl (pada trimester I dan III) atau < 10,5 g/dl (pada trimester II) (Kemenkes RI,

2013). Menurut Manuaba, anemia pada ibu hamil dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tidak anemia (Hb 11 gr/dl), anemia ringan (Hb 910 gr/dl), anemia sedang (Hb 7-8 gr/dl), anemia berat (< 7 gr/dl) (Suryandari dan Happinasari, 2015). Program intervensi untuk menanggulangi ataupun mencegah kekurangan zat besi salah satunya adalah peningkatan konsumsi makanan kaya gizi.Untuk menanggulangi masalah anemia defisiensi zat besi melalui peningkatan asupan makanan dapat diupayakan dengan mengonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi tinggi dan/atau meningkatkan konsumsi bahan makanan yang bersifat meningkatkan absorbsi zat besi. Memberikan zat besi 60 mg/hari dapat menaikkan kadar Hb sebanyak 1 gr/dl/bulan.

7. Sistem Respirasi

Perubahan hormonal pada kehamilan trimester tiga yang memengaruhi aliran darah ke paru – paru mengakibatkan banyak ibu hamil akan merasa susah bernafas. Ini juga didukung oleh adanya tekanan rahim yang membesar yang dapat menekan diafragma, sehingga ibu hamil merasa susah bernafas.

8. Sistem Pencernaan

Pada kehamilan trimester tiga, lambung berada pada posisi vertikal dan bukan pada posisi normalnya, yaitu horizontal.Kekuatan mekanis ini menyebabkan peningkatan intragastrik dan perubahan sudut persambungan gastro-esofageal yang mengakibatkan terjadinya refluks esofageal yang lebih besar.Penurunan drastis tonus dan motilitas lambung dan usus ditambah relaksasi sfingter bawah esophagus merupakan faktor predisposisi terjadinya nyeri ulu hati, konstipasi, dan hemoroid.Hemoroid terjadi akibat konstipasi dan naiknya tekanan vena-vena dibawah uterus termasuk vena hemoroidal.Konstipasi dikarenakan hormon progesteron menimbulkan gerakan usus makin berkurang (relaksasi otot – otot polos) sehingga makanan lebih lama didalam usus dan juga dapat terjadi karena kurangnya aktifitas/senam dan penurunan asupan cairan.

9. Sistem Perkemihan

Perubahan anatomis yang sangat besar terjadi pada system perkemihan saat hamil yaitu ginjal dan ureter.Pada akhir kehamilan, terjadi peningkatan frekuensi Buang Air Kecil (BAK) karena kepala janin mulai turun sehingga kandung kemih tertekan.Perubahan struktur ginjal ini juga merupakan aktivitas

hormonal (estrogen dan progesteron), tekanan yang timbul akibat pembesaran uterus, dan peningkatan volume darah.

10. Sistem Muskuloskeletal

Postur tubuh wanita secara bertahap mengalami perubahan karena janin membesar dalam abdomen.Untuk mengompensasi penambahan berat badan ini, bahu lebih tertarik ke belakang dan tulang belakang lebih melengkung, sendi tulang belakang lebih lentur. Lordosis yang progesif akan menjadi bentuk yang umum pada kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang ke arah dua tungkai. Sendi sakroiliaka, sakrokoksigis dan pubis akan meningkat mobilitasnya, yang diperkirakan karena pengaruh hormonal. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu dan pada akhirnya dapat menyebabkan nyeri punggung pada beberapa wanita (Saifuddin, dkk, 2013).

11. Kenaikan Berat

Badan Normal berat badan meningkat sekitar 6-16 kg, terutama dari pertumbuhan isi konsepsi dan volume berbagai organ atau cairan intrauterine (Sukarni dan Margaret, 2016).

Tebel 2. 3. Perhitungan Berat Badan Berdasarkan Indeks Masa Tubuh

Kategori	IMT	Rekomendasi
Rendah	**<19,8**	**12,5-18**
Normal	**19,8-26**	**11,5-16**
Tinggi	**26-29**	**7-11,5**
Obesitas	**>29**	**≥7**
Gameli		**16-20,5**

Sumber : Walyani, E. 2015.

KET : IMT = BB/(TB)^2 IMT : Indeks Masa Tubuh

BB : Berat Badan (kg)

TB : Tinggi Badan (cm)

2.1.2. Asuhan Kehamilan

Menurut Kemenkes RI (2015) untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, anjurkan setiap ibu hamil untuk melakukan kunjungan antenatal komprehensip yang berkualitas minimal 4 kali.

Tebel 2. 4. Kunjungan Pemeriksaan Antenatal

Trimester	Jumlah Kunjungan	Waktu Kunjungan yang dianjurkan
I	**1x**	**Sebelum minggu ke16**
II	**1x**	**Antara minggu ke 24-28**
III	**2x**	**Antara minggu 30-32**
		Antara minggu 36-38

Sumber : Kemenkes RI. 2015

Tujuan dari asuhan antenatal adalah memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu dan bayi, mengenali secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif, empersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi (Saifuddin, dkk, 2013).

Setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat.Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya (Saifuddin, dkk. 2013).

Menurut Saifuddin, dkk (2013) penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

1. Mengupayakan kehamilan yang sehat.
2. Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
3. Persiapan persalinan yang bersih dan aman.
4. Perencanaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.

a). Melengkapi Riwayat Medis

Pada setiap kunjungan antenatal, petugas mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi ibu melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis kehamilan intrauterin, serta ada tidaknya masalah atau komplikasi (Saifuddin, dkk, 2013) Pada kunjungan pertama riwayat medis ibu yang harus dilengkapi adalah seperti tertera pada tabel dibawah ini. Pada kunjungan berikutnya, selain memperhatikan catatan pada kunjungan sebelumnya, tanyakan keluhan yang dialami ibu selama kehamilan berlangsung (Kemenkes RI, 2013).

Tebel 2. 5. Riwayat Medis Untuk dimiliki Pada Kunjungan Pertama

Identitas	**Riwayat Kehamilan Sekarang**
1. Nama **2. Usia** **3. Nama suami (jika ada)** **4. Alamat** **5. No. Telepon** **6. Tahun menikah (jika sudah menikah)** **7. Agama** **8. Suku**	**1. Hari pertama haid terakhir** **2. Tafsiran waktu persalinan** **3. Perdarahan pervaginam** **4. Keputihan** **5. Mual dan muntah** **6. Masalah pada kehamilan ini** **7. Pemakaian obat dan jamu-jamuan** **8. Keluhan lainnya**
Riwayat Kontrasepsi	**Riwayat Medis Lainnya**
1. Riwayat kontrasepsi terdahulu **2. Riwayat kontrasepsi terakhir sebelum kehamilan ini**	**1. Penyakit Jantung** **2. Hipertensi** **3. Diabetes mellitus** **4. Hepatitis** **5. HIV** **6. IMS** **7. Tuberkolusis** **8. Alergi obat/makanan** **9. Penyakit ginjal kronik** **10. Talasemia dan gangguan hematologi lainnya**
Riwayat Obstetri Lalu	
1. Jumlah kehamilan **2. Jumlah persalinan** **3. Jumlah persalinan cukup bulan** **4. Jumlah persalinan premature** **5. Jumlah anak hidup, berat lahir serta jenis kelamin**	

6. Cara persalinan **7. Jumlah keguguran** **8. Jumlah aborsi** **9. Perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas yang terdahulu** **10. Adanya hipertensi dalam kehamilan terdahulu** **11. Riwayat berat bayi < 2,5 kg atau > 4 kg** **12. Riwayat kehamilan sunsang** **13. Riwayat kehamilan ganda** **14. Riwayat pertumbuhan janin terhambat** **15. Riwayat penyakit dan kematian perinatal, neonatal dan kematian**	**11. Malaria** **12. Asma** **13. Epilepsi** **14. Riwayat penyakit kejiwaan** **15. Riwayat operasi** **16. Status imunisasi TT** **17. Riwayat transfusi darah** **18. Golongan darah** **19. Riwayat penyakit di keluarga** **20. Riwayat kecelakaan (trauma)**
Riwayat Sosial Ekonomi	
1. Usia ibu saat pertama kali menikah **2. Status perkawinan, berapa kali menikah** **3. Respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan dan kesiapan persalinan** **4. Siapa pembuat keputusan dalam keluarga** **5. Kebiasaan atau pola makan minum** **6. Kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan dan alkohol**	**7. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari** **8. Pekerjaan pasangan** **9. Pendidikan** **10. Kehidupan seksual** **11. Pilihan tempat untuk melahirkan**

Sumber : Kemenkes RI. 2013.

b). Melengkapi Pemeriksaan Fisik Umum Menurut Kemenkes RI (2013)

pemeriksaan fisik umum yang harus dilakukan pada ibu hamil adalah sebagai berikut. :

1. Pemeriksaan fisik umum pada kunjungan pertama :

- Tanda vital : (tekanan darah, suhu badan, frekuensi nadi, frekuensi napas)
- Berat badan
- Tinggi badan
- Lingkar Lengan Atas (LiLA)
- Muka : apakah ada edema atau terlihat pucat
- Status generalis atau pemeriksaan umum lengkap, meliputi kepala, mata, higiene mulut dan gigi, karies, tiroid, jantung, paru, payudara (apakah terdapat benjolan, bekas operasi didaerah aerola, bagaimana kondisi putting), abdomen (terutama bekas operasi terkait uterus), tulang belakang, ekstremitas (edema, varises, reflekspatella serta kebersihan kulit).

2. Pemeriksaan fisik umum pada kunjungan berikutnya :

- Tanda vital : tekanan daah, suhu badan, frekuensi nadi, frekuensi napas
- Berat badan
- Edema
- Pemeriksaan terkait masalah yang telah teridentifikasi pada kunjungan sebelumnya.

c). Melengkapi Pemeriksaan Fisik Obstetri

Menurut Kemenkes RI (2013) pemeriksaan fisik obstetri yang dilakukan pada ibu hamil meliputi :

1. Pemeriksaan fisik obstetri pada kunjungan pertama :

- Tinggi fundus uteri (menggunakan pita ukur bila usia kehamilan >20 minggu)
- Vulva/perineum untuk memeriksa adanya varises, kondiloma, edema, haemooroid atau kelainan lainnya

2. Pemeriksaan fisik obstetri pada setiap kunjungan berikutnya

- Pantau tumbuh kembang janin dengan mengukut tinggi fundus uteri.
- Palpasi abdomen menggunakan manuver Leopold :

- Leopold I : menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terletak di fundus uteri (dilakukan sejak awal trimester I)
- Leopold II : menentukan bagian janin pada sisi kanan dan kiri ibu (dilakukan mulai akhir trimester II)
- Leopold III : menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah uterus (dilakukan mulaiakhir trimester II)
- Leopold IV : menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul (dilakukan bila usia kehamilan >36 minggu)

- Auskultasi denyut jantung janin menggunakan doppler (jika usia kehamilan >16 minggu).
- Melakukan Pemeriksaan Penunjang
  Pemeriksaan penunjang untuk ibu hamil meliputi pemeriksaan laboratorium (rutin maupun sesuai indikasi) dan pemeriksaan ultrasonografi (Kemenkes RI, 2013).
- Memberikan Suplemen dan Pencegahan Penyakit Menurut Kemenkes RI (2013) pemberian suplemen dan pencegahan penyakit pada ibu hamil adalah sebagai berikut :

1. Beri ibu 60 mg zat besi elemental segera setelah mual/muntah berkurang dan 400 µg asam folat 1x/hari sesegera mungkin selama kehamilan.

a. Catatan : 60 mg besi elemental setara 320 mg sulfas ferosus.
b. Efek samping yang umum dari zat besi adalah gangguan saluran cerna (mual, muntah, diare, konstipasi)
c. Tablet zat besi sebaiknya tidak diminum bersama dengan teh atau kopi karena mengganggu penyerapan.
d. Jika memungkinkan, idealnya asam folat sudah mulai diberikan sejak 2 bulan sebelum hamil (saat perencanaan kehamilan).

2. Beri ibu vaksin tetanus toksoid (TT) sesuai status imunisasinya. Pemberian immunisasi pada wanita usia subur atau ibu hamil harus didahului dengan skrinning untuk mengetahui jumlah dosis (dan status) imunisasi TT yang telah diperoleh selama hidupnya. Pemberian imunisasi TT tidak mempunyai

interval (selang waktu) maksimal, hanya terdapat interval minimal antar dosis TT.

a. Jika ibu belum pernal imunisasi atau status imunisasinya tidak diketahui, berikan dosis vaksin (0,5 ml IM di lengan atas) sesuai tabel berikut.

Tebel 2. 6. Pemberian Vaksin TT untuk Ibu yang belum pernah imunisasi (DPT/TT/Td) atau Tidak Tahu Status Imunisasi

Pemberian	Selang Waktu Minimal
TT1	**Saat kunjungan pertama (sedini mungkin pada kehamilan**
TT2	**4 minggu setelah TT1**
TT3	**6 bulan setelah TT2**
TT4	**1 tahun setelah TT3**
TT5	**1 tahun setelah TT4**

Sumber: Kemenkes RI. 2013

b. Dosis booster mungkin diperlukan pada ibu yang sudah pernah diimunisasi. Pemberian dosis booster 0,5 ml IM disesuaikan dengan jumlah vaksinasi yang pernahditerima sebelumnya seperti pada tabel berikut:

Tebel 2. 7. Pemberian Vaksin Tetanus untuk Ibu yang sudah pernah dimunisasi (DPT/TT/Td)

Pernah	Pemberian Selang Waktu Minimal
1 kali	**TT2, 4 minggu setelah TT1**
2 kali	**TT3, 6 bulan setelah TT2**
3 kali	**TT4, 1 tahun setelah TT3**
4 kali	**TT5, 1 tahun setelah TT4**
5 kali	**Tidak perlu lagi**

Sumber : Kemenkes RI. 2013

a. Memberikan Materi Konseling,Informasi dan Edukasi (KIE)

Menurut Kemenkes RI (2013) buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) wajib dimiliki oleh setiap ibu hamil, karena materi konseling dan edukasi

yang perlu diberikan tercantum di buku tersebut. Pastikan bahwa ibu hamil memahami hal-hal berikut:

1. **Persiapan persalinan, termasuk:**
   a. Siapa yang akan menolong persalinan
   b. Dimana akan melahirkan
   c. Siapa yang akan menemani dalam persalinan
   d. Kemungkinan kesiapan donor darah bila timbul permasalahan
   e. Transportasi
   f. Dukungan biaya
2. **Pentingnya peran suami atau pasangan dan keluarga selama kehamilan dan persalinan.**
3. **Tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai:**
   a. Sakit kepala lebih dari biasa
   b. Perdarahan per vaginam
   c. Gangguan penglihatan
   d. Pembengkakan pada wajah/tangan
   e. Nyeri abdomen (epigastrium)
   f. Mual muntah berlebihan
   g. Demam
   h. Janin tidak bergerak sebanyak biasanya
4. **Pemberian makanan bayi, ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).**
5. **Penyakit yang mempengaruhi kesehatan ibu dan janin.**
6. **Perlunya menghentikan kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan seperti merokok dan minum alkohol.**
7. **Program KB terutama penggunaan kontrasepsi pascasalin.**
8. **Kesehatan ibu termasuk kebersihan, aktivitas dan nutrisi.**
9. **Hubungan suami istri boleh dilanjutkan selama kehamilan (kondom)**

a. Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning)

Menurut Mangkuji, dkk (2014) pembuatan grafik metode SOAP merupakan pengelolaan informasi yang sistematis yang mengatur penemuan dan konklusi kita menjadi suatu rencana asuhan, metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan guna menyusun dokumentasi asuhan.

1. **Subjektif**
   a. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis
   b. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien
   c. Pada orang yang bisu, dibelakang data diberi tanda “o” atau “x”
2. **Objektif**
   a. Pendokumentasian hasil pemeriksan fisik
   b. Hasil pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain
   c. Informasi dari keluarga atau orang lain
3. **Assesment**
   a. Pendokumentasian hasil analisis dan inerpretasi (kesimpulan) data subjektif dan objektif
   b. Diagnosis/masalah
   c. Diagnosis/masalah potensial
   d. Antisipasi diagnosis/masalah potensial/tindakan segera
4. **Planning Pendokumentasian tindakan (I) dan evaluasi (E), meliputi: asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostik/laboratorium, konseling dan tindak lanjut (follow up).**

2.2. Persalinan

2.2.1. Konsep Dasar Persalinan

a. **Pengertian Persalinan**

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin (Sukarni dan Margareth, 2016).

Persalinan adalah persalinan yang dimulai secara spontan beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama proses persalinan, bayi dilahirkan spontan dengan presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu lengkap. Setelah persalinan ibu dan bayi dalam keadaan baik (Walyani dan Th Endang, 2016).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Persalinan mencakup proses fisiologi yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin (Jannah, 2017).

b. **Fisiologi Persalinan**

1. Fisiologi Persalinan Kala I

Menurut Jannah (2017) perubahan fisiologi yang terjadi pada ibu bersalin kala I sebagai berikut :

a. Perubahan Uterus

Uterus terdiri atas dua komponen fungsional utama, yaitu myometrium dan serviks. Berikut ini akan dibahas tentang kedua komponen fungsional beserta perubahannya.

b. Kontraksi Uterus

Kontraksi uterus bertanggung jawab terhadap penipisan dan pembukaan serviks dan pengeluaran bayi dalam persalinan.Kontraksi uterus saat persalinan sangat unik karena merupakan kontraksi otot yang sangat sakit. Kontraksi uterus bersifat involunter yang bekerja di bawah control saraf dan intermiten yang memberikan keuntungan berupa adanya periode istrahat atau relaksasi di atara dua kontraksi.

c. Perubahan Serviks

Kala I persalinan dimulai dari awal munculnya kontraksi persalinan yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri

dengan pembukaan serviks lengkap. Kala I dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Fase laten berlangsung mulai dari pembukaan serviks 0 sampai berakhir di pembukaan serviks 3 cm. Pada fase ini, kontraksi uterus meningkat frekuensi, durasi, dan intensitasnya dari setiap 10-20 menit, 15-20 detik, lalu intensitasnya cukup tinggi menjadi 5-7 menit, hingga durasi 30-40 detik dengan intensitas yang kuat. Fase aktif dimulai dari pembukaan serviks 4 cm yang diakhiri dengan pembukaan serviks 10 cm. Pada fase ini, kontraksi uterus menjadi efektif, ditandai dengan peningkatan frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi. Di akhir fase aktif, kontraksi berlangsung 2-3 menit sekali selama 60 detik.Fase aktif dibedakan menjadi fase akselerasi, dilatasi maksimal, deselerasi.Fase akselerasi, pembukaan serviks dari 3 cm menjadi 4 cm. fase tersebut merupakan fase persiapan menuju fase berikutnya.

Fase dilatasi maksimal, fase yang ditandai dengan peningkatan cepat dilatasi serviks, dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm selama 2 jam.Normalnya, pembukaan serviks pada fase tersebut konstan, yaitu 3 cm per jam untuk multipara dan 1-2 cm untuk primipara.Fase deselerasi, merupakan akhir fase aktif dengan dilatasi serviks dari 9 cm menuju pembukaan lengkap (10 cm).Dilatasi serviks pada fase tersebut lambat rata – rata 1 cm per jam, tetapi pada multipara lebih cepat.

d. Perubahan Kardiovaskular

   Pada setiap kontraksi, 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk ke dalam sistem vaskular ibu.Hal tersebut dapat meningkatkan curah jantung 10-15%.

e. Perubahan Tekanan Darah

   Tekanan darah meningkat selama kontraksi (kenaikan sistolik rata-rata 15 mmHg dan diatolik 5-10 mmHg).Tekanan darah di antara kontraksi kembali normal seperti sebelum persalinan.Rasa sakit, takut dan cemas dapat juga meningkatkan tekanan darah.

f. Perubahan Metabolisme

Selama persalinan, metabolisme aerob maupun anaerob terusmenerus meningkat seiring dengan kecemasan dan aktivitas otot.Peningkatan metabolisme tersebut ditandai dengan peningkatan suhu tubuh, nadi pernafasan, curah jantung dan kehilangan cairan.

g. Perubahan Suhu

Suhu tubuh dapat sedikit naik (0,5-10C) selama persalinan dan segera turun setelah persalinan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan metabolisme dalam tubuh.

h. Perubahan Nadi

Frekuensi nadi di antara dua kontraksi lebih meningkat dibandingkan sesaat sebelum persalinan.Perubahan tersebut disebabkan oleh metabolisme yang meningkat.

i. Perubahan Pernafasan

Peningkatan aktivitas fisik dan pemakaian oksigen terlihat dari peningkatan frekuensi pernafasan.Hiperventilasi dapat menyebabkan alkalosis respiratorik (pH meningkat), hipoksia, dan hipokapnea (CO2 menurun).

j. Perubahan Ginjal

Poliuri dapat terjadi selama persalinan.Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan curah jantung selama persalinan dan filtrasi glomerulus serta aliran plasma ginjal.

k. Perubahan Gastrointestinal

Pergerakan lambung dan absorbsi pada makanan padat sangat berkurang saat persalian.Hal itu diperberat dengan penurunan produksi asam lambung yang menyebabkan aktivitas pencernaan hampir berhenti, dan pengosongan lambung menjadi sangat lamban.Cairan tidak berpengaruh dan meninggalkan perut dengan tempo yang biasa.Mual dan muntah biasa terjadi sampai akhir kala I.

l. Perubahan Hematologik Hemoglobin meningkat sampai 1,2 g/100 ml selama persalinan dan akan kembali pada tingkat sebelum persalinan sehari setelah pasca bersalin, kecuali ada perdarahan pascapartum.

2. Fisiologi Kala II

Menurut Walyani 2016 perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu bersalin pada Kala II adalah sebagai berikut :

a. Kontraksi Uterus

Dimana kontraksi ini bersifat nyeri yang di sebabkan oleh anoxia dari sel-sel otot tekanan pada ganglia dalam serviks dan Segmen Bawah Rahim (SBR), regangan dari serviks, regangan dan tarikan pada peritoneum, itu semua terjadi pada saat kontraksi. Adapun kontraksi yang bersifat berkala dan yang harus diperhatikan adalah lamanya kontraksi berlangsung 60-90 detik, kekuatan kontraksi, kekuatan kontaraksi secara klinis ditentukan dengan mencoba apakah jari kita dapat menekan dinding Rahim ke dalam, interval anatara kedua kontraksi pada kala pengeluaran sekali dalam 2 menit.

b. Perubahan-perubahan Uterus

Keadaan Segmen Atas Rahim (SAR) dan Segmen Bawah Rahim (SBR). Dalam persalinan perbedaan SAR dan SBR akan tampak lebih jelas, dimana SAR dibentuk oleh korpus uteri dan bersifat memegang peranan aktif (berkontraksi) dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan, dengan kata lain SAR mengadakan suatu kontraksi menjadi tebal dan mendorong anak keluar. Sedangkan SBR dibentuk oleh isthmus uteri yang sifatnya memegang peranan pasif dan makin tipis dengan majunya persalinan (disebabkan karena regangan), dengan kata lain SBR dan serviks mengadakan relaksasi dan dilatasi.

c. Perubahan Pada Serviks

Perubahan pada serviks pada Kala II ditandai dengan pembukaan lengkap, pada pemeriksaan dalam tidak teraba lagi bibir portio, Segmen Bawah Rahim (SBR), dan serviks

d. Perubahan Pada Vagina dan Dasar Panggul

Setelah Pembukaan Lengkap dan Ketuban telah pecah terjadi perubahan, terutama pada dasar panggul yang direganggangkan oleh bagian depan janin sehingga menjadi saluran yang dinding-dindingnya tipis karena suatu regangan dan kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke

depan atas dan anus, menjadi terbuka, perineum menonjol dan tidak lama kemudian kepala janin tampak pada vulva.

3. Fisiologi Kala III

Dimulai segera setelah bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya.Biasanya plasenta lepas dalam 6 – 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri.Pengeluaran plasenta, disertai dengan pengeluaran darah. Komplikasi yang sering timbul pada kala III adalah perdarahan akibat atonia uteri, retensio plasenta, perlukaan jalan lahir, tanda gejala tali pusat (Sari dan Rimandini, 2014)

a. Tanda – Tanda Pelepasan Plasenta

1. Perubahan bentuk dan tinggi fundus

   Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya dibawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah pear atau alpukat dan fundus berada di atas pusat.

2. Tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva.

3. Semburan darah mendadak dan singkat.

   Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar di bantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah (retroplasental pooling) dalam ruang diantara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungannya maka darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Penyebab terpisahnya plasenta dari dinding uterus adalah kotraksi uterus (spontan atau dengan stimulus) setelah kala dua selesai.Berat plasenta mempermudah terlepasnya selaput ketuban,

yang terkelupas dan dikeluarkan.Tempat perlekatan plasenta menentukan kecepatan pemisahan dan metode ekspulsi plasenta.Selaput ketuban dikeluarkan dengan penonjolan bagian ibu atau bagian janin (Sari dan Rimandini, 2014).

4. Fisiologi Kala IV

Kala IV adalah kala pengawasan dari 1-2 jam setelah bayi dan plasenta lahir.Hal – hal yang perlu diperhatikan adalah kontraksi uterus sampai uterus kembali dalam bentuk normal.Hal ini dapat dilakukan dengan rangsangan taktil (masase) untuk merangsang uterus berkontraksi baik dan kuat.Perlu juga dipastikan bahwa plasenta telah lahir lengkap dan tidak ada yang tersisa dalam uterus serta benar – benar dijamin tidak terjadi perdarahan lanjut (Walyani dan Th Endang, 2016).

Menurut Sari dan Rimandini (2014) setelah kelahiran plasenta, uterus dapat ditemukan ditengah-tengah abdomen kurang lebih dua pertiga sampai tiga perempat antara simpisis pubis dan umbilikus.Jika uterus ditemukan berada di atas umbilicus dan bergeser, paling umum ke kanan, cenderung menandakan kandung kemih penuh dan perlu dikosongkan. Perubahan fisiologi yang terjadi :

a. Tanda Vital

   Tekanan darah, nadi, dan pernapasan, harus menjadi stabil pada level pra-persalinan selama jam pertama pascapartus, pemantauan tekanan darah dan nadi yang rutin selama interval ini adalah satu sarana mendeteksi syok akibat kehilangan darah berlebihan.Suhu ibu berlanjut sedikit meningkat, tetapi biasanya dibawah 38°C.

b. Gemetar

   Umum bagi wanita mengalami tremor selama kala empat persalinan. Gemetar seperti itu dianggap normal jika tidak disertai demam lebih dari 38°C atau tanda-tanda infeksi lain. Respon ini dapat diakibatkan hilangnya ketegangan dan sejumlah energi saat melahirkan. Respon

fisiologis terhadap penurunan volume intra abdomen dan pergeseran hematologic juga memainkan peranan

c. Sistem Gatrointestinal

Mual dan muntah, jika ada selama persalinan, harus diatasi. Banyak ibu yang melaporkan haus dan lapar segera setelah melahirkan

d. Sistem Renal

Kandung kemih yang hipotonik disertai retensi urine dan pembesaran umum terjadi.Tekanan dan kompresi pada kandung kemih dan uretra selama persalinan adalah penyebabnya.Mempertahankan kandung kemih harus tetap kosong guna mencegah uterus berubah posisi dan atoni.Uterus yang berkontraksi dengan buruk meningkatkan perdarahan dan keparahan nyeri.

e. Evaluasi Uterus

Tindakan pertama bidan setelah kelahiran plasenta adalah mengevaluasi konsistensi uterus dan melakukan massase uterus sesuai kebutuhan untuk memperkuat kontraksi. Perlunya ketersediaan orang kedua untuk memantau konsistensi uterus dan aliran lochia serta membantu massase uterus. Jika ibu bermaksud menyusui dan menempatkan bayi pada dada dapat menstimulasi kontraksi uterus dan meningkatkan tonus yang kuat.Kebanyakan uterus yang sehat dapat berkontraksi dengan sendirinya.Uterus yang berkontraksi normal harus keras ketika disentuh.

f. Pemeriksaan Serviks

Vagina dan Perineum Untuk mengetahui apakah ada tidaknya robekan jalan lahir periksa daerah perineum, vagina dan vulva. Setelah bayi lahir, vagina akan mengalami peregangan, oleh kemungkinan edema dan lecet. Introitus vagina juga akan tampak terluka dan terbuka. Sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak dan mengalami lecet-lecet.Segera setelah kelahiran bayi, serviks dan vagina harus diperiksa secara menyeluruh untuk mencari ada tidaknya laserasi dan dilakukan perbaikan lewat pembedahan kalau diperlukan.Serviks, vagina dan perineum dapat diperiksa lebih mudah sebelum pelepasan plasenta

karena tidak ada perdarahan rahim yang mengaburkan pandangan. Setelah kelahiran plasenta, perhatian atau arahan harus ditujukan pada setiap perdarahan rahim yang mungkin berasal dari tempat implantasi plasenta

Menurut buku APN tahun 2012 laserasi dapat dikategorikan dalam :

1. Derajat I : mukosa vagina, komisura posterior dan kulit perineum, tidak perlu dijahit.
2. Derajat II : mukosa vagina, komisura posterior kulit perineum dan otot perineum.
3. Derajat III :mukosa vagina, komisura posterior kulit perineum, otot perineum dan otot sfingter ani rujuk segera.
4. Derajat IV :mukosa vagina, komisura posterior kulit perineum, otot perineum otot sfingter ani, dan dinding depan rectum rujuk segera.

Selama kala IV bidan harus meneruskan proses penatalaksanaan kebidanan yang telah mereka lakukan selama kala I, II, III untuk memastikan ibu tidak menemui masalah apapun. mereka mengumpulkan data, menginterpretasikan data, serta membuat rencana asuhan berdasarkan interpretasi mereka atas data tersebut. Kemudian mengevaluasi rencana asuhan dengan cara mengumpulkan data lebih banyak (Sari dan Rimandini, 2014).

Karena terjadi perubahan fisiologis, maka pemantauan dan penanganan yang dilakukan oleh bidan adalah:

a. Tanda Vital

   Pantau tanda vital ibu yang meliputi Tekanan Darah (TD), Nadi (Pols) dan Respiration Rate (RR) selama kala IV segera setelah plasenta lahir.Tanda tersebut dievaluasi setiap 15 menit sampai keadaan ibu stabil seperti sebelum melahirkan atau lebih sering jika terdapat indikasi. Jika TD rendah atau <90/60 mmHg, sedangkan denyut nadinya normal, maka tidak akan menjadi masalah. namun, jika TD <90/60 mmHg dan nadinya >100 x/i, ini mengidentifikasi adanya suatu masalah. bidan harus mengumpulkan data lain untuk

membuat diagnosis. Mungkin ibu sedang mengalami demam atau terlalu banyak mengeluarkan darah (Sari dan Rimandini, 2014).

b. Suhu

Pantau suhu ibu satu kali/jam.Suhu ibu dicek paling sedikit satu kali selama kala IV.Jika suhu meningkat pantau lebih sering. Suhu tubuh yang normal adalah <38℃.Jika suhunya >38℃, bidan harus mengumpulkan data-data lain untuk memungkinkan identifikasi masalah. Suhu yang tinggi tersebut mungkin disebabkan oleh dehidrasi (karena persalinan yang lama dan

tidak cukup minum) atau ada infeksi) (Sari dan Rimandini, 2014).

c. Tonus otot dan tinggi fundus uterus

Jika kontraksi tidak baik maka uterus teraba lembek, tinggi fundus uterus normal, sejajar pusat atau dibawah pusat. Jika uterus teraba lembek, lakukan masase uterus, bila perlu berikan injeksi oksitosin atau methergin.Lakukan masase uterus untuk memastikan uterus menjadi keras setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, dan setiap 30 menit dalam jam kedua kala IV (Sari dan Rimandini, 2014).

d. Perdarahan

Perdarahan yang normal setelah kelahiran selam 6 jam pertama mungkin hanya akan sebanyak satu pembalut perempuan per jam, atau seperti darah haid yang banyak. Jika perdarahan lebih banyak dari ini, ibu hendaknya diperiksa lebih sering dan penyebab-penyebab perdarahan berat harus diidentifikasi (Sari dan Rimandini, 2014).

e. Kandung Kemih

Kandung kemih harus dievalusi dan dikosongkan jika teraba penuh.Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya setiap kali diperlukan.Jika kandung kemih penuh dengan air seni, uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik (Sari dan Rimandini, 2014).

2.2.2. Asuhan Persalinan

Menurut Nurjasmi, dkk (2016) tatalaksana asuhan persalinan normal tergabung dalam 60 langkah APN yaitu :

a. Mengenali Tanda dan Gejala Kala II
    1. Mendengar dan melihat tanda kala II persalinan
        a. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran
        b. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningat pada rectum dan vagina
        c. Perineum tampak menonjol
        d. Vulva dan sfingter ani membuka

b. Menyiapkan Pertolongan Persalinan
    2. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menatalaksanaan komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi siapkan :
        a. Tempat datar, rata bersih, kering dan hangat
        b. 3 handuk/kain bersih dan kering (termasuk ganjal bahu bayi)
        c. Alat hisap lender
        d. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi

        Untuk ibu :

        a. Menggelar kain di perut bawah ibu
        b. Menyiapkan oksitosin 10 unit
        c. Alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set
    3. Pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan.
    4. Melepaskan dan menyiapkan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan tangan dengan tisu/handuk pribadi yang bersih dan kering.
    5. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam.
    6. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik (gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik).

c. Memastikan Pembukaan Lengkap dan Keadaan Janin

7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior (depan) ke posterior (belakang) menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT.

a. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang

b. Buang kapas atau kasa pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia.

c. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5% selanjutnya langkah ke 9. Pakai sarung tangan DTT/steril untuk melaksanakan langkah lanjutan.

8. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap.
    a. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap maka lakukan amniotomi.
9. Dekontaminasi sarung tangan (celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam klorin 0,5%, selama 10 menit). Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Tutup kembali partus set.
10. Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus mereda (relaksasi) untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal (120160 x/menit).
    a. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.
    b. Mendokumentasikan hasil-hasil periksa dalam, DJJ, semua temuan pemeriksaan dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf.

d. Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Membantu Proses Meneran

11. Beritahu pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik, kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
    a. Tunggu timbul kontraksi atau rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman penatalaksanaan fase aktif) dan dokementasikan semua temuan yang ada.

b. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar.

12. Meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman.
13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat.
    a. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif.
    b. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai.
    c. Bantu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihanya (kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama).
    d. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.
    e. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu.
    f. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai.
    g. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran >120 menit (2 jam) pada primigravida atau >60 menit (1 jam) pada multigravida.
14. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit.

e. Persiapan untuk Melahirkan

15. Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut bawah ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.
16. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu.
17. Buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan.
18. Pakai sarung tangan DTT/steril pada kedua tangan

f. Pertolongan untuk Melahirkan Bayi Lahirnya kepala

19. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal.
20. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat (ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi), segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Perhatikan!
    a. jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi
    b. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat di antara dua klem tersebut.
21. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Lahirnya Bahu
22. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan kearah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Lahirkan Badan dan Tungkai
23. Setelah bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi sebelah atas.
24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk)

g. Asuhan Bayi Baru Lahir

25. Lakukan penilaian (selintas) :
    a. Apakah bayi cukup bulan?
    b. Apakah bayi menangis kuat dan/atau bernafas tanpa kesulitan?

c. Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah "TIDAK" lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Bila semua jawaban adalah "YA", lanjut ke-26

26. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya (kecuali kedua tangan) tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman diperut bagian bawah ibu.
27. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir (hamil tunggal) dan bukan kehamilan ganda (gemeli)
28. Beritahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik
29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit (intramuskuler) di 1/3 distal lateral paha (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin)
30. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali kearah ibu, dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm dari klem pertama.

31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat
    a. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah di jepit (lindungi perut bayi), dan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut.
    b. Ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
    c. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan.
32. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu-bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puttingsusu atau areola mamae ibu.
    a. Selimuti ibu-bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi.

b. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
c. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara.
d. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu.

h. Manajemen Aktif Kala III Persalinan (MAK III)

33. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva
34. Letakkan satu tangan diatas kain pada perut bawah ibu (diatas simfisis), untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat.
35. Setelah uterus berkontraksi, teganggakan tali pusat kea rah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorso kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur diatas.
    a. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.

Mengeluarkan Plasenta

36. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat di lahirkan.
    a. Ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan (jangan ditarik secara kuat terutama jika uterus tak berkontraksi) sesuai dengan sumbu jalan lahir (ke arah bawah-sejajar lantai-atas).
    b. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta
    c. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat:
        1. Ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM.
        2. Lakukan kateterisasi (gunakan teknik aseptik) jika kandung kemih penuh.

3. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan
4. Ulangi tekanan dorso-kranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya.
5. Jika plasenta tak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan maka segera lakukan tindakan plasenta manual.

37. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan.
    a. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jarijari tangan atau klem ovum DTT/Steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal.

    Rangsangan Taktil (Masase) Uterus

38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)
    a. Lakukan tindakan yang diperlukan (kompresi bimanual internal, kompresi aorta abdominalis, tampon kondom-kateter) jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil/masase.

i. Menilai Perdarahan

39. Periksa kedua sisi plasenta (maternal-fetal) pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta kedalam kantung plastik atau tempat khusus.
40. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan.

j. Asuhan Pasca Persalinan

41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
42. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh lakukan kateterisasi.

k. Evaluasi

43. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5 %, bersihkan noda darah dan cairan tubuh, dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan, kemudian keringkan dengan handuk
44. Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
45. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik
46. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah
47. Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik (40-60 kali/menit).
    a. Jika bayi sulit bernafas, merintih, atau retraksi, resusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit.
    b. Jika bayi nafas terlalu cepat atau sesak nafas, segera rujuk ke Rumah Sakit (RS) Rujukan.
    c. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Lakukan kembali kontak kulit ibu-bayi dan hangatkan ibu-bayi dalam satu selimut.

l. Kebersihan dan Keamanan

48. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi.
49. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai
50. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
51. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkannya
52. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%
53. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit
54. Cuci ke dua tangan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering

55. Pakai sarung tangan bersih/DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi.
56. Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pastikan kondisi bayi baik, pernapasan normal, (40-60 kali/menit) dan temperatur stubuh normal (36,5-37,50C) setiap 15 menit
57. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan.
58. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
59. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tissue atau handuk pribadi yang bersih dan kering.

m. Dokumentasi

60. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa tanda vital dan asuhan kala IV persalinan.

Observasi Persalinan dengan Menggunakan Partograf

Menurut Kemenkes RI (2013) observasi persalinan dengan menggunkan partograf dimulai pada pembukaan 4 cm. kenudian, petugas harus mencatat kondisi ibu dan janin sebagai berikut :

a. Denyut jantung janin
b. Air ketuban
    1. U : selaput ketuban utuh
    2. J : air ketuban jernih
    3. M : bercampur meconium
    4. D : bercampur darah
    5. K : kering
c. Perubahan bentuk kepala janin (molase)
    1. 0 : sutura masih terpisah
    2. 1 : sutura menempel
    3. 2 : sutura tumpang tindih tapi masih bisa diperbaiki
    4. 3 : sutura tumpang tindih dan tidak bisa diperbaiki
d. Pembukaan serviks, dinilai tiap 4 jam dan ditandai dengan tanda silang

e. Penurunan kepala bayi, menggunakan sistem perlimaan, catat dengan tanda lingkaran (0). Pada posisi 0/5, sinsiput (S), atau paruh atas kepala berada di simfisis pubis.
f. Waktu, menyatakan berapa lama penanganan sejak pasien diterima
g. Jam, catat jam sesungguhnya
h. Kontraksi, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap ½ jam lakukan palpasi untuk hitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit dan lamanya. Lama kontraksi dibagi dalam hityungan detik :<20 detik, 20-40 detik, dan >40 detik.
i. Oksitosin, catat jumlah oksitosin pervolume cairan infus serta jumlah tetes permenit.
j. Obat yang diberikan
k. Nadi, setiap ½ jam sekali tandai dengan titik besar.
l. Tekanan darah, setiap 4 jam sekali tandai dengan anak panah
m. Suhu tubuh, setiap 4 jam sekali
n. Protein, aseton, volume urin, catat setiap ibu berkemih

2.3.Nifas

2.3.1. Konsep Dasar Masa Nifas

a. Perngertian Masa Nifas

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan (Kemenkes RI, 2015).

Masa Nifas atau puerperium adalah masa setelah partus selesai sampai pulihnya kembali alat-alat kandungan seperti sebelum hamil.Lamanya masa nifas ini yaitu kira-kira 6-8 minggu (Walyani dan Th Endang, 2015).

b. Fisiologi Masa Nifas

Menurut Kemenkes RI (2015), dalam masa nifas alat-alat genetalia interna maupun eksterna akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan semula

sebelum hamil. Perubahan alat-alat genital ini dalam keseluruhannya disebut involusio.

1. **Uterus**

   Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 30 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot – otot polos uterus.

Tebel 2. 8. TFU dan Berat Uterus Menurut Masa Involusi

Involusi Uteri	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus (kg)
Saat bayi baru lahir	**Setinggi pusat, 2 jari dibawah pusat**	**1000**
1 minggu postpartum	**Pertengahan pusat-simfisis**	**500**
2 minggu postpartum	**Tidak teraba diatas simfisis**	**350**
6 minggu postpartum	**Normal**	**50**
8 minggu postpartum	**Normal seperti sebelum hamil**	**30**

Sumber : Kemenkes RI, 2015

2. **Serviks**

   Setelah persalinan bentuk serviks agak menganga seperti corong berwarna merah kehitaman.Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. Setelah bayi lahir, tangan masih bisa masuk rongga rahim, setelah 2 jam dapat dilalui 2-3 jari dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 jari.

3. **Lochea**

   Lochea adalaah ekskresi cairan rahim selama masa nifas.Lochea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus. Pemeriksaan lochea meliputi perubahan warna dan bau karena lochea memiliki ciri khas :

bau amis atau khas darah dan adanya bau busuk menandakan adanya infeksi. Jumlah total pengeluaran seluruh periode lochea rata – rata ± 240-270 ml.

Tebel 2. 9. Perbedaan Masing-masing Lokhea

Lochea	Waktu	Warna	Ciri-ciri
Rubra/ Merah	**1-3 hari**	**Merah**	**Terdiri dar darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding Rahim, lemak bayi, lanugo, dan meconium**
Sanguinolenta	**4-7 hari**	**Merah kecoklatan dan berlendir**	**Sisa darah dan berlendir**
Serosa	**8-14 hari**	**Kuning kecoklatan**	**Mengadung serum, leukosit, dan robekan/laserasi plasenta**
Alba/putih	**>14 hari**	**Putih**	**Mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lender serviks, dan serabut jaringan yang mati**

Sumber : Kemenkes RI, 2015

4. Vulva, Vagina dan Perineum

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur – angsur akan muncul kembali sementara labia menjadi lebih menonjol. Himen tampak sebagai tonjolan kecil dan dalam proses pembentukan berubah menjadi kurunkulae motiformis yang khas bagi wanita multipara. Perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju.Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada saat perineum mengalami robekan.Robekan jalan lahir dapat terjadi secara spontan ataupun dilakukan episiotomy dengan indikasi

tertentu.Pada postnatal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan. Ukuran vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama. Meskipun demikian, latihan otot perineum dapat mengembalikan tonus otot tersebut dan dapat mengencangkan vagina hingga tingkat tertentu.Hal ini dapat dilakukan pada akhir puerperium dengan latihan harian.

5. Sistem Pencernaan

Pasca melahirkan, kadar progesterone juga mulai menurun. Namun demikian fungsi usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal.Buang air besar secara spontan bisa tertunda selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini bisa disebabkan karena tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan pada awal masa pascapartum, diare sebelum persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang makan atau dehidrasi. Pada ibu yang mengalami episiotomi, laserasi dan hemoroid sering menduga nyeri saat defekasi sehingga ibu sering menunda untuk defekasi.Faktor tersebut mendukung konstipasi pada ibu nifas dalam minggu pertama.Suppositoria dibutuhkan untuk membantu eliminasi pada ibu nifas. Akan tetapi proses konstipasi juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu dan kekhawatiran lukanya akan terbuka bila ibu buang air besar

6. Sistem Perkemihan

Ibu postpartum dianjurkan segera buang air kecil, agar tidak mengganggu proses involusi uteri dan ibu merasa nyaman. Namun demikian, paska melahirkan ibu sulit merasa buang air kecil dikarena trauma yang terjadi pada uretra dan kandung kemih selama proses melahirkan, yakni sewaktu bayi melewati jalan lahir. Dinding kandung kemih dapat mengalami oedema.Kombinasi trauma akibat kelahiran, peningkatan kapasitas kandung kemih setelah bayi lahir, dan efek konduksi anestesi menyebab keinginan untuk berkemih menurun.Selain itu, rasa nyeri pada panggul yang timbul akibat dorongan saat melahirkan, laserasi vagina, atau episiotomi menurunkan atau mengubah reflex berkemih.Penurunan berkemih, seiring diuresis pascapartum bisa menyebabkan distensi kandung kemih.Distensi kandung

kemih yang muncul segera setelah wanita melahirkan dapat menyebabkan perdarahan berlebih karena keadaan ini bisa menghambatuterus berkontraksi dengan baik. Pada masa pasca partum tahap lanjut, distensi yang berlebihan ini dapat menyebabkan kandung kemih lebih peka terhadap infeksi sehingga menggangu proses berkemih normal. Apabila terjadi distensi berlebih pada kandung kemih dalam mengalami kerusakan lebih lanjut (atoni). Dengan mengosongkan kandung kemih secara adekuat, tonus kandung kemih biasanya akan pulih kembali dalam 5-7 hari setelah bayi lahir.

7. Tanda – tanda Vital

a. Suhu tubuh

Suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,20C.Pasca melahirkan, suhu tubuh dapat naik kurang lebih 0,50C dari keadaan normal.Kenaikan suhu badan ini akibat dari kerja keras sewaktu melahirkan, kehilangan cairan maupun kelelahan. Kurang lebih pada hari ke-4 postpartum, suhu badan akan naik lagi. Apabila kenaikan suhu tubuh diatas 38 ^{0}C, waspada terhadap infeksi postpartum.

b. Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80x/menit.Pasca melahirkan, denyut nadi dapat mejadi bradikardi maupun lebih cepat.Denyut nadi yang melebihi 100x/menit, harus waspada kemungkinan infeksi atau perdarahan postpartum.

c. Tekanan Darah

Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia.Tekanan darah normal manusia adalah sistolik antara 90120 mmHg dan diastolic 60-80 mmHg.Pasca melahirkan pada kasus normal, tekanan darah biasanya tidak berubah.Perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah pasca melahirkan dapat diakibatkan oleh perdarahan.Sedangkan tekanan darah tinggi pada postpartum merupakan tanda terjadinya preeklampsia postpartum.

d. Pernafasan

Frekuensi pernafasan normal pada orang dewasa adalah 1624x/menit.pada ibu postpartum umumnya pernafasan lambat atau normal.Hal ini dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat.Keadaan pernafsan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu dan nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas. Bila pernafasan pada masa postpartum menjadi lebih cepat, kemungkinan ada tanda – tanda syok

8. Proses Laktasi

Selama masa nifas payudara bagian alveolus mulai optimal memproduksi air susu (ASI). Dari alveolus ini ASI disalurkan ke dalam saluran kecil (duktulus), dimana beberapa saluran kecil bergabung membentuk saluran yang lebih besar (duktus).Di bawah areola, saluran yang besar ini mengalami pelebaran yang disebut sinus.Akhirnya semua saluran yang besar ini memusat ke dalam puting dan bermuara ke luar.Di dalam dinding alveolus maupun saluran, terdapat otot yang apabila berkontraksi dapat memompa ASI keluar.

Tebel 2. 10. Jenis-Jenis ASI

Jenis ASI	Ciri-ciri
Kolostrum	**Cairan pertama yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara pada hari 1-3, berwarna kuning keemasan, mengandung protein tinggi rendah laktosa**
Asi Transisi	**Keluar pada hari 3-8, jumlah ASI meningkat tetapi protein rendah dan lemak, hidrat arang tinggi**
Asi Matur	**ASI yang keluar hari ke 8-11 dan seterusnya, nutria terus berubah sampai bayi 6 bulan**

Sumber : Kemenkes RI, 2015

2.3.2. Asuhan Nifas

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya.Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas

dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi (Saifuddin, dkk, 2013).

Tebel 2. 11. Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
I	**6-8 jam setelah persalinan**	**1. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri** **2. Mendekati dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut** **3. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga, bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri** **4. Pemberian asi awal** **5. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir** **6. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah terjadi hipotermi**
II	**6 hari setelah persalinan**	**1. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi baik, tinggi fundus uteri dibawah pusat (umbilicus), tidak ada perdarahan, lochea tidak berbau** **2. Mendeteksi tanda – tanda : demam, perdarahan abnormal, sakit kepala hebat, dll** **3. Memastikan ibu mendapatkan asupan nutrisi, hidrasi dan istirahat yang cukup** **4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperihatkan tanda – tanda**

		penyulit **5. Memberikan konseling pada ibu memberikan asuhan pada talli pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari – hari**
III	**2 minggu setelah persalinan**	**Sama dengan tujuan kunjungan ke II**
IV	**6 minggu setelah persalinan**	**1. Menanyakan Pada Ibu, penyulit yang ia atau bayi alami** **2. Memberikan konseling KB secara dini**

Sumber : Walyani dan Th. Endang, 2015

a. Anamnesis

Tebel 2. 12. Anamnesis Pada Ibu Nifas

Riwayat Ibu	Riwayat Sosial Ekonomi	Riwayat Bayi
1. Nama, umur **2. Tanggal dan tempat lahir** **3. Penolong** **4. Jenis persalinan** **5. Masalah-masalah selama persalinan** **6. Nyeri** **7. Menyusui atau tidak** **8. Keluhan saat ini** **9. Rencana masa datang :kontrasepsi yang akan digunakan.**	**1. Respon ibu dan keluarga terhadap bayi** **2. Kehadiran anggota keluarga untuk membantu ibu dirumah** **3. Para pembuat keputusan dirumah** **4. Kebiasaan minum, merokok dan menggunakan obat** **5. Kepercayaan dan adat istiadat**	**1. Menyusu** **2. Keadaan tali pusat** **3. Vaksinasi** **4. Buang air kecil/besar**

Sumber :Saifuddin, dkk, 2013.

b. Pemeriksaan Kondisi Ibu

Tebel 2. 13. Pemeriksaan Pada Ibu Nifas Pada Ibu Nifas

Umum	Payudara	Perut/uterus	Vulva/perineum
1. Suhu tubuh **2. Denyut nadi** **3. Tekanan darah** **4. Tanda-tanda anemia** **5. Tanda-tanda edema/trombo flebitis** **6. Refleks** **7. Varices** **8. CVAT (cortical vertebral area tenderness)**	**1. Puting susu : pecah, pendek, rata** **2. Nyeri tekan** **3. Abses** **4. Pembengka kan** **5. Pengeluaran ASI**	**1. Tinggi fundus uteri** **2. Kontraks i uterus** **3. Kandung kemih**	**1. Pengeluaran lochia** **2. Luka episiotomy** **3. Pembengkakan** **4. Haemoroid**

Sumber : Saifuddin, dkk, 2013.

c. Penanganan

Tebel 2. 14. Tindakan yang baik untuk masa Nifas

Tindakan	Deskripsi dan Keterangan
Kebersihan diri	**1. Anjurkan kebersihan seluruh tubuh.** **2. Mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin.** **3. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut**

	setidaknya dua kali sehari.
Istrahat	**1. Anjurkan ibu untuk beristirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.** **2. Sarankan ia untuk kembali ke kegiatan-kegiatan rumah tangga biasa perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur.**
Gizi	Ibu menyusui harus: **a. mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari** **b. makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral dan vitamin yang cukup** **c. minum setidaknya 3 liter air setiap hari (anjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui)** **d. pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca bersalin** **e. minum kapsul vitamin A (200.000 unit) agar bisa memberikan vitamin A kepada bayi melalui ASInya.**
Perawatan Payudara	**1. menjaga payudara tetap bersih dan kering.** **2. Menggunakan BH yang menyokong payudara.** **3. Apabila puting susu lecet oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting setiap kali selesai menyusui.**
Hubungan Perkawinan	Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu atau dua jarinya kedalam vagina tanpa rasa nyeri.
Keluarga berencana	**1. Idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali.** **2. Meskipun beberapa metoda KB mengandung resiko, menggunakan kontrasepsi tetap lebih aman terutama apabila ibu sudah haid lagi.** **3. Sebelum menggunakan metode KB, hal-hal berikut sebaiknya dijelaskan dahulu kepada ibu:**

	a. Bagaimana metoda ini dapat mecegah kehamilan dan efektivitasnya **b. Kelebihan dan keuntungannya** **c. Kekurangannya** **d. Efek samping** **e. Bagaimana menggunakan metoda itu** **f. Kapan metoda itu dapat mulai digunakan untuk wanita pascasalin yang menyusui.**

Sumber : Saifuddin, dkk, 2013.

2.4. Bayi Baru Lahir

2.4.1. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir

a. Pengertian Bayi Baru Lahir

Menurut Saifuddin, bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir selama satu jam pertama kelahiran.

Menurut M. Sholeh Kosim, bayi baru lahir normal adalah berat bayi lahir antara 2500-4000 gram, cukup bulan, lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital (cacat bawaan) yang berat (Marmi dan Rahardjo, 2015).

b. Fisiologi Bayi Baru Lahir

Fisiologi neonatus adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan proses vital pada neonatus. Dibawah ini akan diuraikan beberapa fungsi dan proses vital neonatus.

1. Sistem Pernapasan

   Masa yang paling kritis pada bayi baru lahir adalah ketika harus mengatasi resistensi paru pada saat pernapasan yang pertama kali. Dan proses pernapasan ini bukanlah kejadian yang mendadak, tetapi telah dipersiapkan lama sejak intrauterin. Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta.Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paruparu bayi. Perkembangan sistem pulmoner terjadi sejak masa embrio, tepatnya pada umur kehamilan 24 hari dan pada umur kehamilan 34-36 minggu struktur peru-peru matang, artinya paru-paru sudah bisa mengembangkan sistem

alveoli. Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik pertama sesudah lahir. Saat kepala bayi melewati jalan lahir, ia akan mengalami penekanan yang tinggi pada toraksnya, dan tekanan ini akan hilang dengan tiba-tiba setelah bayi lahir. Proses mekanis ini menyebabkan cairan yang ada di dalam paru-paru hilang karena terdorong ke bagian perifer paru-paru untuk kemudian diabsorbsi. Karena terstimulus oleh sensor kimia, suhu, serta mekanis akhirnya bayi memulai aktivasi napas untuk yang pertama kalinya (Marmi dan Rahardjo, 2015).

2. Perubahan Peredaran Darah Neonatus

   Aliran darah dari plasenta berhenti pada saat tali pusat diklem.Tindakan ini menyebabkan suplai oksigen ke plasenta menjadi tidak ada dan menyebabkan serangkaian reaksi selanjutnya (Marmi dan Rahardjo, 2015).

   Sirkulasi janin memiliki karakteristik sirkulasi bertekanan rendah.Karena paru-paru adalah organ tertutup yang berisi cairan, maka paruparu memerlukan aliran darah yang minimal.Sebagian besar darah janin yang teroksigensi melalui paru-paru mengalir melalui lubang antara atrium kanan dan kiri yang disebut dengan foramen ovale. Darah yang kaya akan oksigen ini kemudian secara istimewa mengalir ke otak melalui duktus arteriosus (Marmi dan Rahardjo, 2015).

3. Karena tali pusat di klem, sistem bertekanan rendah yang berada pada unit janin plasenta terputus sehingga berubah menjadi sistem sirkulasi tertutup, bertekanan tinggi dan berdiri sendiri.

   Efek yang terjadi segera setelah tali pusat di klem adalah peningkatan tahanan pembuluh darah sistemik. Hal yang paling penting adalah peningkatan tahanan pembuluh darah dan tarikan napas pertama terjadi secara bersamaan. Oksigen dari napas pertama tersebut menyebabkan sistem pembuluh darah berelaksasi dan terbuka sehingga paru-paru menjadi sistem bertekanan rendah (Marmi dan Rahardjo, 2015).

   Kombinasi tekanan yang meningkat dalam sirkulasi sistemik dan menurun dalam sirkulasi paru menyebabkan perubahan tekanan aliran darah dalam jantung.Tekanan akibat peningkatan aliran darah di sisi kiri jantung menyebabkan foramen ovale menutup, duktus anteriorsus yang mengalirkan

darah teroksigenasi ke otak janin kini tak lagi diperlukan. Dalam 48 jam, duktus ini akan mengecil dan secara fungsional menutup akibat penurunan kadar prostaglandin E2, yang sebelumnya disuplai oleh plasenta. Darah teroksigenasi yang secararutin mengalir melalui duktus anteriorsus serta foramen ovale melengkapi perubahan radikal pada anatomi dan fisiologi jantung. Darah yang tidak kaya akan oksigen masuk ke jantung bayi menjadi teroksigenasi sepenuhnya di dalam paru, kemudian dipompakan ke seluruh bagian tubuh (Marmi dan Rahardjo, 2015).

2.4.2. Asuhan Bayi Baru Lahir

Menurut Patricia, bayi baru lahir juga membutuhkan perawatan yang dapat meningkatkan kesempatan menjalani masa transisi dnegan berhasil. Tujuan asuhan kebidanan yang lebih luas selama masa ini adalah memberikan perawatan komprehensif kepada bayi baru lahir pada saat ia dalam ruang rawat, untuk mengajarkan orang tua bagaimana merawat bayi mereka dan untuk memberi motivasi terhadap upaya pasangan menjadi orang tua, sehingga orang tua percaya diri dan mantap (Marmi dan Rahardjo, 2015).

a. Asuhan Bayi Segera Lahir

Asuhan segera bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran. Aspek-aspek penting asuhan segera bayi baru lahir :

1. Memantau pernafasan dan warna kulit bayi setiap 5 menit sekali (Marmi dan Rahardjo, 2015).

   Evaluasi nilai APGAR, yaitu Apperance (Warna kulit), Pulse (denyut nadi), Grimace (respon refleks), Activity (tonus otot) dan Respiratory (pernafasan) dilakukan mulai dari menit pertama sampai 5 menit.Hasil pengamatan masing-masing aspek dituliskan dalam skala skor 0-2.

Tabel 3. 1 Penilaian Bayi dengan Metode APGAR

Aspek Pengamatan	Skor

Bayi Baru Lahir	0	1	2
Appearance/warna kulit	**Seluruh tubuh bayi berwarna kebiruan**	**Warna kulit tubuh normal, tetapi tangan dan kaki berwarna kebiruan**	**Warna kulit seluruh tubuh normal**
Pulse/denyut nadi	**Denyut nadi tidak ada**	**Denyut nadi , 100 kali/menit**	**Denyut nadi > 100 kali/menit**
Grimace/ respon reflex	**Tidak ada respon terhadap stimulasi**	**Wajah meringis saat distimulasi**	**Menangis,menarik, batuk atau bersin saat distimulasi**
Activity/ tonus otot	**Lemah, tidak ada gerakan**	**Lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerakan**	**Bergerak aktif dan spontan**
Respiratory/pernafasan	**Tidak bernafas, pernafasan lambat dan tidak teratur**	**Menangis lemah, terdengar seperti merintih**	**Menangis kuat, pernafasan baik dan teratur**

Sumber : Walyani, 2015.

2. Jaga agar bayi tetap kering dan hangat dengan cara ganti handuk atau kain yang basah dan bungkus bayi dengan selimut serta pastikan kepala bayi telah terlindung baik.
3. Memeriksa telapak kaki bayi setiap 15 menit:

a. Jika telapak bayi dingin periksa suhu aksila bayi.
b. Jika suhu kurang dari 36,5 derajat C segera hangatkan bayi.

4. Kontak dini dengan bayi Berikan bayi kepada ibunya secepat mungkin untuk :
   a. Kehangatan yaitu untuk mempertahankan panas.
   b. Untuk ikatan batin dan pemberian ASI.
      1. Jangan pisahkan ibu dengan bayi dan biarkan bayi bersama ibunya paling sedikit 1 jam setelah persalinan (Marmi dan Kukuh, 2016).
      2. Segera setelah bayi lahir dan tali pusat diikat, kenakan topi pada bayi dan bayi diletakkan secara tengkurap di dada ibu, kontaklangsung antara kulit dada bayi dan kulit dada ibu. Bayi akan merangkak mencari puting susu ibu dan menyusu (GAVI, 2015).
5. Perawatan Mata Obat mata eritromisin 0,5 % atau tetrasiklin 1% dianjurkan untuk pencegahan penyakit mata karena klamidia (penyakit menular seksual). Obat mata perlu dibrikan pada jam pertama setelah persalinan, yang lazim digunakan adalah larutan Perak Nitrat atau Neosporin dan langsung diteteskan pada mata bayi segera setelah bayi lahir. (Saifuddin, 2014).

b. Asuhan 24 Jam Bayi Baru Lahir Menurut Marmi dan Kukuh (2016) dalam waktu 24 jam, bila bayi tidak mengalami masalah apapun, berikanlah asuhan berikut :

1. Lanjutkan pengamatan pernafasan, warna dan aktifitas bayi.
2. Pertahankan suhu tubuh bayi
   a. Hindarkan memandikan bayi minimal 6 jam dan hanya setelah itu jika tidak terdapat masalah medis serta suhunya 36,5°C atau lebih.
   b. Bungkus bayi dengan kain yang kering/hangat.
   c. Kepala bayi harus tertutup.
3. Pemeriksaan fisik bayi Butir-butir penting pada saat memeriksa bayi baru lahir:
   a. Gunakan tempat yang hangat dan bersih.
   b. Cuci tangan sebelum dan sesudah memeriksa, gunakan sarung tangan dan bertindak lembut pada saat menangani bayi.

c. Lihat, dengar dan rasakan tiap-tiap daerah mulai dari kepala sampai jari-jari kaki.
d. Jika ada faktor resiko dan masalah minta bantuan lebih lanjut jika diperlukan.
e. Rekam hasil pengamatan.

4. Berikan vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K pada BBL.
5. Identifikasi bayi.
6. Perawatan lain :
   a. Lakukan perawatan tali pusat.
   b. Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi pulang ke rumah beri imunisai BCG, Polio Oral dan Hepatitis B.
   c. Ajarkan tanda-tanda bahaya bayi pada orang tua.
   d. Ajarkan pada orang tua cara merawat bayi.
   e. Beri ASI sesuai kebutuhan setiap 2-3 jam.
   f. Jaga keamanan bayi terhadap trauma dan penyakit atau infeksi.
   g. Ukur suhu tubuh bayi jika tampak sakit atau menyusui kurang baik.
   h. Penyuluhan sebelum bayi pulang.
      1. Perawatan tali pusat
      2. Pemberian ASI
      3. Jaga kehangatan bayi
      4. Tanda-tanda bahaya
      5. Imunisasi
      6. Perawatan harian atau rutin
      7. Pencegahan infeks

c. Asuhan 2-6 Hari Bayi Baru Lahir Pada hari ke 2-6 setelah persalinan ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada bayi, yaitu:
   1. Minum Berikan ASI sesering mungkin sesuai keinginan ibu (jika payudara penuh) dan tentu saja lebih berarti menyusui sesuai kehendak bayi atau kebutuhan bayi setip 2-3 jam (paling sedikit setiap 4 jam), bergantian pada payudara kiri dan kanan. Pemberian ASI saja cukup pada periode usia 0-6

bulan , kebutuhan gizi bayi baik kualitas dan kuantitas terpenuhi dari ASI saja tanpa makanan atau minuman lainnya. Pemberian makananlain akan mengganggu produksi ASI dan mengurangi kemampuan bayi menghisap.

2. Buang Air Besar Feses bayi di dua hari pertama setelah persalinan biasanya berbentuk seperti ter atau aspal lembek. Zat buangan ini berasal dari perncernaan bayi yang dibawa dari kandungan. Menurut Dr. Waldi Nurhamzah, SPA umumnya warna-warna feses bayi dapat dibedakan menjadi kuning, coklat, hijau, merah dan putih atau keabuan. Normal atau tidaknya sistem pencernaan bayi dapat dideteksi dari warna-warna feses tersebut.
    a. Feses kuning : normal (ASI penuh yaitu foremilk/ASI depan dan hindmilk/ASI belakang.
    b. Feses hijau : normal (tidak boleh terus-menerus karena bayi hanya mendapat foremilk saja).
    c. Feses merah : disebabkan adanya tetesan darah yang menyertai.
    d. Feses keabu-abuan : waspada (disebabkan gangguan pada hati)
3. Buang Air Kecil Bayi baru lahir cenderung sering BAK 7-10 x sehari.Jika urine pucat, kondisi ini menunjukkan masukan cairan yang cukup.
4. Tidur Dalam 2 minggu pertama setelah lahir, bayi normalnya sering tidur, bayi baru lahir sampai usia 3 bulan rata-rata tidur selama 16 jam sehari.
5. Kebersihan Kulit Muka, pantat dan tali pusat bayi perlu dibersihkan secara teratur.Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.
6. Keamanan Jangan sekali-sekali meninggalkan bayi tanpa ada yang menunggu. Hindari pemberian apapun ke mulut bayi selain ASI.

2.5.Keluarga Berencana

2.5.1. Konsep Dasar Keluarga Berencana

a. **Pengertian Keluarga Berencana**

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen dan upaya ini dapat

dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan (Proverawati, Islaely dan Aspuah, 2015).

b. **Fisiologi Keluarga Berencana**

Menurut Proverawati, Islaely dan Aspuah (2015) idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya dua tahun sebelum ibu hamil kembali.Setiap pasangan harus menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan tentang keluarganya. Biasanya ibu tidak akan menghasilkan telur (ovulasi) sebelum ia mendapatkan lagi haidnya selama meneteki (amenorhoe laktasi). Meskipun beberapa metode KB mengandung resiko, penggunaan kontrasepsi tetap lebih aman terutama bila ibu sudah haid lagi.

1. Metode Amenore Laktasi (MAL)

MAL adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya.Metode ini khusus digunakan untuk menunda kehamilan selama 6 bulan setelah melahirkan dengan memberikan ASI eksklusif. MAL dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi, apabila :

a. Menyusui secara penuh (full breast feeding), lebih efektif jika diberikan minimal 8 kali sehari.
b. Belum mendapat haid.
c. Umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerja MAL adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada masa laktasi/menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat (inhibitor). Hormon penghambat dapat mengurangi kadar estrogen, sehingga ovulasi tidak terjadi.

   MAL memiliki efektifitas sangat tinggi sekitar 98% apabila digunakan secara benar dan memenuhi persyaratan, yaitu digunakan selama enam bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapat haid pasca melahirkan dan menyusui secara eksklusif (Proverawati, Islaely dan Aspuah, 2015).

   Manfaat kontrasepsi MAL antara lain :

a. Efektifitas tinggi (98%) apabila digunakan selama enam bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapat haid dan menyusui eksklusif.
b. Dapat segera dimulai setelah melahirkan.
c. Tidak memerlukan prosedur khusus, alat maupun obat.
d. Tidak memerlukan pengawasan medis.
e. Tidak mengganggu senggama.
f. Mudah digunakan.
g. Tidak perlu biaya.
h. Tidak menimbulkan efek samping sistemik.
i. Tidak bertentangan dengan budaya maupun agama.

MAL mempunyai keterbatasan antara lain:

a. Memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan.
b. Metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan, belum mendapat haid dan menyusui secara eksklusif.
c. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk Hepatitis dan HIV.
d. Tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui.
e. Kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif (Proverawati, Islaely dan Aspuah, 2015).

2. Kontrasepsi Pil

a. Kontrasepsi Pil Kombinasi

Kontrasepsi pil kombinasi adalah pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan dosis tertentu.Mekanisme utama pil kombinasi untuk mencegah terjadinya kehamilan adalah dengan menghambat keluarnya sel telur (ovum) dari indung telur (ovarium).Dengan penggunaan yang benar, hanya terjadi kurang dari 1 kehamilan per 100 perempuan atau 3 kehamilan per 1000 perempuan. Kontrasepsi pil kombinasi tidak akan mengganggu kembalinya kesuburan karena apabila dihentikan, kehamilan dapat terjadi pada bulan berikutnya (kecuali bila ditemukan gangguan lainnya). Penggunaan kontrasepsi pil kombinasi tidak dapat mencegah terjadinya infeksi menular seksual (IMS) pada penggunanya.

Efek samping yang sering terjadi :

1. Amenore (tidak haid).
2. Mual, pusing atau muntah.
3. Perdarahan pervaginam/spotting.

Keadaan yang perlu mendapat perhatian :

1. Nyeri dada hebat, batuk dan napas pendek.
2. Sakit kepala hebat.
3. Nyeri tungkai hebat (betis atau paha).
4. Nyeri abdomen hebat.
5. Pandangan kabur

b. Kontrasepsi pil progestin

Kontrasepsi pil progestin atau minipil adalah pil yang mengandung progestin dalam dosis yang sangat rendah. Mekanisme kontrasepsi pil progestin terjadi melalui penebalan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma melalui kanalis servikalis, menghambat lonjakan tengah siklus hormon luteal (LH) dan folikel stimulating hormon (FSH), inhibisi perjalanan ovum di saluran tuba, mengganggu pematangan endometrium dan supressi ovulasi (hanya terjadi pada 50% dari keseluruhan pengguna). Dengan penggunaan yang benar, efektifitas kontrasepsi pil progestin adalah 99,95% atau angka kegagalan hanya 0,5%. Tetapi dengan adanya keterlambatan jeda minum obat maka angka kegagalannya mencapai 5%.

Efek samping penggunaan pil progestin diantaranya :

a. Gangguan frekuensi dan lamanya haid.
b. Sefalgia

3. Kontrasepsi Suntik

a. Kontrasepsi suntik kombinasi

Kontrasepsi suntik kombinasi terdiri dari dua hormon yaitu progestin dan estrogen seperti hormon alami pada tubuh seorang perempuan. Suntikan kombinasi dipasarkan dengan nama dagang Ciclofem, Ciclofeminia, Cyclofem, Cyclo-povera, dan lain-lain. Efektifitas kontrasepsi suntik kombinasi:

1. Sangat efektif (0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan) selama tahun pertama penggunaan.
2. Risiko kehamilan lebih besar jika perempuan terlambat disuntik atau terlewatkan satu atau beberapa kali suntikan.

Efek samping dan masalah :

1. Amenore.
2. Mual, pusing dan muntah.
3. Perdarahan pervaginam/spotting

Tanda-tanda yang harus diwaspadai pada pengguna suntikan kombinasi:

1. Nyeri dada hebat atau nafas pendek.
2. Sakit kepala hebat atau gangguan penglihatan.
3. Nyeri tungkai hebat. Tidak terjadi perdarahan atau spotting selama 7 hari sebelum suntikan berikutnya, kemungkinan terjadi kehamilan.

b. Kontrasepsi Suntik Progestin

Kontrasepsi suntik progestin yang umum digunakan adalah Depo Medroxyprogesteron acetate (DMPA) dan Norethisteron Enanthate (Net-En). Kontrasepsi progestin, tidak mengandung estrogen sehingga dapat digunakan pada masa laktasi dan perempuan yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen.Suntikan progestin memiliki efektifitas yang tinggi (3 kehamilan per 1000 perempuan) pada tahun pertama penggunaan, asal penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yaitu setiap 12 minggu.

Efek samping:

1. Amenore.
2. Perdarahan ireguler.
3. Kenaikan berat badan.
4. Perut kembung dan tidak nyaman.
5. Perdarahan banyak atau berkepanjangan.
6. Sefalgia.

4. Kontrasepsi Implan

Implan mengandung hormon progestin.Progestin ditempatkan didalam kapsul implan satu atau dua batang yang dipasang pada lapisan bawah kulit dibagian medial lengan atas dengan jangka 3 tahun. Waktu mulai menggunakan implant:

a. Implan dapat diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid. Tidak diperlukan kontrasepsi tambahan.
b. Bila implan diberikan setelah hari ke 7 siklus haid, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari.
c. Bila klien tidak mendapat haid, implan dapat diberikan setiap saat, asal saja dapat dipastikan klien tidak hamil. Klien tidak boleh melakukan hubungan seksual untuk 7 hari lamanya atau menggunakan metode kontrasepsi lain selama 7 hari.
d. Bila klien pasca persalinan 6 minggu – 6 bulan, menyusui, serta belum haid, implan dapat diberikan, asal dapat dipastikan klien tidak hamil.
e. Bila pasca persalinan > 6 minggu dan telah mendapat haid, maka implan dapat dipasang setiap saat, tetapi jangan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari.

Efek samping atau masalah yang ditemukan :

a. Amenore.
b. Ekspulsi.
c. Perdarahan pervaginam/spotting.
d. Infeksi pada daerah insersi.
e. Berat badan naik/turun

5. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Menurut Nurjasmi (2016) AKDR merupakan salah satu metode jangka panjang yang cukup efektif karena hanya terjadi kurang dari 1 kehamilan diantara 100 pengguna AKDR di tahun pertama memakai AKDR. AKDR post partum adalah AKDR yang dipasang pada saat 10 menit setelah plasenta lahir hingga 48 jam post partum. Perdarahan haid yang lebih lama serta nyeri dibawah perut merupakan efek samping utama dalam waktu 3-6 bulan penggunaan.

Cara kerja dari alat kontrasepsi AKDR adalah sebagai berikut :

a. Menghambat kemampuan sperma masuk ke tuba fallopi.

b. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri.
c. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi.
d. Memungkinkan untuk mencegah implantasi.

6. Kontrasepsi Mantap
   a. Tubektomi

      Tubektomi adalah tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapat keturunan lagi. Jenis kontrasepsi ini bersifat permanen, karena dilakukan penyumbatan pada saluran telur wanita yang dilakukan dengan cara diikat, dipotong ataupun dibakar.

      Keuntungan dari kontrasepsi tubektomi adalah :

      1. Penggunaannya sangat efektif, yaitu 0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan.
      2. Tidak mempengaruhi terhadap proses menyusui (breast feeding).
      3. Tidak bergantung pada faktor senggama.
      4. Baik bagi klien bila kehamilan akan menjadi resiko kehamilan yang serius.
      5. Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anastesi lokal.
      6. Tidak ada efek samping dalam jangka waktu yang panjang.

      Namun, metode tubektomi ini juga memiliki keterbatasanketerbatasan yang harus diperhatikan, yaitu :

      1. Harus dipertimbangkan sifat mantap metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali), kecuali dengan rekanalisasi.
      2. Klien dapat menyesal di kemudian hari.
      3. Resiko komplikasi kecil, namun dapat meningkat apabila menggunakan anastesi umum.
      4. Rasa sakit atau ketidaknyamanan muncul dalam waktu pendek setelah tindakan.
      5. Dilakukan oleh dokter terlatih, yaitu dokter spesialis ginekologi untuk proses laparoskopi.
      6. Tidak melindungi diri dari IMS.

b. Vasektomi

Vasektomi adalah metode sterilisasi dengan cara mengikat saluran sperma (vas deferens) pria. Beberapa alternatif untuk mengikat salauran sperma tersebut, yaitu dengan mengikat saja, memasang klip tantalum, kauterisasi, menyuntikkan sclerotizing agent, menutup saluran dengan jarum dan kombinasinya (Proverawati, Islaely dan Aspuah, 2015).Angka keberhasilan vasektomi adalah sekitar 99%.Tetapi untuk dapat memastikan keberhasilan tersebut, sebaiknya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan vasektomi maka diadakan pemeriksaan analisa sperma. Vasektomi akan dikatakan berhasil manakala hasil pemeriksaannya adalah azoospermia (Proverawati, Islaely dan Aspuah, 2015).

2.5.2. Asuhan Keluarga Berencana

Menurut Arum dan Sujiyatini (2016) tindakan konseling hendaknya diterapkan 6 langkah yang dikenal dengan kata SATU TUJU yaitu:

SA : Sapa dan Salam kepada klien secara terbuka dan sopan

T :Tanyakan pada klien informasi tentang dirinya

U : Uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu beberapa jenis kontrasepsi yang paling mungkin.

TU : BanTUlah klien menentukan pilihannya

J : Jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya.

U : perlunya dilakukan kunjungan Ulang.

BAB III

TUJUAN KASUS

3.1. KEHAMILAN

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL NY. C DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

1. PENGUMPULAN DATA

A. Identitas/Biodata

Nama	**: Ny. C**	**Nama suami**	**: Tn. Z**
Umur	**: 22 Tahun**	**Umur**	**: 22 Tahun**
Agama	**: Islam**	**Agama**	**: Islam**
Pendidikan	**: S1**	**Pendidikan**	**: S1**
Pekerjaan	**: IRT**	**Pekerjaan**	**: Wiraswasta**
Alamat rumah	**: Deli Tua**		

B. Anamnese(Data Subjektif)

Pada tanggal : 20 November 2024 Pukul : 08:00 wib

1. Alasan kunjungan saat ini : Ketiga

2. Keluhan-keluhan : Tidak ada

3. Riwayat menstruasi :

- **Haid pertama : Umur 12 Tahun**
- **Siklus : 28 Hari**
- **Banyaknya : 3 kali ganti doek**
- **Dismenorrhe : Ya**
- **Teratur/Tidak teratur : Teratur**
- **Lamanya : 6 Hari**
- **Sifat darah : Encer**

4. Riwayat kehamilan,persalinan dan nifas yang lalu :

No	Usia kehamilan	Jenis kehamilan	Tempat persalinana	Komplikasi		Penolong	BBL		Nifas	
				Ibu	Bayi		BBLahir	Keadaan	laktasi	kelainan
1	H	A	M	I	L		I	N	I	

Riwayat kehamilan ini :

- **Hari Pertama Haid Trakhir : 17-02-2024**
- **TTP : 20-11-2024**
- **Keluhan pada**
  - **Trimester I : Tidak Ada**
  - **Trismester II : Pusing**
  - **Trismester III : Sering buang air keci**
- **Pergerakan anak pertama sekali : Baik**
- **Pengerakan anak 24 jam terakhir : 10-20 Kali**
  - **Bila lebih dari 20x dalam 24 Jam, dengan frekuensi : >15 detik**
- **Keluhan yang dirasakan (bila ada jelaskan) :**
  - **Rasa lelah : Ada**
  - **Mual muntah yang lama : Tidak Ada**
  - **Nyeri perut : Tidak Ada**
  - **Panas menggigil : Tidak Ada**
  - **Sakit kepala berat/terus meneru : Tidak Ada**
  - **Penglihatan kabur : Tidak Ada**
  - **Rasa nyeri/panas waktu BAK : Tidak Ada**
  - **Rasa gatal pada vulva,vagina : Tidak Ada**
  - **Pengeluaran cairan pervaginam : Tidak Ada**
  - **Nyeri,kemerahan : Tidak Ada**
  - **Oedema, tegang pada tungkai : Tidak Ada**
  - **Lain-lain (jelaskan) : Tidak ada**
- **Obat-obat yang di konsumsi :**

- **Trimester I : Fe, Prenatal**
- **Trismester II : Fe(1x1),Prenatal**
- **Trismester III : B12 (3x1)**
- **Kekhawatiran khusus : Tidak ada**

- **Pola eliminasi :**
  - **BAK :**
    - **frekuensi : 2x3 kali/hari**
    - **warna : jernih**
    - **Keluhan BAK : Tidak Ada**
  - **BAB :**
    - **frekuensi : 2 kali/hari**
    - **warna : kuning**
    - **konsistensi : lunak**
    - **Keluhan BAB : Tidak Ada**
- **Pola aktivitas sehari-hari**
  - **Pola istrihat dan tidur :**
    - **Siang : ±3 jam**
    - **Malam : ±8 Jam**
  - **Seksual : 2-3 minggu**
- **Immunisasi TT1 tanggal : 12-02-2024**
- **TT2 tanggal : 08-02-2024**
- **Konstrasepsi yang pernah digunakan : Tidak Ada**

5. Riwayat penyakit sistemik yang pernah diderita : Tidak Ada

Jantung : Tidak Ada

Asma : Tidak Ada

Hepatitis : Tidak Ada

Ginjal : Tidak Ada

Hipertensi : Tidak Ada

Epilepsi : Tidak Ada

Lain-lai : Tidak Ada

6. Riwayat penyakit pada keluarga :

Jantung : Tidak Ada

Hipertensi : Tidak Ada

DM : Tidak ada

Gamely : Tidak Ada

Lain-lain : Tidak Ada

7. Riwayat ekonomi

- **Status perkawinan : Sah**
- **Respon ibu dan keluarga kehamilan : Direncanakan**
- **Dukungan suami/keluarga terhadap kehamilan : Ada dukungan**
- **Pengambil keputusan dalam keluarga : Suami**
- **Pola makan dan minum :**
  - **Makan sehari-hari : 3 kali/hari,**
  - **Frekuensi :1piring,1mangkuk,½susu(100 cc)**
  - **Jenis makanan yang di makan : Nasi, Lauk, Sayur, Buah-buahan**
  - **Perubahan di makan yang di alami (ngidam,nafsu makan, dll) :**
    - **Minum : 6 gelas/perhari**
    - **Kebiasaan Merokok : Tidak pernah merokok**
    - **Minuman keras :Tidak pernah minum-minuman keras**
    - **Mengkomsumsi obat terlarang: Tidak pernah mengkomsumsi obat terlarang**
- **Kegiatan sehari-hari(bebas kerja) : Bekerja**
- **Tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan membantu persalinan : Puskesmas**

C. Pemeriksaan fisik (Data Objektif)

1. Status emosional : Compomentis

2. Pemeriksaan fisik :

BB : 67 Kg

TB : 159 Cm

Lila : 33 Cm,

BB sebelum nya : 55 Kg

3. **Tanda vital**

   TD : 120/90 mmHg

   Nadi : 81 x/menit

   Pernapasan : 22x/menit

   Temp : 36,5 ^c

4. **Kepala : Kulit kepala : Bersih**

   Distribusi Kepala : Merata

   Warna rambut : Hitam mengkilat

5. **Wajah : Tidak ada oedema**

   Gloasma gravidarum : Tidak ada Gloasma Gravidarium

   Pucat : Tidak Ada, Pucat pada wajah

6. **Mata : Conjungtiva : Merah**

   Sclera : Tidak Ikterus

7. **Hidung : polip : Tidak ada**

   Pengeluaran : Tidak ada

8. **Mulut : Lidah : Bersih**

   Stomatitis : Tidak ada, Stomatitis pada mulut

   Gigi : Tidak ada, karang gigi(caries)

   Berlobang : Tidak ada, gigi yang berlobang

   Epulis pada gusi : Tidak ada, epulis pada gusi

   Tonsil : Tidak Meradang, pada Tonsil

   Pharynx : Tidak meradang pada pharynx

9. **Telinga : Tidak ada serumen**

   Pengeluaran : Tidak ada

10. **Leher : Tidak ada bekas operasi**

    Kelenjar Thyroid : Tidak membesar kelenjar thyroid

    Pembuluh limfe : Tidak membesar pembuluh limfe

11. **Dada : Mamae : Simestri : ya simestri sebelah kiri**

    Areola mamae : Hitam kecoklatan

    Puting susu : Masuk Kedalam

Benjolan : Tidak ada benjolan

Pengeluaran dari puting susu : Tidak ada

12. Aksila : Pembesaran kelenjar getah bening : Tidak ada

13. Abdomen :

- **Pembesaran : Simestris**
- **Bentuk : Memanjang**
- **Linea : nigra**
- **Striae : Livide**
- **Bekas luka operasi : Tidak ada, Bekas luka operasi**
- **Pergerakan janin : Teraba, Gerakkan janin sangat baik**

Pemeriksaan Kebidanaan

- **Kontraksi : Tidak ada**
- **Tinggi Fundus : 33 Cm**

o **Palpasi**

❖ **Leopod I : TFU 33 Cm, Bagian Fundus lunak , Tidak ada lentingan**

❖ **Leopod II : Bagian kiri ibu, Teraba bagian keras memanjang**

❖ **Leopod III : Bagian Kanan bawah ibu,**
Teraba bulat dan lentingan

❖ **Leopod IV : Kepala belum masuk PAP**

o **Bagian janin yang terdapat di fundus uteri :**

o **Bagian tegang/memapan : Kiri**

o **Bagian kecil : Kanan**

o **Presentase : Kepala**

o **Penurunan bagian terbawah : Convergen (belum masuk PAP)**

o **Auskultasi : DJJ : 145 x/menit**

o **punctum maksimum : Pinggir kiri bawah pusat ibu**

o **Frekuensi : 3 x/menit, regular**

Pemeriksaan panggul luar :

- **Distancia Spinarum : 24 Cm Conjungtiva Ekstranal : 20 Cm**

- **Distancia Kristarum : 29 Cm Lingkar Panggul : 85 Cm**

14. Genatalia

– **Vulva :**

Pengeluaran : Tidak ada

Varices : Tidak ada,Varices pada genatalia

Kemerahan/lesi : Tidak ada

– **Perineum : Bekas luka/luka**

Perut : Tidak ada bekas luka pada perineum

– **Lain-lain : tidak ada**

15. Pinggang (periksa ketuk : Coste-Vertebre-Angel-Tendernes=CVAT)

Nyeri : Tidak ada Nyeri pada CVAT

16. Ekstremitas :

Oedem pada tangan/jari : Tidak ada

Oedem ekstrimitas bawah : Tidak ada

Varices : Tidak ada

Refleks patella : ada(+) sebelah kiri dan kanan

D. Pemeriksaan laboratorium

1. HB : 12 gr%

2. Protein urine : tidak ada

3. Glukosa urine : Tidak ada

4. Lain-lain : -

E. Pemeriksa penunjang

1. Usg : Ada

2. Rontrgen : Tidak ada

3. Lain-lain : -

3.1.1. CATATAN PERKEMBANGAN KEHAMILAN TM III

II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH DAN KEBUTUHAN

Ny.C berumur 22 Tahun,G1P0A0, kehamilan 38 minggu, Janin tunggal, Janin Hidup, Intrauterine, Letak Puka, Presentase kepala, Belum masuk PAP, Keadaan Ibu dan janin sangat baik.

Do : Ny. C berumur 22 tahun

Ds : Ibu mengatakan bernama Ny. C berusia 22 Tahun G1P0A0,

- **Ds : Ibu mengatakan ini kehamilan pertama**
  Ibu mengatakan belum pernah mengalami keguguran
  Ibu mengatakan keadaan ibu saat ini baik

- **Do :ibu mengatakan perut ibu tampak membesar**
  Ibu mengatakan areola mamae,
  puting susu hitam kecoklatan
  Ibu mengatakan perut ibu tampak terlihat

UK(usia kehamilan 38 minggu)

Ds : ibu mengatakan haid terakhir tanggal 20-02-2024
Ibu mengatakan pergerakkan Janin mulai dirasakan
Ibu mengatakan merasa mules dan ingin BAB

Do : di dapatkan usia kehamilan :

TK 20-11-2024
HPHT 17-02-2024

3 9 x 2 = 18 hari (18 hari + 3 hari) 28 hari = 2 minggu

9 x 4= 36 minggu (36 minggu +2 minggu) = 38 minggu

jadi UK(usia kehamilan ibu = 38 minggu)

Dilakukan Leopod I adalah TFU(Tinggi Fundus Uteri)= 38 Cm

Janin Tunggal

- **Ds : ibu mengatakan pergerakkan janin hidup**
  Ibu mengatakan pergerakkan janin tunggal
  Teraba satu bagian keras, bulat, bagian yang keras,
  mudah digoyangkan

❖ **Do : Punctum maksimun di atas pusat**

Janin Hidup

❖ **Ds : ibu mengatakan janin teraba aktif**

❖ **Do : DJJ 145x/menit, Pembesaran uterus sesuai Usia kehamilan**

Intra Uterine

❖ **Ds : Ibu mengatakan tidak pernah nyeri pada saat hamil**

❖ **Do : Terlihat Ekspresi wajah ibu di lakukan palpasi abdomen**

Presentase Kepala

❖ **Ds : ibu mengatakan pergerakan janin kuat**

❖ **Do : Ibu mengatakan sering BAK**

Letak Puka

❖ **Ds : Leopod II : terdapat punggung kanan**
Leopod III : Teraba dibagian bawah janin

❖ **Do : DJJ 146x/menit terdengar jelas dan teratur pada abdomen sebelah kanan bawah perut ibu**

Belum Masuk PAP

❖ **Ds : Kepala masih bisa di goyangkan pada leopod III**

❖ **Do : Leopod IV teraba kepala belum masuk PAP,**
dan Convergen,
Teraba Keras dan bulat pada bagian simpisis Ibu.

Keadaan ibu dan janin baik

❖ **Ds : Ibu mengatakan tidak ada masalah dengan kehamilan**
Ibu mengatakan bahagia dengan kehamilan

❖ **Do : TTV Batas normal,DJJ normal, Pergerakkan janin aktif.**

❖ **Masalah : Tidak Ada**

❖ **Kebutuhan : -Penkes mengenai ketidaknyamanan pada trisemester III**

-Penkes tentang tanda-tanda persalinan

-Mobilisasi, Perawatan Payudara, dan Personal Hygiene

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL :

" Tidak Ada"

IV. TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI :

" Tidak Ada"

V. PERENCANAAN

1) **Beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan bahwa ibu dalam keadaan baik.**
2) **Beritahu pada ibu pemeriksaan bahwa kehamilannya, dalam keadaan baik.**
3) **Anjurkan ibu untuk banyak istrihat dan mengurangi aktivitas**
4) **Beritahu ibu tentang tanda bahaya kehamilan.**
5) **Beritahu ibu untuk mengnyiapkan persalinan dan tanda-tanda persalinan : seperti : buang air kecil (BAK), dan lender darah, menganjurkan ibu untuk segera ke Puskesmas.**
6) **Beritahu ibu untuk meminum Fe, Lacta, B12**
7) **Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang dan sewaktu-waktu apabila ada keluhan**
8) **Anjurkan dan jelaskan kepada untuk menggunakan KB dan ASI Ekslutif.**

VI. PELAKSANAAN

1) **Memberitahu kepada ibu tentang hasil pemeriksaan ibu dalam keadaan baik.**

2) **Memberitahu kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bahwa kehamilannya dalam keadaan baik, posisi ibu keadaan sudah membaik.**
3) **Beritahu kepada ibu keadaan ibu untuk mengatur pola nutrisi ibu. Seperti : memperbanyak makan-makanan sayur-sayuran, buah-buahan.**
4) **Memberitahu kepada ibu tanda-tanda bahaya kehamilan : - perdarahan pada jalan lahir, pengeluaran bau busuk, bengkak pada kaki, tekanan darah semakin tinggi, nyeri kepala, serta beritahu kepada ibu untuk segera periksa ke Puskesmas atau ke Rumah sakit.**
5) **Memberitahu ibu tentang mengnyiapkan persalinan, dan tanda-tanda persalinan : - ibu sering BAK, mengluarkan darah, dan memberitahu kepada ibu segera ke tempat persalinan dan menyiapkan pakaian bayi, uang, persiapan fisik dan mental ibu, pendamping ibu pada saat persalinan.**
6) **Memberitahu kepada ibu mengkomsumsi : Fe,Lacta, B12 pada pagi hari. Dan beritahu kepada ibu jangan mengkomsumsi : Kopi, dan minum-minum bersoda.**
7) **Menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang, kemudian dan sewaktu-waktu terdapat ada keluhan.**

VII. EVALUASI

1) **Ibu mengetahui kondisi ibu saat ini baik, terdapat**

TD : 120/90 mmHg

HR : 81x/menit

RR : 22x/menit

Temp : 36,5

2) **Ibu mengetahui kehamilan ibu dalam keadaan baik,**

DJJ : 145x/menit, pergerakan janin aktif

3) **Ibu bersedia untuk istirahat yang cukup**
4) **Ibu mengetahui tanda bahaya kehamilan**
5) **Ibu sudah mempersiapkan persalinan dan bersedia datang kembali**

6) **Ibu sudah mendapat tablet Fe(1x1), bioman(1x1),Lacta(1x1) dan ibu mengetahui dosis obat dan cara meminumnya**
7) **Ibu bersedia kunjungan ulang, kemudian dan sewaktu-waktu terdapat ada keluhan.**
8) **Anjurkan kepada ibu setelah melahirkan, menggunakan alat konstrasepsi KB dan ibu anjurkan ibu memberi ASI ke Bayinya minimal 0-6 bulan.**

3.1.2. CATATAN PERKEMBANGAN KEHAMILAN TM-III

Tanggal : 20-11-2024 Pukul : 08.00 wib

Ny. C G1P20A0 usia : 22 Tahun, usia kehamilan : 38 minggu, puka, presentase kepala, intra uteri, janin tunggal, janin hidup, belum masuk PAP

S : subjek

Ny. C Umur : 22 Tahun pemeriksaan kehamilan tanggal 20 November2024 Dengan keluhan sering merasa lelah. Diketahui HPHT : 17 -02-2024

O : Objektif

K/U ibu baik, Kesadaran : Cm

Pemeriksaan TTV

TD :120/ 90 mmHg HR : 81 x/ menit

RR : 22 x/ menit T : $36,5^0$ C

Pemeriksaan fisik

- **Leopold I : TFU 33 cm**
- **Leopold II : Teraba pada bagian kanan panjang memapan (punggung)**
- **Leopold III : Teraba keras, melenting, bulat pada bagian tebawah janin**
- **Leopold IV : Kepala masih dapat digoyangkan**

Pemriksaan auskultasi

DJJ : 145x / menit

Pemeriksaan laboratorium

HB : 12 gr %

A : (Asesment)

Ny. C berumur 22 Tahun,G1P0A0, kehamilan 38 minggu, Janin tunggal, Janin Hidup, Intrauterine, Letak Puka, Presentase kepala, Belum masuk PAP

P : (Planning)

1. Beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan bahwa ibu dalam keadaan baik.
2. Beritahu pada ibu pemeriksaan bahwa kehamilannya, dalam keadaan baik dan janin belum masuk ke panggul.
3. Menganjurkan ibu untuk banyak istrihat dan mengurangi aktivitas
4. Memberitahukan tanda persalinan yaitu :
   - Perut mules dan nyari yang menjalar kepinggang ke perut bagian bawah secara teratur dan semakin bertambah
   - Keluar lender bercampur darah dari jalan lahir
   - Keluar air ketuban dari jalan lahir
   - Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang apabila ada keluhan.

3.2. PERSALINAN

Manajemen asuhan kebidanan pada ibu bersalin di klinik kurnia kecamatan deli tua kabupaten deli serdang

I. PENGUMPULAN DATA

A. Identitas/ Biodata

Nama	: Ny. C	Nama suami	: Tn. M
Umur	: 22 tahun	Umur	: 22 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: S1	Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat rumah	: Deli Tua		

II. ANAMNESE (DATA SUBJEKTIF)

Pada tanggal : 20-11-2024 **Pukul :08.00 wib**

1. **Alasan kunjungan saat ini : Ibu mengatakan ingin bersalin**

   Keluhan utama : Ibu mengatakan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah

2. **Tanda-tanda bersalin**

   - **Kontraksi: Ada sejak tanggal: 20-10-2024 pukul: 06.00 wib**
   - **Frekuensi: 2x10 menit x 40 detik**

     Pengeluaran pervaginam
   - **Darah lendir : Ada**
   - **Air ketuban : Ada**
   - **Darah : Ada**

3. **Riwayat kehamilan sekarang**

   HPHT : 12-02-2024

   Haid bulan sebelumnya : Teratur

   Lamanya : 6 hari

   Siklus : 28 hari

ANC : Teratur frekuensi : - x/i

Keluhan/ penyulit pada kehamilan ini : Tidak ada

( ) anemia ( ) epilepsy

( ) PE ( ) jantung

( ) DM ( ) dll, sebutkan

4. Riwayat imunisasi : Sudah dilakukan imunisasi TT
5. Pergerakan janin dalam 24 jam terakhir : 15 x/i
6. Kesiapan menghadapi persalinan : Siap
7. Pendamping persalinan yang diinginkan : Suami
8. Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu

No	Tgl lahir/ Umur	Usia kehamilan	Jenis persali Nan	Tempat persalinan	Komplikasi		Penolong	BBL		Nifas	
					Ibu	bayi		BB lahir	Keadaan	laktasi	kelainan
1	H	A	M	I	L		I	N	I		

9. Makan dan minum terakhir pukul : 07.30 wib
   Jenis makanan : Nasi, ikan, 1 mangkuk sayur
10. Buang air besar terakhir : 1x
    Buang air kecil terakhir : 4x
11. Tidur : 6 jam

C. PEMERIKSAAN FISIK

1. **Penampilan fisik : Baik**
   Keadaan emosional : Stabil
2. **Tanda vital**
   TD : 120/90 mmHg
   RR : 22 x/ menit
   Pols : 81 x/ menit

Suhu : 36,5^{o}c

3. **Tinggi badan : 159 cm Berat badan : 67 kg**
4. **Muka : Tidak pucatKelopak mata :Tidak oedema**

   Konjungtiva : Merah muda

   Sklera : Tidak ikterus
5. **Mulut dan gigi : Bersih**

   Lidah dan gigi : bersih Caries : tidak ada

   Tonsil : tidak

   Pharing : tidak
6. **Leher : Tidak ada pembengkakan**

   Kelenjar tiroid : pembesaran kelenjar : tidak ada

   Kelenjar getah bening : pembesaran : tidak ada
7. **Dada : simetris**

   Jantung : Rhitme

   Paru : Normal

   Payudara : simetris

   Puting susu : menonjol

   Benjolan : tidak ada

   Pengeluaran : tidak ada

   Rasa nyeri : tidak ada

   Lain–lain : tidak ada
8. **Abdomen**

   Pembesaran : tidak

   Benjolan : tidak ada

   Bekas luka operasi : tidak ada

   Strie : albicans

   Linea : albican

   Pembesaran lien/liver : tidak ada

   Kandung kemih : kosong

Pemeriksaan kebidanan(Kala I)

Palpasi uterus : tidak ada

Tinggi fundus uteri : 38 cm

Kontraksi : ada/ tidak ada

Letak : memanjang/ melintang

Presentasi : kepala

Posisi : normal

Penurunan : 3/5

Pergerakan : ada/ tidak ada & aktif/ tidak aktif

Taksiran berat janin : 3300 gram

Auskultasi : ada

DJJ : ada

Frekuensi : 150x/ menit

Punctum maximum : kuadran kiri bawah pusat

9. **Anogenital (inspeksi)**

Perineum (luka parut) : tidak ada

Vulva vagina : Warna : Cokelat Luka : tidak

Fistula : tidak Varices : tidak

Pengeluaran pervaginam (Warna) : Merah kecoklatan Jumlah : -

Kelenjar bartholini : Pembengkakan : tidak

Konsistensi : lembek

Anus : haemoroid : tidak ada

Pemeriksaan dalam : Ada, pembukaan 6 cm

Dinding vagina : Baik

Portio : teraba

Posisi portio : antreflexi

Pembukaan serviks : 6 cm

Konsistensi : keras

Penurunan bagian terendah : Hodge : IV

Persentasi Fetus :(✓) UUK ki-dep ( ) UUK ka-dep

Spina ischiadica : tumpul

Promontorium : tidak teraba

Linea inominata : Tidak teraba

Arcus pubis : 90°

II. PENGKAJIAN KALA II, PUKUL :09.20 wib

A. ANAMNESE (SUBJEKTIF)

- Keinginan meneran : Ada

- Perasaan adanya tekanan pada anus/vagina : Ada

- Rasa nyeri : Ada

B. PEMERIKSAAN FISIK (OBJEKTIF)

1. Penampilan fisik : Baik

2. Keadaan emosional : Stabil

3. Tanda vital

- Tekanan darah : 120/90 mmHg
- Denyut nadi : 81x/ menit
- Pernafasan : 22x/ menit
- Suhu tubuh :36,5^{o}c

4. Pemeriksaan kebidanan

A. Abdomen

HIS	:Frekuensi	: 4x dalam 10 menit	Lamanya : 45 detik
DJJ	:Frekuensi	: 148x/ menit	reguler

B. Genital

- **Perineum : Menonjol**
- **vulva : Membuka**
- **Bagian janin : terlihat**

Menetap/ tidak, diameter : 6 cm

III. PENGKAJIAN KALA III PUKUL : 15.00 wib

A. ANAMNESE (SUBJEKTIF)

- **Keinginan meneran : Tidak ada**
- **Mules : Ada**
- **Keluhan lain jelaskan : Tidak ada**

B. PEMERIKSAAN FISIK(OBJEKTIF)

1. Penampilan fisik : Baik

2. Keadaan emosional : Stabil

3. Tanda vital

- Tekanan darah : 120/70 mmHg

- Denyut nadi : 83x/ menit

- Pernafasan : 23x/ menit

- Suhu tubuh : 36,8^{o}c

4. Pemeriksaan kebidanan

a. Abdomen

TFU : Setinggi pusat

Konsistensi : Keras

Kandung kemih : Kosong

b. Genital

Tali pusat : Memanjang

Pengeluaran dari vagina : Lokia

5. Pemeriksaan plasenta

- Permukaan maternal : Kotiledon utuh (20), kasar, merah tua

- Permukaan fetal : Selaput amnion, licin, warna keputihan

- Keutuhan selaput karion dan amnion : Utuh

- Diameter plasenta : 20 cm

6. Pengkajian tali pusat

a. Insersi tali pusat : Sentral

b. Panjang tali pusat : 50 cm

c. Konsistensi cairan wharton : -

IV. PENGKAJIAN KALA IV, PUKUL : 15.10 wib

A. ANAMNESE (SUBJEKTIF)

1. Perasaan : Baik

2. Keluhan fisik

Mules : **(✓)Ada** **( )Tidak ada**

Lelah : **( )Ada, jelaskan** **(✓)Tidak ada**

Kedinginan : **( )Ada, jelaskan** **(✓)Tidak ada**

Nyeri : **( )Ada, jelaskan** **(✓)Tidak ada**

Haus : **(✓)Ada** **( )Tidak ada**

Lapar : **( )Ada** **(✓)Tidak ada**

Lain lain,jelakan : **Tidak ada**

B. PEMERIKSAAN FISIK (OBJEKTIF)

1. Penampilan fisik : **Baik**

Pucat : **( )Ya** **(✓)Tidak**

Gelisah : **( )Ya** **(✓)Tidak**

Keringat : **(✓)Ya** **( )Tidak**

Gemetar : **( )Ya** **(✓)Tidak**

2. Keadaan emosional : **Stabil**

Nampak takut : **( )Ya** **(✓)Tidak**

Inkoheren : **( )Ya (✓)Tidak**

Lain lain,jelaskan : **Tidak ada**

3. Tanda vital

Tekanan darah : **120/70 mmHg**

Denyut nadi : **81x/ menit**

Pernafasan : **22x/ menit**

Suhu tubuh : 36,8^{o}c

4. Pemeriksaan kebidanan

A. Abdomen

TFU : **2 jari dibawah pusat**

Konsistensi uterus : **(✓)Keras** **( )Lembek**

(✓)bulat **( )Melebar**

Kandung kemih : **(✓)Kosong** **( )Penuh**

B. Genital

Luka jalan lahir : **Tidak ada**

Pengeluaran darah/vaginam : **- cc**

	Tanda	0	1	2	Jumlah nilai
Menit Ke-1	[ ] frekuensi jantung [ ] usaha bernafas [ ] tonus otot [ ] reflex [ ] warna	[ ] tidak ada [ ] tidak ada [ ] lumpuh [ ] tak bereaksi [ ]biru/pucat	[ ] <100 [ ]lambat tak beraturan [✓]ext.flexi sedikit [✓]gerakan sedikit [ ]tumbuh kemerahan lengan dan kaki	[✓]>100 [✓] menangis kuat [ ]gerakan aktif [ ]menangis [✓] kemerahan	8
Menit Ke-5	[ ] frekuensi jantung [ ] usaha bernfas [ ] tonus otot [ ] reflex [ ] warna	[ ] tidak ada [ ] tidak ada [ ] lumpuh [ ] tak bereaksi [ ] biru/ pucat	[ ] <100 [ ] lambat tak beraturan [ ] ext.flexi sedikit [ ] gerakan sedikit [ ] tumbuh kemerahan lengan dan kaki	[✓] >100 [✓] menangis kuat [✓] gerakan aktif [✓] menangis [✓] kemerahan	10

2. PB/ BB : 3300 gram/ 47 cm

3.2.1. CATATAN PERKEMBANGAN PERSALINAN

II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : Ibu G1P0A0, Usia kehamilan 38 minggu, Presentase kepala, Janin tunggal, intra uteri, punggung kiri, inpartu kala I fase aktif.

1. Ibu G1P0A0

DS : - Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama

- Ibu mengatakan sudah keluar tanda seperti lendir bercampur darah

DO : Dari hasil pemeriksaan ibu telah dilakukan palpasi abdomen/ leopold

2. Usia kehamilan 37 minggu 3 hari

DS : Ibu mengatakan Hari pertama haid terakhir (HPHT) 08-01-2024

DO : Tanggal kunjungan : 20-11-2024

Hari pertama haid terakhir : 17-02-2024

3 9x2 =18 hari +3

=28 hari (2minggu)

9x4 = 36 minggu + 2 minggu

= 38 minggu

Jadi usia kehamilan 38 minggu

TFU : 38 cm diatas simfisis

3. Presentase kepala

DS :Ibu mengatakan ada bagian yang menjanggal, bulat dan keras dibagian bawah

DO : Pada pemeriksaan leopold III terdapat bagian keras, bulat, dan melenting

4. Janin tunggal

DS : Ibu mengatakan bayinya bergerak dengan aktif disatu sisi saja

DO: Dari hasil pemeriksaan palpasi leopold II dan leopold III dibagian perut ibu masih terdapat daerah kosong dengan DJJ hanya terdengar sekali saja disatu sisi

5. Intra uteri

DS : Ibu mengatakan adanya dorongan dalam rahim

Do : Dari hasil pemeriksaan palpasi pada abdomen bahwa adanya perubahan

pada uterus ibu yaitu membersar

6. Pungung kiri

DS : Ibu mengatakan janinnya lebih aktif bergerak disebelah kanan

Do : Dari hasil pemeriksaan leopold II dibagian kiri terdapat bagian panjang, keras,dan memapan sedangkan sebelah kanan terdapat daerah yang kosong yaitu akremitas

7. Inpartu kala I

DS : Ibu mengatakan rasa nyeri terjadi dari simfisis menjalar kepinggang
Ibu mengatakan keluar tanda seperti lendir bercampur darah

Do : Dari hasil pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan dalam (VT) terjadi pembukaan 6 cm, His 3x dalam 10 menit

Masalah : Cemas menghadapi persalinan ini

Kebutuhan : -Support keluarga
-Posisi yang nyaman
-Mobilisasi

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

"Tidak ada"

IV. TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI

''Tidak ada"

V. PERENCANAAN

1. **Pantau tanda-tanda vital ibu dan janin**
2. **Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi**
3. **Beri dukungan pada ibu**
4. **Beritahu ibu posisi yang nyaman**
5. **Persiapan alat-alat persalinan**
6. **Persiapan perlengkapan bayi dan pakaian ibu**
7. **Persiapan fisik dan mental ibu untuk persalinan**
8. **Pantau kemajuan pembukaan serviks**

VI. PELAKSANAAN

1. **Memantau tanda-tanda vital ibu dan janin baik, dengan TD :120/70 mmHg, HR: 81x/ menit, RR : 22x/ menit, Temp : 36,5^{o}c dan DJJ :**

148x/ menit

2. **Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi seperti janin jalan-jalan, sering jongkok**
3. **Memberi dukungan pada ibu supaya ibu tetap semangat untuk menghadapi persalianan**
4. **Memberitahu ibu posisi yang nyaman dengan tekhnik kaki ditekuk atau posisi miring**
5. **Mempersiapkan alat-alat persalinan**

   Saf I

   a. **Partus Set : 2 arteri klem, 1 gunting tali pusat dan episiotomi, ½ Kocher, Kateter Nelaton, Umbilical klem, Sarung tangan 2 pasang, Kasa secukupnya**
   b. **Hecting Set : Nald holder, Gunting lurus, Pincet anatomi dan cirurgis**
   c. **Kom kapas sublimat**
   d. **Kom air DTT**
   e. **Kom pita metlin dan catgut**
   f. **Kom obat berisi : Oksitosin 6 ampul, Ergometrin 3 ampul, Lidocain 3 ampul dan Aquabides**
   g. **Kom obat berisi : Neo k, HB unijec, Sm tetrasiclyn 1%**
   h. **Stetoskop linex, spuit 10,5,3,1 cc**

   Saf II

   a. **Baki berisi : Tensi meter, Stetoskop, Termometer, Jam tangan detik**
   b. **Perlengkapan ibu : Baju ibu, Kain dan Pembalut, dan Pakain bayi**

   Saf III

   a. **Infus set : 3 botol cairan RL, Abocath, Set infus, Plester, Gunting, Torniquet**
   b. **Piring plasenta**
   c. **Bengkok 3 buah**
   d. **Tempat jarum bekas**

e. **Alat resusitasi bayi : kain pengganjal, kain alas, lampu sorot, sungkup, bola karet/ delee, kassa**

6. **Mempersiapkan perlengkapan bayi dan pakaian ibu seperti bedong bayi, gurita, baju, tali dua, topi, sarung tangan dan kaki, pakain ibu, sarung, dan duk/ pembalut**
7. **Mempersiapkan fisik dan mental ibu untuk persalinan agar persalinan berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan komplikasi**
8. **Memantau kemajuan pembukaan serviks dengan partograf dengan cara melakukan VT (Vaginal Toucher) dengan waktu 4 jam sekali**

VII. EVALUASI

1. **Ibu sudah tahu bahwa keadaannya dan janinnya baik**
2. **Ibu sudah melakukan mobilisasi seperti jalan-jalan, dan jongkok**
3. **Ibu merasa senang karena adanya dukungan dari orang-orang terdekatnya**
4. **Ibu sudah menerapkan posisi yang nyaman**
5. **Alat-alat persalinan sudah disiapkan**
6. **Perlengkapan bayi dan ibu sudah disiapkan**
7. **Ibu mengatakan siap untuk menghadapi persalinan**
8. **Pemantau pembukaan serviks telah didokumentasikan dalam pencatatan**

3.2.2. **Catatan Perkembangan Kala II**

I. PENGKAJIAN KALA II, Pukul : 11.00wib

A. Anamnese (Subjektif)

-Keinginan meneran : Ada

-Perasaan adanya tekanan pada anus/ vagina : Ada

-Rasa nyeri : Ada

B. Pemeriksaan Fisik (Objektif)

1. Penampilan fisik : Baik
2. Keadaan emosional : Stabil

3. Tanda vital

-Tekanan darah : 120/70 mmHg

-Denyut nadi : 81 x/ menit

-Pernafasan : 22 x/ menit

-Suhu tubuh : 36,7^{o}c

4. Pemeriksaan kebidanan

A. Abdomen

His : Frekuensi : 3x dalam 10 menit Lamanya : 30 detik

Djj : Frekuensi : 148 x/menit Reguler

B. Genital

-Perineum : Menonjol

-Vulva : Membuka

-Bagian janin : terlihat

Menetap diameter : 6 cm

II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : Ibu Inpartu kala II

DS : Ibu mengatakan ingin BAB, kontraksi yang adekuat dan teratur, keluarnya air ketuban dan perasaan ingin meneran

DO : Dari hasil pemeriksaan kepala bayi sudah tampak divulva dan terjadi kemajuan dalam persalinan

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : -Tekhnik meneran

- Posisi dalam persalinan

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

"Tidak Ada"

IV. TINDAKAN SEGERA

"Tidak Ada"

V. PERENCANAAN

1. **Informasikan kepada ibu tentang kemajuan persalinan**
2. **Atur posisi ibu untuk bersalin**
3. **Ajari ibu cara mengedan yang baik**

4. Lakukan langkah APN

VI. PELAKSANAAN

1. Menginformasikan pada ibu tentang kemajuan persalinan bahwa ibu akan segera melahirkan

2. Mengatur posisi ibu dengan posisi litotomi atau sesuai dengan keinginan ibu untuk memberi rasa nyaman pada ibu untuk memberi rasa nyaman pada ibu saat melahirkan

3. Mengajari ibu untuk mengedan panjang dan kuat pada saat his dan bernafas perlahan-lahan pada saat his tidak ada

4. Melakukan langkah APN

1. Tanda gejala kala II

-Doran (Dorongan ibu meneran)

-Teknus (Tekanan pada anus)

-Perjol (Perineum menonjol)

-Vulka (Vulva membuka)

2. Siap alat/ siapkan diri

-Celemek (Pakai alat APD)

-Cuci (Cuci tangan)

-Sarung (Pakai Handscoon)

-Oksi (Ambil spuit dan oksi)

3. Pastikan pembukaan lengkap

-Bersih (Vulva hygiene)

-PD (Pemeriksaan dalam)

-Celup (masukkan handscoon kelarutan klorin)

-Djj (Dengar djj)

4. Siap ibu dan keluarga

Beri tahu ibu bapak

5. Pimpinlah ibu untuk meneran

-2 : His (+) Pimpin dan puji

-3 : His (-) Istirahat, makan minum. Djj

-1 : Posisi

6. Siap-siap untuk menolong

-Handuk (letakkan handuk diperut ibu)

-Bokong (letakkan Underpet)

-Buka (pakai handscoon, buka bak instrumen)

-Sarung (buka sarung)

7. Tolong

Kepala (lindungi perineum, cek lilitan, tunggu putar paksi luar)

Bahu (berpegangan biparietal)

Badan (sanggah dan susuri dengan tekhnik polda)

8. Penanganan BBL

-2 : Nilai apgar score, letak diperut ibu

-3 : Keringkan bayi, jepit tali pusat, potong tali pusat

-2 : Ikat tali pusat dengan kasa steril, lakukan IMD

-2 : Cek janin kedua kalau tidak ada, lalu suntik oksitosin

9. Manajemen aktif kala III (ini materi utama)

-3 : PTT (pindah, posisi, tegang)

-2 : Plasenta (tarik, putar)

-1 : Masase (fundus)

10. Perdarahan periksa

Plasenta dan robekan

11. Pasca persalinan

-Letakkan handscoon kelarutan klorin

-Lakukan penimbangan, suntikan vit k dipaha kiri bayi

-Suntik Hepatitis B, lihat kontraksi, ajarkan ibu, cek perdarahan, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dan bayi

-Dekontaminasi alat, posisi ibu, celup dan cuci

12. Partograf

VII. EVALUASI

1. **Ibu sudah tahu keadaannya**
2. **Ibu sudah menerapkan posisi untuk bersalin**
3. **Ibu sudah tahu cara mengedan yang baik**
4. **Langkah APN telah dilakukan**

3.2.3. Catatan Perkembangan Kala III

I. PENGKAJIAN KALA III, Pukul : 15:00 wib

A. Anamnese (Subjektif)

-Keinginan meneran : Tidak ada

-Mules : Ada

-Keluhan lain jelaskan : Tidak ada

B. Pemeriksaan fisik (Objektif)

1. Penampilan fisik : Baik

2. Keadaan emosional ; Stabil

3. Tanda vital

-Tekanan darah : 120/70 mmHg

-Denyut nadi : 81x/ menit

-Pernafasan : 22x/ menit

-Suhu tubuh ; 36,0^{o}c

4. Pemeriksaan kebidanan

a. Abdomen

TFU : Setinggi pusat

Konsistensi : Keras

b. Genital

Tali pusat : Memanjang

Pengeluaran dari vagina : Lokia

5. Pemeriksaan plasenta

-Permukaan maternal : Kotiledon utuh (20), kasar, merah tua

-Permukaan fetal : Cairan amnion, licin, warna keputihan

-Keutuhan selaput korion dan amnion : Utuh

-Diameter plasenta : 20 cm

6. Pengkajian tali pusat

-Insersi tali pusat : Sentral

-Panjang tali pusat : 50 cm

-Konsistensi cairan wharton : -

II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA, MASALAH, DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : Inpartu kala III

DS : Ibu mengatakan bahagia karena bayinya telah lahir

Ibu mengatakan merasa lelah karena meneran

Ibu mengatakan perutnya masih mules

DO : Uterus teraba bulat dan keras

Kontraksi pada uterus masih dapat dirasakan

TFU setinggi pusat

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : Suntik oksitosin dan pengeluaran plasenta dengan baik

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

"Tidak ada"

IV. TINDAKAN SEGERA

"Tidak ada"

V. PERENCANAAN

1. **Beritahu ibu bahwa keadaannya dan bayinya baik**
2. **Lakukan MAK III (Manajemen Aktif Kala III)**

VI. PELAKSANAAN

1. **Memberitahu ibu bahwa keadaannya dan bayinya sehat dengan TD : 120/80 mmHg, HR : 81 x/ menit, RR : 22 x/ menit, Temp : 36,0^{o}c. Bayi lahir dengan spontan, jenis kelamin laki-laki, menangis kuat, dan kulit kemerahan**
2. **Melakukan MAK III**
   a. **Memakai sarung tangan**
   b. **Memeriksa kembali uterus dengan meraba abdomen untuk memastikan tidak ada janin kedua**
   c. **Menjelaskan dan memberitahu ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi dengan baik**
   d. **Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan injeksi oksitosin IM 1/3 paha atas bagian distal lateral**
   e. **Melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini)**
   f. **Memindahkan klem tali pusat 5-10 cm dari vulva**
   g. **Melakukan PTT (Peregangan Tali Pusat Terkendali)**

h. **Tangan kiri melakukan dorsocranial hingga plasenta lepas dan tangan kanan melakukan PTT**
i. **Saat plasenta muncul diintroitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban searah dengan jarum jam, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadahnya**
j. **Lakukan masase uterus sampai uterus berkontraksi baik**
k. **Evaluasi laserasi jalan lahir pada vagina dan perineum**
l. **Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan**
m. **Cuci tangan dengan larutan klorin, lepaskan handscoon dan rendam dalam keadaan terbaik**
n. **Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir**
o. **Plasenta lahir spontan**

VII.EVALUASI

1. **Ibu sudah tahu keadaan dirinya dan bayinya**
2. **Manajemen Aktif Kala III telah dilakukan**

3.2.3. Catatan Perkembangan Kala IV

I. PENGKAJIAN KALA IV, Pukul : 15.10 wib

A. Anamnese (Subjektif)

1. **Perasaan : Baik**
2. **Keluhan fisik**

-Mules : Ada
-Lelah : Tidak ada
-Kedinginan : Tidak ada
-Nyeri : Tidak ada
-Haus : Ada
-Lapar : Tidak ada
-Lain-lain, jelaskan : Tidak ada

B. Pemeriksaan fisik (Objektif)

1. Penampilan fisik
   - Pucat : Tidak
   - Gelisah : Tidak
   - Keringat : Ya
   - Gemetar : Tidak ada
2. Keadaan emosional
   - Nampak takut : Tidak
   - Inkoheren : Tidak
   - Lain-lain, jelaskan : Tidak
3. Tanda vital
   - Takanan darah : 120/70 mmHg
   - Denyut nadi : 81x/ menit
   - Pernafasan : 22x/ menit
   - Suhu tubuh : 36,0^{o}c
4. Pemeriksaan kebidanan

A. Abdomen
   - TFU : 2 jari dibawah pusat
   - Konsistensi uterus : Keras dan bulat
   - Kandung kemih : Kosong

B. Genital
   - Luka jalan lahir : Tidak ada
   - Pengeluaran darah/ vaginam :- cc

	Tanda	0	1	2	Jumlah nilai
Menit Ke-1	[ ] frekuensi jantung [ ] usaha bernafas	[ ] tidak ada [ ] tidak ada [ ] lumpuh	[ ] <100 [ ]lambat tak beraturan	[✓]>100 [✓] menangis kuat	

	[ ] tonus otot [ ] reflex [ ] warna	[ ] tak bereaksi [ ]biru/pucat	[✓]ext.flexi sedikit [✓]gerakan sedikit [ ]tumbuh kemerahan lengan dan kaki	[ ]gerakan aktif [ ]menangis [✓] kemerahan	8
Menit Ke-5	[ ] frekuensi jantung [ ] usaha bernfas [ ] tonus otot [ ] reflex [ ] warna	[ ] tidak ada [ ] tidak ada [ ] lumpuh [ ] tak bereaksi [ ] biru/ pucat	[ ] <100 [ ] lambat tak beraturan [ ] ext.flexi sedikit [ ] gerakan sedikit [ ] tumbuh kemerahan lengan dan kaki	[✓] >100 [✓] menangis kuat [✓] gerakan aktif [✓] menangis [✓] kemerahan	10

2. PB/ BB : 3300 gram/ 47 cm

II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : Inpartu kala IV

DS : Ibu mengatakan lemas dan bahagia karena melihat bayinya

DO : Kontraksinya baik, TFU 2 jari dibawah pusat, dan K/U baik

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : Posisi yang nyaman, Tempat yang bersih dan nyaman, Makan dan minum

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

"Tidak ada"

IV. TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI

"Tidak ada"

V. PERENCANAAN

1. **Pantau tanda-tanda vital ibu dan bayi**
2. **Lakukan penilaian apgar score pada bayi**
3. **Periksa adanya laserasi jalan lahir**
4. **Periksa keadaan uterus ibu**
5. **Ajari ibu cara menyusui yang benar**
6. **Anjurkan ibu pemberian asi eksklusif pada bayi**
7. **Berikan penkes tentang pentingnya konsumsi nutrisi yang baik**
8. **Beri posisi yang nyaman pada ibu dan beri injeeksi vit k1 IM pada bayi**
9. **Lakukan dokumentasi untuk hasil pemeriksaan**

VI. PELAKSANAAN

1. **Memantau tanda-tanda vital ibu dan bayi dengan hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TD: 120/70 mmHg, HR: 81x/ menit, RR: 22x/ menit, T: 36,5^{o}c**
2. **Melakukan penilaian apgar score pada bayi**
3. **Memeriksa adanya laserasi jalan lahir supaya terhindar terjadinya perdarahan pervaginam**
4. **Memeriksa keadaan uterus dengan merasakan adanya kontraksi agar uterus terjadinya involusi uteri yaitu kembalinya uterus kebentuk semula**

5. **Mengajari ibu cara menyusui yang benar dan tepat agar puting susu ibu tidak lecet dengan cara seluruh areola masuk kedalam mulut bayi jangan hanya putingnya saja**
6. **Menganjurkan ibu dalam pemberian asi eksklusif pada bayi karena asi awal sangat baik untuk metabolisme tubuh bayi**
7. **Memberikan penkes tentang pentingnya konsumsi nutrisi yang baik misalnya pada ibu yaitu banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan agar kebutuhan nutrisi bayi tercukupi karena nutrisi bayi tergantung pada ibunya sendiri**
8. **Memberi posisi yang nyaman pada ibu dan memberikan injeksi vitamin k1 IM 10 mg dipaha kiri anterolateral**
9. **Melakukan dokumentasi pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan**

VII.EVALUASI

1. **Pemantauan tanda-tanda vital ibu dan bayi telah dilakukan**
2. **Penilaian apgar score pada bayi telah dilakukan**
3. **Pemeriksaan laserasi jalan lahir pada ibu telah dilakukan**
4. **Pemeriksaan keadaan uterus pada ibu telah dilakukan**
5. **Ibu sudah tahu cara menyusui yang benar**
6. **Ibu bersedia memberikan asi eksklusif pada bayinya**
7. **Ibu sudah mengkonsumsi nutrisi yang baik**
8. **Ibu merasa nyaman dengan posisinya dan penyuntikan vit k1 pada bayi telah dilakukan**
9. **Dokumentasi telah dilakukan.**

3.3. MASA NIFAS

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS NY. C DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Hari/Tanggal : 20-11- 2024 Jam : 17.20 wib

I. PENGUMPULAN DATA

A. IdentitasBiodata

NamaIbu	: Ny. C	Nama Suami	: Tn. V
Umur :	: 22 thn	Umur	: 22 thn
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat rumah	: Desa simalingkar b		

B. Anamnese (Data Subjektif)

1. Keluhan Utama : Kunjungan masa nifas
2. RiwayatPersalinan : Normal
   - Tempat Melahirkan : Puskesmas
   - Tanggal Melahirkan : 20-10-2024
   - Jenis Persalinan : Spontan
   - Penolong : Bidan
   - Lama Persalinan : 7-8 jam
3. Bayi
   - Lahir : Spontan
   - Pukul : 11:20 wib
   - BB : 3200 gr
   - Bugar : Baik
   - Cacatbawaan :Tidak ada
   - Masagestasi : 39 minggu 6 hari
   - Bayi rawat gabung dengan ibunya
4. Riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu :
5. Pola makan/minum

- Frekuensi : 3 kali sehari
- Jenis makanan : Nasi, ikan, telur,dan sayur
- Porsi : 1 piring
- Keluhan : Tidak ada

6. Pola Eliminasi
   - BAK : Normal
   - Warna : Kuning
   - Frekuensi : 7 kali sehari
   - BAB : Normal
   - Keluhan : Tidak ada

7. Pola istirahat/Tidur
   - Tidur malam : 8 jam
   - Tidur siang : Kurang lebih 2 jam
   - Gangguan tidur :Tidak ada
8. Status Psikologi
   - Respon ibu terhadap pengalaman persalinan : Baik
   - Respon ibuterhadap bayi : Baik
   - Hubungan ibudan bayi : Cemas
   - Kekhawatiran khusus : Ibu merasa cemas
   - Taking In : Ibu masih ketergantungan
   - Taking Hold : Ibu masih ketergantungan
9. Mobilisasi : Ibu sudah bisa miring kanan dan kiri

C. DATA OBJEKTIF

1. Keadaanumum : Stabil
   Kesadaran : Composmentis
   Keadaanemosional : Baik
2. Tanda – tanda vital :
   TD : 120/80 mmhg
   Nadi : 81 x/i

Suhu : 36,6^{o} c

RR : 22 x/i

3. Mata
   - Kelopak mata : Tidak edema
   - Konjungtiva : Merah muda
   - Sklera : Tidak Ikterik
4. Mamae
   - Colostrums : Ada
   - Putting susu :Menonjol
   - Pembengkakan : Tidak ada
   - Rasa nyeri : Tidak ada
   - Kebersihan : Bersih
   - Warna : Kehitaman
5. Abdomen
   - Bekaslukaoperasi : Tidak ada
   - TFU : 3 jari dibawah pusat
   - Uterus : Keras
   - Kandungkemih : Kosong
6. Genitalia
   - Perineum
     - ✓ Robekan perineum : Derajat II
     - ✓ Oedema : Tidak ada
     - ✓ Varises : Tidak ada
   - Pengeluaranpervaginam
     - ✓ Lochea : Rubra
     - ✓ Bau : Amis
     - ✓ Konsisten : -
     - ✓ Warnalochea : Merah segar
     - ✓ Jumlah : 3 kali ganti doek

7. Ekstremitas
   - Oedema : Tidak ada

- Varices : Tidak ada
- Reflex patella : Tidak ada

D. PEMERIKSAAN PENUNJANG

- Hb : 10gr/dl
- Gol.darah : Tidak dilakukan
- Rhesus : Tidak dilakukan
- DLL : Tidak dilakukan

3.3.1. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas Pertama (6 Jam Postpartum)

Tanggal : 20-11-2024 Pukul : 23.20 wib

II. INTERPRESTASI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : Ny. C, umur 22 tahun P1A0, 6 jam post partum

DS : Ibu mengatakan senang telah melahirkan anak pertama dengan selamat pada tanggal 20 November2024 jam 11.20 wib
Ibu mengatakan saat ini perutnya masih mules, lochea masih keluar dari alat kemaluan, ASI lancar, bayi menyusu dengan baik

DO : Kesadaran composmentis, Keadaan emosional stabil, TD: 110/80 mmHg, Suhu: 36,4^{o}c, Nadi: 81x/ menit, RR: 20x/ menit, TFU 2 jari dibawah pusat, Lokhea rubra, uterus baik, konsistensi keras

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : Perawatan perineum
Perawatan tali pusat dan bayi

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

"Tidak ada"

IV. TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI

"Tidak ada"

V. PERENCANAAN

1. Beritahu ibu hasil pemeriksaan
2. Jelaskan pada ibu tentang mules yang dirasakan
3. Beritahu ibu tentang cara perawatan tali pusat
4. Beritahu ibu tentang menjaga kehangatan bayi
5. Beritahu ibu untuk istirahat yang cukup
6. Beritahu ibu tentang gizinya
7. Beritahu ibu tentang pemberian asi
8. Beritahu ibu cara menyusui yang benar
9. Beritahu ibu tentang kebersihan diri
10. Dokumentasi semua asuhan

VI. PELAKSANAAN

1. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan saat ini dalam keadaan umum baik yaitu TD: 110/80 mmHg, HR: 81x/ menit, RR: 20x/ menit, T: 36,4^{o}c, TFU 2 jari dibawah pusat
2. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan rasa mules yang ia alami merupakan hal yang normal, karena rahim yang keras dan mules berarti rahim sedang berkontraksi yang dapat mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas.
3. Memberitahu ibu tentang cara perawatan tali pusat yaitu agar tidak mengompresnya dengan menggunakan alkohol atau betadine
4. Memberitahu ibu untuk menjaga kehangatan bayi dengan selalu memakaikan selimut dan topi pada bayi untuk mencegah hipotermia
5. Memberitahu ibu untuk istirahat cukup tidur siang sangat diperlukan oleh ibu untuk memulihkan tenaga ibu
6. Memberitahu ibu tentang gizi yang seimbang agar kebutuhan bayi pada masa laktasi bisa terpenuhi dan tidak ada makanan yang dipantang

7. Menganjurkan ibu tentang pemberian asi eksklusif karena dapat menambah kekebalan tubuh bagi bayi
8. Memberitahu ibu cara menyusui yang benar dengan menyusui dalam posisi dan pelekatan yang benar, sehingga menyusui efektif yaitu seluruh badan bayi tersangga dengan baik, jangan hanya leher dan bahunya saja, kepala dan tubuh bayi lurus, badan bayi lurus, badan bayi menghadap ke dada ibunya, badan bayidekat ke ibunya
9. Memberitahu ibu tentang kebersihan diri agar mandi setiap hari dapat membantu mengurangi sumber infeksi serta untuk mengurangi ketidaknyamanan pada ibu seperti sering mengganti pembalut ibu
10. Mendokumentasikan semua asuhan dan temuan/ hasil pemeriksaan

VII. EVALUASI

1. Ibu sudah tahu kondisinya sekarang dalam keadaan normal
2. Ibu sudah mengerti dan paham tentang penyebab rasa mules yang ia alami
3. Ibu sudah mengerti tentang perawatan tali pusat
4. Ibu sudah mengerti untuk menjaga kehangatan bayi
5. Ibu mengatakan akan istirahat cukup
6. Ibu mengerti dan mengetahui tentang gizi yang diperlukan
7. Ibu telah mengerti tentang pemberian asi eksklusif
8. Ibu sudah tahu cara menyusui yang benar
9. Ibu telah mengerti tentang menjaga kebersihan diri
10. Semua asuhan telah didokumentasik

3.3.2. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas (3 Hari Post Partum)

Tanggal : 20-11-2024 Pukul : 10.00 wib

S : Subjek

Ny. C Umur : 22 Tahun Nifas Hari Ke-3 datang untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Novembe r2024

O : Objektif

K/U ibu baik, Kesadaran : Cm

Pemeriksaan TTV

TD :120/ 70 mmHg HR : 79 x/ menit

RR : 20 x/ menit T : 36,6^0 C

Keluhan Utama : Perut masih merasa mules

Riwayat persalinan : Normal

Tempat Melahirkan : Puskesmas

Tanggal Melahirkan : 20 November2024

Jenis Persalinan : Normal

Penolong : Bidan

Lama Persalinan : 8 jam

Bayi

Lahir : Spontan Pukul : 11.20 wib

BB : 3200 gram

Bugar : 8

Cacat bawaan : Tidak Ada

Bayi Rawat Gabung dengan Bayinya : YA

A : (Asesment)

Ny. C Umur : 24 Tahun Nifas Hari Ke-3 datang untuk melakukan pemeriksaan dengan keluhan masih terasa mules .

P : (Planning)

1. Informasikan hasil pemeriksaan

   TD : 120/80 mmHg RR : 18 x/ menit

   HR : 79 x /menit T : 36,5^0 C

2. Pantau involusia uteri (3 jari dibawah pusat)
3. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan cara keluarga secara bergantian melihat keadaan bayi.
4. Anjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti tinggi protein untuk membantu mempercepat penyembuhan jika ada luka.

3.3.3. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas Ketiga (2 Minggu Postpartum)

Tanggal : 20-11-2024` Pukul : 09.00 WIB

S : Subjek

Ny. C Umur : 22 Tahun Nifas hari Ke-14 datang untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 20-11-2024. Ibu mengatakan sudah BAB dan BAK tidak ada nyeri perut dan tidak ada keluhan lain yang dirasakan ibu.

O : Objektif

K/U ibu baik, Kesadaran : Cm

Pemeriksaan TTV

TD :120/ 70 mmHg HR : 79 x/ menit

RR : 19 x/ menit T : 36,4^0 C

Kandung kemih : kosong

Putting susu : menonjol

Pembengkakan : tidak ada

Uterus :

TFU : pertengahan simfisis dan pusat

kontraksi baik

lokhea serosa (kuning keputihan),

A : (Asesment)

Ny. C post partum normal hari ke- 14 keadaan ibu baik.

P : (Planning)

1. Beritahukan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk memberikan asi sesering mungkin kepada bayinya.
3. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk pemulihan rahim dan menjaga kualitas produksi asi.
4. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
5. Berikan konseling pada ibu
   - personal hygine/ kebersihan diri

- perawatan payudara
- posisi dan tekhnik menyusui yang benar
- posisi menyendawakan bayi setelah menyusui

6. Ibu mengerti dan dapat mengulangi penjelasan yang telah diberikan dan mampu mengulanginya.

3.3.4. Catatan Perkembangan Kunjungan Nifas Keempat (6 Minggu Postpartum)

Tanggal : 20-11-2024 Pukul :08.00 wib

S : Subjek

Ny. C Umur : 24Tahun Nifas Minggu Ke-6 yang lalu, ibu mengatakan keadaannya baik dan tidak ada keluhan. Ibu juga mengatakan darah nifasnya tidak ada lagi dan tidak ada nyeri.

O : Objektif

K/U ibu baik, Kesadaran : Cm

Pemeriksaan TTV

TD :120/ 90 mmHg HR : 72 x/ menit

RR : 19 x/ menit T : $36,2^0$ C

Kandung kemih : kosong

Putting susu : menonjol

Pembengkakan : tidak ada

Pemeriksaan Uterus :

TFU : pertengahan simfisis dan pusat

kontraksi baik

lokhea serosa (kuning keputihan)

A : (Asesment)

Ny. C post partum normal minggu ke 6 keadaan ibu baik.

P : (Planning)

1. Beritahukan hasil pemeriksaan pada ibu
2. Anjurkan ibu untuk memberikan asi sesering mungkin kepada bayinya.
3. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk pemulihan rahim dan menjaga kualitas produksi asi.

4. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
5. Anjurkan ibu untuk menjaga personal hygine
6. Berikan konseling kepada tentang Kb dan kontrasepsinya
    - pengertian keluarga berencana
    - mamfaat keluarga berencana
    - metode kontrasepsi
    - waktu ber-KB
7. Ibu mengerti dan dapat mengulangi penjelasan yang telah diberikan dan mampu mengulanginya

3.4. BAYI BARU LAHIR

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

I. PENGUMPULAN DATA

A. IDENTITAS/ BIODATA

Nama Bayi	: By. Ny. C
Umur Bayi	: 6 Jam
Tgl/jam/lahir	: 26-10-2024/ 11.20 wib/ Spontan
Jenis kelamin	: Perempuan
No.Status Reg	: -
Berat Badan	: 3200 gram
Panjang Badan	: 47 cm

Nama Ibu	: Ny. C	Nama Suami	: Tn. M
Umur	: 24 tahun	Umur	: 24 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Pedangang	Pekerjaan	: Pedagang
Alamat rumah	: Desa Kedai Durian		

B. ANAMNESE (DATA SUBJEKTIF)

Pada tanggal :20-10- 2024 Pukul : 09.20 wib

1. Riwayat penyakit kehamilan

- **Perdarahan : Tidak ada**
- **Pre eklamsi : Tidak ada**
- **Eklampsi : Tidak ada**
- **Penyakit kelamin : Tidak ada**
- **Lain-ain : Tidak ada**

2. Kebiasaan waktu hamil

- **Makanan : Nasi, Ikan dan sayur**
- **Obat-obatan/ jamu : Tidak ada**
- **Merokok : Tidak ada**
- **Lain-lain : Tidak ada**

3. Riwayat persalinan sekarang

a. Jenis persalinan : Normal

b. Ditolong oleh : Bidan

c. Lama persalinan

Kala I : 8 jam : menit : -

Kala II : 1 jam: menit : -

d. Ketuban pecah : spontan lamanya : -

Warna : Jernih bau: Amis jumlah : -

e. Komplikasi persalinan

- **Ibu : Tidak ada**
- **Bayi : Tidak ada**

f. Keadaan bayi baru lahir

- **Nilai Apgar : 1-5=8 5-10=10.**

	Tanda	0	1	2	Jumlah nilai

Menit Ke-1	[ ] frekuensi jantung [ ] usaha bernafas [ ] tonus otot [ ] reflex [ ] warna	[ ] tidak ada [ ] tidak ada [ ] lumpuh [ ] tak bereaksi [ ]biru/pucat	[ ] <100 [ ]lambat tak beraturan [✓]ext.flexi sedikit [✓]gerakan sedikit [ ]tumbuh kemerahan lengan dan kaki	[✓]>100 [✓] menangis kuat [ ]gerakan aktif [ ]menangis [✓] kemerahan	8
Menit Ke-5	[ ] frekuensi jantung [ ] usaha bernfas [ ] tonus otot [ ] reflex [ ] warna	[ ] tidak ada [ ] tidak ada [ ] lumpuh [ ] tak bereaksi [ ] biru/ pucat	[ ] <100 [ ] lambat tak beraturan [ ] ext.flexi sedikit [ ] gerakan sedikit [ ] tumbuh kemerahan lengan dan kaki	[✓] >100 [✓] menangis kuat [✓] gerakan aktif [✓] menangis [✓] kemerahan	10

Sidik telapak kaki kiri bayi	**Sidik telapak kaki kanan bayi**

Sidik jempol tangan kiri ibu	**Sidik jempol tangan kanan ibu**

RESUSITASI

Penghisapan lendir	:	ya	rangsangan	: ya	
Ambu	:	tidak	lamanya	:	menit
Masase jantung	:	tidak	lamanya	:	menit
Intubasi Endutraheat	:	tidak	nomor :		
Oksigen	:	tidak	lamanya	:	menit
Therapi	:	Tidak			
Keterangan	:	Tidak ada			

C. PEMERIKSAAN FISIK (Data Objektif)

- Keadaan umum : Baik
- Suhu : 36,7^{o}c Axilla/Rectal, pukul : 14.20 wib
- Pernapasan : 36 x/menit,teratur/tidak, pukul : 14.20 wib
- HR : 130 x/menit,teratur/tidak,pukul: 14.20 wib
- Berat badan sekarang : 3300 gram

Pemeriksaan fisik secara sistematis

-Kepala : Tidak terdapat kaput

-Ubun-ubun : Tidak ada Cephal hematoma

-Muka : Kemerahan, tidak pucat/ odema

-Mata : Konjungtiva tidak pucat dan sklera mata tidak ikhterus

-Telinga : Simetris dan tidak ada pengeluaran

-Mulut : Bersih

-Hidung : Bersih

-Leher : Simetris

-Dada : Simetris

-Tali Pusat : Tidak ada pendarahan

-Punggung : Tidak odema dan baik

-Ekstremitas : Baik

-Genitalia: Prempuan (labia mayor, labia minor, klitoris (+)

-Anus : (+) positif

Refleks

-Refleks Moro : Baik, saat dirangsang, terkejut(+)

-Refleks Rooling : Baik, langsung mencari rangsangan

-Refleks Walking : Belum dilakukan rangsangan

-Refleks Graphs/plantar :Baik, tangan menggenggam saat diberi rangsangan

-Refleks Sucking :Baik, menghisap kuat saat diberi rangsangan

-Refleks Tonic Neck : Pengangkatan leher (+)

Antropometri

-Lingkar Kepala : 32 cm

-Lingkar Dada : 33 cm

-Lingkar Lengan Atas : 11 cm

Eliminasi

-Miksi : sudah warna: Kuning

-Mekonium : sudah warna: Kehijauan

3.4.1 Catatan Perkembangan Kunjungan Bayi Baru Lahir Pertama (6 Jam)

Tanggal : 20-10-2024 Pukul : 15.20 wib

II. INTERPRESTASI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : By. Ny. C ke-1 dengan berat badan lahir normal 3200 gram dan panjang badan 47 cm

DS : Ibu mengatakan ini adalah anak pertama, usia kehamilan aterm, partus spontan, tidak ada komplikasi pada bayi, daya hisap baik saat IMD, dan kolostrum keluar

DO : Dari hasil pemeriksaan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, panjang badan bayi 47 cm, berat badan bayi 3200 gram, Apgar score 8-10, tidak ada kelainan dalam pemeriksaan fisik dan refleks dalam keadaan normal

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : 1. Informasikan hasil pemeriksaan
2. Penkes tentang ASI eksklusif
3. Penkes tentang menjaga kehangatan bayi

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

"Tidak ada"

IV. TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI

"Tidak ada"

V. PERENCANAAN

1. Informasikan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada bayi
2. Beri injeksi vit K1 pada bayi
3. Beri injeksi imunisasi HB-0 pada bayi

4. Jaga suhu bayi tetap hangat
5. Lakukan perawatan tali pusat
6. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya
7. Anjurkan ibu untuk pemberian ASI eksklusif

VI. PELAKSANAAN

4. Menjaga suhu bayi dengan cara membedong bayi dengan kain bersih dan hangat, menutup kepala bayi dan meletakkan bayi disamping/didekap ibu
5. Melakukan perawatan tali pusat dan mengajarkan ibu agar menjaga tali pusat tetap kering dan bersih, dan membungkusnya dengan kassa steril
6. Menganjurkan ibu untuk menyususi bayinya sesering mungkin kurang lebih setiap 2 jam sekali
7. Menganjurkan ibu untuk memberi ASI eksklusif yaitu hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun

VII. EVALUASI

1. Ibu dan keluarga senang mendengar keadaannya
2. Suntikan Vit. K sudah diberikan 1 jam setelah bayi lahir
3. Imunisasi HB-0 sudah diberikan
4. Bayi sudah dibedong dan diletakkan disamping ibu
5. Tali pusat sudah dibungkus dengan kassa steril
6. Ibu akan menyusui bayinya sesering mungkin
7. Ibu akan memberi ASI eksklusif

3.4.2. Catatan Perkembangan Kunjungan Neonatal Kedua (6 Hari)

Tanggal : 20-11 2024 Pukul : 10.00 wib

S: (subjek)

Ibu bayi mengatakan melahirkan tanggal 02-10-2024 jam 14.20 wib, jenis kelamin perempuan, BB : 3200 gram, PB :47 cm, bayi menyu kuat.. BAK 6-7 kali / hari, warna kuning jernih, BAB 3x / hari warna kuning.

O: (objektif)

K/U baik Kesadaran : cm

Tangis bayi kuat, tonus otot kuat

TTV

TD : - RR : 35x / menit

HR : 120x / menit T : 36,7 ^{0}C

A : (Asesment)

Neonatus cukup bulan Usia 6 hari dengan keadaan Normal.

P : (Planning)

1. Beritahukan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa bayi dalam keadaan baik.

2. Pastikan pada ibu apakah bayinya mendapatkan asi dengan cukup tanpa diberikan pendamping atau susu formula , ibu mengerti.

3. Ingatkan kembali tentang tanda-tanda bahaya yang dapat terjadi pada bayi baru lahir. Diantaranya bayi rewel, tali pusat bau, bengkak dan berwarna merah, bayi kuning dan tidak mau menyu.jika tanda-tanda tersebut terjadi diharapkan ibu menghubungi petugas kesehatan secepatnya, dan ibu mengerti

4. Ingatkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang sebulan kemudian untuk penimbangan bayi dan imunisasi BCG serta polio.

3.4.3 Catatan Perkembangan Kunjungan Neonatal Ketiga (28 Hari)

Tanggal : 20-11-2024 Pukul : 10.00 wib

S: (subjek)

Ibu bayi mengatakan melahirakan tanggal 20-10-2024 jam 13.00 wib, jenis kelamin perempuan, BB : 3300 gram, PB :49 cm, bayi menyu kuat. Tali pusat bayi lepas saat usia bayi 6 hari. BAK 6-7 kali / hari, warna kuning jernih, BAB 3x / hari warna kuning.

O: (objektif)

K/U baik Kesadaran : cm

Tangis bayi kuat, tonus otot kuat

TTV

TD : - RR : 35x / menit

HR : 120x / menit T : 36,7 ^{0}C

A : (Asesment)

Neonatus cukup bulan Usia 28 hari dengan keadaan Normal.

P : (Planning)

1. Beritahukan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa bayi dalam keadaan baik.

2. Pastikan pada ibu apakah bayinya mendapatkan asi dengan cukup tanpa diberikan pendamping atau susu formula , ibu mengerti.

3. Ingatkan kembali tentang tanda-tanda bahaya yang dapat terjadi pada bayi baru lahir. Diantaranya bayi rewel, tali pusat bau, bengkak dan berwarna merah, bayi kuning dan tidak mau menyu.jika tanda-tanda tersebut terjadi diharapkan ibu menghubungi petugas kesehatan secepatnya, dan ibu mengerti

4. Ingatkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang sebulan kemudian untuk penimbangan bayi dan imunisasi BCG serta polio.

3.5. KELUARGA BERENCANA

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA

I. PENGUMPULAN DATA

A. Identitas / Biodata

Nama : Ny. C
Umur : 22 Tahun
Status : Sudah menikah
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan :IRT
Alamat : Deli Tua

B. Anamnesa (Data Subjektif)

1. **Alasan datang : Ingin ber-Kb**
2. **Tanggal berkunjung : 04-11-2024**
3. **Yang Mengantar : Suami**
4. **RiwayatMenstruasi**
   - **a. Menarche : 15 Tahun**
   - **b. Siklus : 28 Hari**
   - **c. Lamanya : 6 hari**
   - **d. Banyaknya : 3x ganti pembalut/ hari**
   - **e. Sifat Darah : Encer**
   - **f. Warna : Merah**
5. **Riwayat Perkawinan**
   - **Kawin ke : 1 (satu)**
   - **Lama Perkawinan : 4 Tahun**
   - **Status perkawinan : SAH**
6. **Riwayat Kehamilan yang lalu**
   - **a. Gravida : 1**
   - **b. Partus : 1**
   - **c. Abortus : 0**

d. Lahir Hidup : 1

e. Lahir Mati : 0

7. Riwayat Persalinan/ abortus terakhir

a. Tanggal Persalinan yang lalu : 02-10-2024

b. Jenis Persalinan : Normal

c. Apakah sedang menyusui :Sedang menyusui

8. Riwayat KB Sebelumnya :

- **Dalam 2 tahun terakhir apakah ada memakai kontrasepsi : Tidak Ada**
- **Bila ya, jelaskan masing-masing :**

No	Metode	Lama Pemakaian	Alasan Penghentian Metode Kontrasepsi
1	Pil		
2	IUD		
3	Injeksi		
4	Kondom		
5	Dll		

9. Riwayat Medis Sebelumnya

- **Sedang Mendapatkan pengobatan jangka panjang : Tidak Ada**

  Jika ya jelaskan :
- **Saat ini sedang menderita penyakit kronis : Tidak Ada**

  Jika ya jelaskan :

10. Riwayat Sosial

a. Merokok : Tidak Ada

b. Minuman keras : Tidak Ada

11. Riwayat Ginekologi

- **Tumor Ginekologi : Tidak Ada**

- **Operasi Ginekologi yang pernah dialami: Tidak Ada**
- **Penyakit Kelamin : Tidak Ada**
- **GO : Tidak Ada**
- **Sipilis : Tidak Ada**
- **Herpes : Tidak Ada**
- **Keputihan : Tidak Ada**
- **Pendarahan tanpa sebab yang jelas : Tidak Ada**

C. PemeriksaanFisik

1. **Status Generalis: Stabil**
2. **Tanda Vital**
   - **TD : 120/80 mmHg**
   - **HR : 79x/ menit**
   - **RR : 18x/ menit**
   - **Suhu : 36,6 ^{0} C**
   - **TB : 150 cm**
   - **BB : 60 kg**
3. **Abdomen**
   - **Perut : Normal**
4. **Genetalia**
   - **Inspeksi : Tidak Ada**
   - **Inspekula : Tidak**
     - **Tanda –tandaPeradangan : Tidak Ada**
     - **Tanda-tanda Kehamilan : Tidak ada**
     - **Pendarahan : Tidak ada**
     - **Panjang uterus :Tidak dilakukan pemeriksaan**

D. PemeriksaanLaboratorium

- **Planotest : (-)**
- **HB : Tidak dilakukan pemeriksaan**
- **HT : -**

E. Data Psikologis

- **Pengertian ibu tentang efek samping alat kontrasepsi :Sudah mengerti**
- **Pengaruh alat Kontrasepsi dengan agama yang dianut : Tidak ada**
- **Pengaruh alat Kontrasepsi dengan hubungan suami istri : Tidak ada**

3.5.1. CATATAN PERKEMBANGAN KB

II. IDENTIFIKSI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa Kebidanan : Aseptor KB MAL

DS : Ibu mengatakan ingin ber KB MAL

Ibu ingin menunda kehamilan

Ibu tidak hamil

DO : K/U : baik

TD : 120/ 80 mmHg **RR : 18x/ menit**

HR : 79x/ menit **T : 36,6 ^{0} C**

Ibu mengatakan tidak ada riwayat hipertensi

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : Menganamnesa Pasien

Penkes tentang KB MAL

III. IDENTIFIKASI MASALAH POTENSIAL

TIDAK ADA

IV. TINDAKAN SEGERA

TIDAK ADA

V. PERENCANAAN

1. Beri tahu hasil pemeriksaan

2. Beri tahu prosedur pelaksanaan

3. Beri penkes tentang KB MAL

4. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang

VI. PELAKSANAAN

1.Memberi tahukan ibu hasil pemeriksaan

TD : 120/80 mmHg RR : 18x/ menit

HR : 79x/ menit T : 36,6 ^{0} C

2. Memberitahukan prosedur pelaksanaan

Jelaskan pada ibu tentang KB MAL atau Metode Amenorea Laktasi dengan cara menyusui bayi secara esklusif selama 6 bulan ASI tanpa makanan pendamping lainnya.

3. Memberikan penkes tentang KB MAL

Jelaskan pada ibu bahwa KB MAL dapat menambah berat badan ibu.

VII. EVALUASI

1.Ibu sudah mengetahui keadaan ibu baik

2. Ibu sudah mengerti dengan PENKES yang diberikan bidan

3.Ibu sudah tahu kunjungan ulang ke Puskesmas

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Masa Kehamilan

Berdasarkan hasil asuhan yang dilakukan penulis kepada Ny. C usia kehamilan 39 minggu 6 Hari hingga , masa persalinan sampai 6 minggu post partum, neonatus dan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas. maka didapatkan pembahasan sebagai berikut:

Asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny. C pada kehamilan 39 minggu adalah pengkajian data dari mulai anamnesa tentang biodata, status pernikahan, keluhan utama, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, pola kegiatan sehari-hari. Selanjutanya penulis melakukan pemeriksaan, yaitu menimbang berat badan, mengukur tekanan darah, menilai status gizi, mengukur tinggi fundus uteri, melakukan pemeriksaan presentasi kepala dan DJJ, spemberian tablet zat besi, melakukan tata laksana kasus dan temu wicara dalam rangka persiapan rujukan.

Pemberian Tablet Fe sudah diberikan pada saat melakukan asuhan ANC. Ny. C mau minum obat tablet Fe tersebut dan pada saat pengkajian penulis memberikan konseling tentang pentingnya tablet Fe untuk dapat menurunkan angka kematian ibu karena Anemia.

Menurut penelitian Ika Pantikawi 2010, tablet Fe mengandung 200 mg Sulfat Ferosus 0,25 mg asam folat yang diikat dengan laktosa. Tujuan pemberian tablet Fe adalah untuk memenuhi kebutuhan pada ibu hamil dan nifas, karena pada masa kehamilan kebutuhannya meningkat seiring dengan pertumbuhan janin.

Pemberian tablet zat besi (tablet tambah darah), Ny. C sudah mengonsumsi sejak usia kehamilan 21 minggu, walau setiap bulanya kadang-kadang masih ada 4 atau 5 tablet karena Ny. C lupa meminumnya, dan Ny. C sudah merasakan manfaatnya selama ini. Ny. C tidak merasakan keluhan yang berarti atau mengarah pada tanda bahaya.

4.2. Asuhan Masa Persalinan

Asuhan pada masa persalinan yang dilakukan pada Ny. di Puskesmas Simalingkar sudah memenuhi standar sesuai dengan asuhan persalinan

a. Kala I

Pada usia kehamilan 38 minggu 6 Hari Ny. C dan keluarga datang ke Puskesmas, ibu mengeluh mules-mules dan telah keluar lendir bercampur darah pada pukul 09.20 Wib dan cairan berwarna jernih dari kemaluan merupakan tanda-tanda awal pesalinan.

Pada saat Ny. C datang ke Puskesmas pukul 09.20 Wib bidan melakukan pemeriksaan serviks dan pembukaan serviks sudah 6 cm, portio tipis lunak, ketuban belum pecah, kepala berada di bidang hodge III dan his kuat. Kurang lebih 4 jam kemudian bidan melakukan pemeriksaan ulang didapatkan bahwa kemajuan persalinan berlangsung normal dengan hasil pembukaan 10 cm dan kepala sudah berada di bidang hodge IV.

Tanda-tanda awal persalinan yaitu his yang datang lebih kuat dan teratur, diikuti dengan keluarnya lendir bercampur darah yang menandakan bahwa jalan lahir mulai membuka serta cairan berwarna keruh yang keluar dari kemaluan adalah ciri-ciri dari air ketuban (Depkes, 2012).

Kala I dimulai dari pembukaan serviks sampai menjadi lengkap (10 cm) dimana proses ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten (7-8 jam) serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif (6 jam) serviks membuka dari 4-10 cm, kontraksi lebih kuat dan sering selama fase aktif (Sari, 2014).

Persalinan Kala 1 merupakan pembukaan yang berlangsung antara nol sampai pembukaan lengkap. Lama Kala 1 untuk pada *primigravida* berlangsung selama 8 jam (Manuaba, 2007).

Pembukaan serviks berdasarkan APN, dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata – rata 1 cm per jam (multipara atau primigravida) atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm (multipara). Waktu pembukaan serviks pada Ny. O berlangsung lebih cepat dibandingan dengan teori.

Asuhan persalinan kala I yang diberikan kepada Ny. O sudah sesuai standar yaitu menghadirkan orang yang dianggap penting oleh ibu seperti suami,keluarga pasien atau teman dekat, mengatur aktivitas dan posisi ibu, membimbing ibu untuk rileks sewaktu his, menjaga privasi ibu, penjelasan tentang kemajuan

persalinan, menjaga kebersihan diri, mengatasi rasa panas, masase, pemberian cukup minum, mempertahankan kandung kemih tetap kosong.

b. Kala II

Selama Kala II ibu dipimpin meneran ketika ada his dan menganjurkan ibu untuk minum di sela-sela his, 20 menit kemudian ibu mengatakan bahwa ia ingin meneran dan sudah ada tanda-tanda persalinan yaitu : adanya dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulva membuka. Kala II berlangsung selama 25 menit pada jalan lahir dengan jumlah darah ± 150 cc.

Pada kala II persalinan saat kepala mengadakan putar paksi luar, Bidan melakunan biparietal untuk melahirkan bahu, setelah itu melakukan sanggah susur.(Maria, 2008)

Namun pada saat di lapangan saat menolong persalinan pada kala II, dimana kepala melakukan putar paksi luar, Bidan melakukan biparietal untuk melahirkan bahu lalu Bidan mengangkat bayi diatas perut ibu, dan tidak melakukan sanggah susur.

Menurut analisa penulis, bahwasanya tindakan yang dilakukan dilapangan tidak sesuai dengan teori, karena menurut teori setelah melakukan biparietal untuk melahirkan bahu janin, Bidan seharusnya melakukan sanggah susur. Namun pada saat dipraktekkan dilapangan Bidan tidak melakukan sanggah susur, hal ini di karna kan kontraksi rahim ibu terlalu kuat sehingga bayi langsung lahir tanpa di lakukan sanggah susur.

c. Kala III

Setelah melakukan asuhan bayi baru lahir, segera dilakukan manajemen aktif kala III untuk meminimalkan kejadian komplikasi. Kala III berlangsung selama 10 menit dengan perdarahan ± 100 cc.

Kala III dimulai setelah pengeluaran bayi sampai pengeluaran plasenta, berlangsung selama 5-30 menit (Rohani, 2014).

Asuhan yang dilakukan pada kala III adalah jepit dan gunting tali pusat sedini mungkin, memberikan oksitosin, melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT (*Controled Cord Traction*), masase fundus.

d. Kala IV

Setelah proses persalinan selesai maka Bidan melakukan asuhan kala IV yaitu pemeriksaan fundus dan masase, nutrisi dan dehidrasi, bersihan ibu, istirahat, peningkatan hubungan ibu dan bayi, memulai menyusui, memantau kondisi Ny.C selama 2 jam diantaranya yaitu melakukan pemantauan tanda-tanda vital, perdarahan dan menilai kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri, mengajari ibu dan anggota keluarga. Dari pemantauan tersebut didapatkan bahwa keadaan ibu baik secara keseluruhan tanpa ada penyulit.

Pada kala IV dilakukan pemantaun pendarahan dengan jumlah 80cc dan pemeriksaan fundus uteri ibu 2 jari dibawah pusat. Keadaan umum ibu normal TD 110/80 mmHg, Temp 37°C, HR 85x/menit. Masa involusi dan penurunan fundus sesuai dengan teori dimana TFU pada 1 jam post partum adalah 2 jari dibawah pusat.

Kala IV adalah kala pengawasan selama 2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan (Kuswanti, 2014).

4.3. Asuhan Masa Nifas

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Masa nifas atau post partum yang disebut juga puerperium berasal dari bahasa latin yaitu kata “puer” yang artinya bayi dan “parous” berarti melahirkan. Darah nifar yaitu darah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas yaitu darah yang tertahan tidak bisa keluar dari rahim karena hamil. Maka itu termasuk darah nifas juga. (Yetti Anggraini, 2014).

Pengawasan masa nifas berdasarkan program dan kebijakan teknis Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dilakukan untuk menilai keadan ibu dan bayi baru lahir serta untuk mencegah, mendeteksi, dan menagani masalah-masalah yang terjadi, dimana bidan harus melakukan kunjungan dan pengawasan paling sedikti 4 kali yaitu dalam 6-8 jam, 2-6 hari, 2 minggu dan 6 minggu.

Dalam hal ini penulis melakukan kunjungan nifas sesuai dengan program yang ada dan hasilnya masa nifas Ny. C berlangsung secara normal tanpa ada komplikasi serta adanya perdarahan, involusi berjalan lancar, infeksi dan pengeluaran ASI tidak ada masalah. Selama melakukan asuhan penulis melakukannnya sesuai dengan tujuan pengawasan masa nifas diantaranya menjaga kesehatan bayinya baik fisik maupun fisikologi, mendeteksi masalah, memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene., nutrisi, KB, menyusui dan imunisasi pada bayi sesuai dengan teori dari hasil pemantauan tersebut di dapatkan keadaan ibu dan bayi normal tanpa ada penyulit.

Kunjungan pada masa nifas dilakukan sebanyak 4 kali kunjungan berdasarkan (Sari, 2014)

a. Kunjungan pertama (6-8 jam setelah persalinan)

Yang bertujuan mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan rujuk jika perdarahan berlanjut, pemberian ASI awal, 1 jam setelah Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan berhasil dilakukan, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat sehat agar bayi tidak mengalami hipotermi dan bila petugas kesehatan menolong persalinan ia harus tinggal dengan ibu untuk 2 jam pertama sudah kelahiran atau sampai bayi dan ibu dalam keadaan stabil.

Pada Masa Nifas Ny. C prosesnya berlangsung dengan normal. Masa involusi dan penurunan fundus sesuai dengan teori dimana TFU pada 6 jam postpartum adalah 2 jari dibawah pusat, pada kunjungan 6 hari postpartum TFU pertengahan pusat dan symfisis, pada kunjungan 2 minggu postpartum TFU tidak teraba di atas symfisis dan bertambah kecil pada kunjungan 6 minggu postpartum, sesuai dengan teoiri dan tidak ada terdapat kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek.

Pada hari pertama post partum, kurang dari 1 jam pertama ibu sudah memberikan ASI pada bayi, hal ini bisa terjadi sebab ibu mau mencoba memberikan kolostrum setelah ibu mendengar informasi yang diberikan bidan bahwa kolostrum adalah susu pertama dan inilah yang dapat memberikan kekebalan tubuh pada bayi sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit dan mengandung banyak gizi.

Pada hari pertama 6 jam setelah post partum Ny. C tidak berani untuk buang air kecil karena merasa takut akan terasa sakit dibagian vagina dengan itu tidak ada kesenjangan antara teori Suherni tahun 2009 dengan kenyataannya menurut teori 6 jam pertama post partum, ibu sudah dapat buang air kecil. Semakin lama urine ditahan, maka dapat mengakibatkan infeksi. Maka dari itu bidan harus dapat meyakinkan ibu supaya dapat segera buang air kecil, karena biasanya ibu malas buang air kecil karena takut akan merasa sakit. Segera buang air kecil setelah melahirkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi post partum.

Pada masa nifas Ny. C dianjurkan tidak boleh tidur selama 2 jam supaya perdarahan dapat berkurang karena rahim akan terus berkontraksi dan ibu disarankan tidak langsung turun dari tempat tidur setelah melahirkan karena dapat menyebabkan jatuh pingsan sirkulasi darah yang belum berjalan baik. Ibu harus cukup beristirahat, dimana ibu harus tidur terlentang selama 8 jam post partum untuk mencegah perdarahan post partum.

Pada Ny. O dilakukan pemeriksaan vital sign dan hasilnya normal terlihat TD : 110/70 mmHg, Nadi : 80 x/i suhu : 36^0 C, pemeriksaan tersebut sesuai dengan teoriEny retna Ambar wati tahun 2008, dimana menurut suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,2 ^{0}c. Sesudah partus dapat naik kurang lebih 0,5 ^{0}c dan nadi berkisar antara 60-80 x/i setelah partus.

b. Kunjungan kedua (6 hari setelah persalinan)

Pada kunjungan ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, menilai adanya tanda- tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit pada bagian payudara ibu, memberikan konseling pada ibu mengenai perawatan pada tali pusat, dan memberikan asuhan pada bayi dengan cara menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

Pada masa nifas Ny. C prosesnya berlangsung normal, tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus masa involusi dan penurunan fundus sesuai

dengan teori dimana tinggi fundus uteri (TFU) pada kunjungan 6 hari post partum tinggi fundus uteri (TFU) pertengahan sympisis dan pusat.

Pada Ny. C sangat rentan menjaga personal hygiene setelah diberi konseling pada bidan pentingnya personal hygiene Ny. C mandi 3 kali sehari, membersihkan daerah perineum dan mengeringkannya, mengganti pakaian setiap kali lembab. Hal ini sesuai dengan teori yaitu pada ibu nifas sebaiknya menjaga kebersihan seluruh tubuh dengan mengajarkan kepada ibu bagaimana cara membersihkan daerah kelamin dengan menggunakan sabun dan air serta menyarankan kepada ibu untuk mengganti pembalut setidaknya dua kali sehari (Ai Yeyeh Rukiyah, 2012)

Pada masa nifas Ny. C dalam pemenuhan nutrisi dan cairan sudah cukup baik, Ny. C makan dengan menggunakan sayur, dan minum hanya 6 gelas/hari. Dalam hal itu sesuai dengan teori yaitu kebutuhan nutrisi dan cairan pada ibu nifas harus mendapatkan tambahan 800 kalori/hari, makan dengan menu seimbang untuk mendapatkan protein, mineral, vitamin dan minum setidaknya 3 liter air setiap hari(Suherni, 2009).

Pada masa nifas Ny. C masih melakukan perawatan payudara tidak terjadi kesenjangan dengan teori Suherni 2009, dimana tujuan dari perawatan payudara ini adalah untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu, sehingga pengeluaran air susu ibu (ASI) lancar.

Pada Ny. C dilakukan pemeriksaan vital sign dan hasilnya normal dengan hasil pemeriksaan TD: 110/70mmHg, Pols: 80x/i, Temp: 36,5^{0}c pemeriksaan tersebut sesuai dengan teori dimana menurut teori suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,2 ^{0} sesudah partus dapat naik ± 0,5 ^{0}c dan nadi berkisar 60-80 x/i setelah partus (Suherni, 2009).

c. Kunjungan ketiga (2 minggu setelah persalinan)

Disini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, memastikanibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, memberikan konseling pada ibu tentang asuhan pada bayi untuk menjaga kesehatan bayi dan menjaga bayi agar tetap hangat.

Mada masa nifas Ny. C 2 minggu prosesnya berlangsung dengan normal. Tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus masa involusi dan penurunan fundus sesuai dengan teori dimana tinggi fundus uteri (TFU) pada kunjungan 2 minggu post partum tinggi fundus uteri (TFU) sudah tidak teraba lagi. Menurut teori Marni, 2014 tinggi fundus uteri (TFU) masa nifas 2 minggu adalah tidak teraba lagi (Ai Yeyeh Rukiyah, 2012).

Pengeluaran lochea pada Ny. C berjalan dengan normal tidak ada kesenjangan dengan teori dimana pengeluaran lochea pada 2 minggu post partum adalah lochea serosa yang berwarna kekuningan/kecoklatan. Pada masa nifas Ny. C, ibu masih melakukan perawatan payudara tidak terjadi kesenjangan dengan teori Sari, 2014 dimana tujuan dari perawatan payudara ini adalah untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencgah tersumbatnya saluran susu,ssehingga pengeluaran air susu ibu (ASI) lancar (Ai Yeyeh Rukiyah, 2012).

d. Kunjungan ke empat (6 minggu setelah persalinan)

Pada kunjungan ini bidan menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ia atau bayi alami dan memberikan konseling untuk menggunakan kontrasepsi secara dini untu menjarangkan kehamilan.

Pada masa nifas Ny. C 6 minggu prosesnya berlangsung dengan normal. Tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus masa involusi dan penurunan fundus sesuai dengan teori dimana tinggi fundus uteri (TFU) pada kunjungan 6 minggu post partum tinggi fundus uteri (TFU) sudah tidak teraba lagi. Menurut teori Marni, 2014 tinggi fundus uteri (TFU) masa nifas 6 minggu adalah tidak teraba lagi.

Pengeluaran lochea pada Ny. C berjalan dengan normal tidak ada kesenjangan dengan teori dimana pengeluaran lochea pada 6 minggu post partum adalah lochea alba yang berwarna putih hal ini sesuai dengan teori Sari dimana pengeluaran lochea pada 6 minggu post partum adalah lochea alba yang berwarna putih (Eny Retna Ambarwati, 2008).

Pada masa nifas Ny. C ibu masih melakukan perawatan payudara. Dimana tidak ada kesenjangan dengan teori Sari, 2014 dimana tujuan dari perawatan payudara ini adalah untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah

tersumbatnya saluran susu sehingga pengeluaran air susu ibu (ASI) lancar.(Eny Retna Ambarwati, 2008).

Pada Ny. C dilakukan pemeriksaan vital sign dan hasilnya normal terlihat TD: 110/80 mmHg, Pols: 80x/i, Temp: 36,5^{o}c pemeriksaan tersebut sesuai dengan teori dimana menurut suhu tubuh wanita inpartu tidak lebih dari 37,2 ^{0}c. Sesudah partus dapat naik kurang lebih 0,5 ^{0}c dan nadi berkisar antara 60-80 x/i setelah partus.

Tujuan asuhan masa nifas yang dilakukan yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupin psikologis, melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi sehari-hari, memberikan pelayanan keluarga berencana, mendapatkan kesehatan emosi.

4.4. Bayi Baru Lahir

Bayi Ny. C lahir spontan pada tanggal 20 November2024 pukul 09.20 WIB, menangis kuat dan warna kulit kemerahan, jenis kelamin Perempuan, tidak ada cacat kongenital, berat badan 3200 gram, panjang badan 47 cm.

Asuhan segera yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah bebaskan jalan nafas, mengeringkan bayi, memotong tali pusat, menjaga kehangatan bayi, pemberian ASI, pencegahan infeksi dan pemberian imunisasi (Depkes, 2012).

Asuhan yang diberikan pada bayi segera setelah lahir yaitu penulis melakukan penilaian dengan cepat dan hasilnya adalah normal, maka langsung meletakkan bayi di atas perut Ny. C segera mengeringkan, membungkus kepala dan badan bayi, tali pusat kemudian dijepit dengan klem dan memotongnya. Setelah itu mengganti kain dengan kain yang bersih dan kering kemudian dilakukan IMD. Sebagai upaya profilaksis diberikan salep mata tetracyclin 1 % dan vitamin K untuk mencegah perdarahan 1 jam setelah lahir. Bayi dalam keadaan sehat dan dapat menyusui dengan baik.

Berdasarkan Riskesdas tahun 2007, sebagian besar (78,5%) kematian neonatus terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-6 hari). Terkait hal tersebut, tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan

neonatus dari semula 2 kali (satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari),menjadi 3 kali (dua kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari). Dengan perubahan ini, jadwal kunjungan neonatus dilaksanakan pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Pelayanan kesehatan neonatal ini diantaranya adalah untuk perawatan tali pusat yang dapat bermanfaat untuk mencegah tetanus neonatorum digambarkan dengan indikator cakupan kunjungan neonatal.

a. Kunjungan 6 jam pertama setelah persalinan.

Pada kasus Ny. C bayi lahir spontan, menangis kuat, tidak ada cacat bawaan, warna kulit kemerahan. Jenis kelamin Perempuan, berat badan 3200 gram, panjang badan 47 cm, A/S 10/10, ekstrimitas (+)/(+), pergerakkan aktif, anus (+), ditandai dengan keluarnya mekonium dan bayi sudah buang air kecil dan buang air besar dengan normal. Hal ini sesuai dengan kepustakaan yang menerangkan bahwa bayi yang sehat akan menangis kuat, bernapas, menggerakkan tangan dan kakinya dan kulit bewarna kemerahan.

Ketika bayi lahir, pengikatan tali pusat dilakukan dengan menggunakan benang tali pusat dalam keadaan steril sesuai dengan teori (Prawirohardjo, 2013) Dengan melakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar maka tetanus neonatorum dapat terhindarkan. Setelah bayi lahir, bayi tidak langsung dimandikan.

By Ny. C hanya dibersihkan dan segera diselimuti serta ditutupi bagian kepalanya dengan kain bersih, kering, dan hangat agar bayi terhindar dari hipotermi atau kehilangan panas. Hal ini sesuai dengan teori kepustakaan Sarwono tahun 2009, untuk tidak memandikan bayi minimal 6 jam setelah lahir untuk mencegah hipotermi. Bayi sudah menyusui setelah ± 2 jam setelah persalinan. Berat badan bayi 3200 gram merupakan berat badan bayi normal. Hal ini sesuai dengan teori Rukiyah tahun 2012, bahwa berat bayi normal adalah 2500-4000 gram.

Untuk mencegah perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir maka bidan memberikan vit K parenteral dengan dosis 0,5 sampai 1 mg IM pada bayi Ny. O maka tidak ada kesenjangan teori dengan praktek yang di lakukan. Karena menurut Saifuddin 2012, semua bayi baru lahir normal dan

cukup bulan dapat di berikan vit K parenteral dengan dosis 0,5 sampai 1 mg IM pada bayi.

b. Kunjungan 6 hari bayi baru lahir

Pada bayi Ny.C pemberian ASI eksklusif masih berjalan dengan baik ibu mau memberikan bayinya ASI eksklusif selama 6 bulan. Hal ini sesuai dengan teori Sari tahun 2014, ASI eksklusif yaitu bayi hanya diberi ASI selama 6 bulan, Setelah 6 bulan barulah diberi makanan pendamping ASI (MPASI).

Asuhan yang dilakukan penulis dalam setiap kunjungan adalah memberikan konseling tentang menjaga kehangatan dan kebersihan bayi, pemberian ASI, perawatan tali pusat yaitu dengan cara membersihkan dan mengeringkan setelah bayi dimandikan kemudian dibungkus dengan kain kassa, mengganti popok bayi jika basah dengan popok yang kering. Serta ibu juga masih tetap melakukan perawatan tali pusat terlihat dari tali pusat bayi tampak kering dan tidak ada terjadi infeksi. Dalam hal ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan asuhan yang diberikan. Karena semua asuhan yang dilakukan sesuai dengan standart (Sari, 2014)

c. Kunjungan 2 minggu setelah persalinan

Ny. C masih tetap menjaga suhu tubuh bayinya karena setiap popok bayi basah ibu langsung menggantinya dengan yang kering. Hal ini sesuai dengan teori Prawirohardjo tahun 2013, dimana bayi yang masih berumur 28 hari masih tetap harus dipantau suhu tubuh karena bayi baru lahir masih rentan kehilangan suhu tubuh. Serta ibu sudah bisa membawa bayinya ke Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi BCG dan Polio 1 karena imunisasi sangat penting untuk kekebalan tubuh bayi.

Dalam hal ini tidak ada kesenjangan teori dengan asuhan yang diberikan karena semua asuhan yang diberikan sesuai dengan standart(Prawirohardjo,2013) Setelah penulis melakukan kunjungan dan asuhan kepada bayi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bayi dalam keadaan sehat tanpa komplikasi apapun.

4.5. Keluarga Berencana

Asuhan keluarga berencana yang dilakukan pada keluarga Tn. S dan Ny. C dilakukan untuk menunda kehamilan. Dimana Ny. C menginginkan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI karena ingin memberikan ASI Eksklusif kepada

bayinya. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan konseling tentang jenis alat – atal kontrasepsi, keuntungan, efek samping dan cara kerja menggunakan alat kontasepsi yang tidak mengganggu pemberian ASI.

Setelah diberikan konseling akhirnya Ny. C memilih untuk menggunakan Metode Amnorea Laktasi. MAL memiliki efektifitas sangat tinggi sekitar 98% apabila digunakansecara benar dan memenuhi persyaratan, yaitu digunakan selama enam bulanpertama setelah melahirkan, belum mendapat haid pasca melahirkan danmenyusui secara eksklusif (Proverawati, Islaely dan Aspuah, 2015).Dimana cara kerja MAL adalah menunda ataumenekan terjadinya ovulasi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu(ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya dan digunakan untuk menunda kehamilan selama 6 bulan setelah melahirkan dengan memberikan ASI eksklusif. Keuntungan pemakaian kontrasepsi ini adalah tidak memerlukan prosedur khusus, dapat segera dimulai, tidak mengganggu senggama, mudahdigunakan, tidak perlu biaya, tidak ada efek samping sistemik dan tidakbertentangan dengan budaya serta agama. Adapun keterbatasan daripenggunaan MAL, yaitu perlu persiapan sejak dini, hanya dapat digunakanselama 6 bulan dengan catatan pemberian ASI eksklusif secara penuh danbelum haid, tidak melindungi dari penyakit menular seksual, dan kesulitanmempertahankan ASI eksklusif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Asuhan antenatal care yang diberikan kepada Ny. C pada usia kehamilan 38 minggu sudah sesuai dengan program pemerintah ANC minimal dilakukan 4 kali kunjungan selama hamil Ny. C melakukan kunjungan antenatal care (ANC) sebanyak 4 kali selama hamil. Kunjungan yang dilakukan Ny. C sudah memenuhi kunjungan antenatal yang setandar 4 kali yaitu 1 kali kunjungan trimester I, 1 kali kunjungan pada trimester II, dan 2 kali kunjungan pada trimester III.

   Pada saat memberikan asuhan ANC. Selama kehamilan tidak ada keluhan yang serius.
2. Asuhan intranatal care pada Ny. C dari kala I sampai kala IV belum sesuai dengan asuhan persalinan normal 60 langkah APN, tidak dilakukan sanggah susur. Ibu dan bayi lahir tanpa ada penyulit maupun komplikasi.
3. Asuhan kebidanan pada ibu nifas dilakukan sebanyak 4 kali dengan tujuan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, mencegah dan mendeteksi, serta menangani masalah-masalah yang terjadi. Selama memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas tidak ditemukan adanya masalah atau komplikasi.
4. Asuhan bayi baru lahir Ny. C yang dilanjutkan dengan asuhan kebidanan 2 jam, 6 jam, 2 hari dan 2 minggu post natal tidak ditemukan masalah atau komplikasi.
5. Asuhan keluarga berencana yang diberikan pada Ny. C adalah pendidikan kesehatan tentang MAL (Metode Amnorea Laktasi) dan ibu bersedia melaksanakan metode tersebut untuk menunda kehamilan.

5.2. Saran

1. Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan harus bisa malakukannya secara *continuity care* diharapkan setelah melakukan manajeman asuhan kebidanan kita dapat membuat dokumentasi sesuai dengan 7 langkah

2. Helen varney , pada ibu bersalin diharapkan membuat patofgraf sesuai dengan asuhan agar tidak terjadi masalah dalam persalinan. Bagi ibu dan keluarga
3. Bagi profesi bidan

   Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meng-update ilmu dan menerapkan ilmu terbaru pada klien

4. Bagi pendidikan

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan materi yang telah diberikan baik dalam proses perkuliahan maupun praktik lapangan. Sehingga mahasiswa mampu menerapkan secara langsung dan berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan pendekatan manajemen kebidanan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidan

4. Bagi penulis

   Senantiasa memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah didapat serta menggunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan asuhan secara berkesinambungan yang di mulai pada ibu hamil TM III, sehingga menambah wawasan dan sebagai proses persalinan, nifas, dan Bayi Baru Lahir dapat berjalan fisiologis atau patologis.

5. Bagi ibu dan keluarga

   Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bahwa pemeriksaan dan pemantauan kesehatan sangat penting khususnya pada masa kehamilan, masa bersalin, masa nifas, dan masa bayi baru lahir sehingga ibu mengerti tentang kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ani,L.S.2013.*AnemiaDefisiensiBesi:MasaPrahamildanHamil*.Jakarta: EGC.

Arum, Dyah, N.S., dan Sujiyatini. 2016. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Yogyakarta: NuhaMedika.

DinkesSumut.2015. *ProfilKesehatanProvinsi SumateraUtara2015*.Medan: Dinas Kesehatan SumateraUtara

Hutahaean, S. 2013.*Perawatan* Antenatal. Jakarta: SalembaMedica.

Indriyani, D. 2013. *Aplikasi Konsep dan Teori Keperawatan Maternitas Postpartum dengan Kematian Janin*. Yogyakarta:Ar-RuzzMedia

Jannah, N. 2017. *Persalinan Berbasis Kompetensi*. Jakarta: EGC.

Kemenkes RI. 2015a. *Profil Kesehatan Indonesia 2015*. www.depkes.go.id (diakses 15 Januari 2017). 2015b. *Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019*. www.depkes.go.id(diakses 15 Januari 2017) . 2013. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*.Jakarta: Kementrian Kesehatan.

Mandriwati, A.G., dkk. 2017. *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Kompetensi*. EdisiRevisiIII. Jakarta: EGC.

Mangkuji,B., dkk. 2014.*Asuhan Kebidanan 7 Langkah*SOAP. Jakarta: EGC. Marmi. 2015. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Puerpurium Care"*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Marmi dan Rahardjo, K. 2015. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*.Yogyakarta: PustakaPelajar.

Pratami,E.2014.*KonsepKebidananBerdasarkanKajianFilosofidanSejarah*. Magetan : ForumIlmiahKesehatan.

Proverawati, A., Islaely, A.D., dan Aspuah, Siti. 2015. *Panduan Memilih Kontrasepsi*. Yogyakarta: NuhaMedika.

Saifuddin,AB.,dkk.2013.*BukuAcuanNasionalPelayananKesehatanMaternal dan Neonatal*. Jakarta: PT. Bina PustakaSarwonoPrawihardjo.

Sari,E.P.,danRimandini,K.D.2014.*AsuhanKebidananPersalinan(Intranatal*

Care). JakartaTimur: CV. TransInfoMedia

Sofian, A. 2012.*Sinopsis Obstetri*. Edisi3. Yogyakarta: EGC

Sukarni,I.,danMargareth.2016.*Kehamilan,PersalinandanNifasDilengkapi dengan Patologi*. Yogyakarta: NuhaMedika..

Tandon, N.M.2016.*Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi danAnakBalita*. Jakarta: EGC.

WagiyodanPutrono.2016.*AsuhanKeperawatanAntenatal,IntranataldanBayi*

Baru Lahir Fisiologis dan Patologis. Yogyakarta: Andi.

Walyani,E.S.2015.*AsuhanKebidananpadaKehamilan*.Yogyakarta:Pustaka

Baru Press.

Walyani,E.S.,danPurwoastuti,E.2015.*AsuhanKebidananMasaNifasdan*

SOAP

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. R USIA 28 TAHUN G2P1A0 USIA KEHAMILAN 37 MINGGU 2 HARI DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal pengkajian : 03 November2024 **Pukul : 08.00 WIB**

Data Subyektif

Identitas

Nama Ibu	**: Ny. R**	**Nama Suami**	**: Tn. V**
Umur	**: 28 tahun**	**Umur**	**: 28 tahun**
Suku/Bangsa	**: Batak/Indonesia**	**Suku/Bangsa**	**: Batak/Indonesia**
Agama	**: Islam**	**Agama**	**: Islam**
Pendidikan	**: SMA**	**Pendidikan**	**: SMA**
Pekerjaan	**: IRT**	**Pekerjaan**	**: Wiraswasta**
Alamat	**: Desa Gedung Johor**		

Alasan Kunjungan: Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya.

Keluhan Utama: Ibu mengatakan sering sakit pinggang, sering kencing, dan susah tidur.

Riwayat Menstruasi

Menarche	: 12 tahun
Siklus Haid	:28 hari
Lama Haid	: 7 hari
Sifat Darah	:Merah Kehitaman
Banyak Darah	: 3x ganti pembalut/hari
Dismenorhea	:Tidak Pernah
Fluor Albus	: Tidak Pernah

Riwayat Kehamilan Sekarang

HPHT	: 15 Februari 2024	TTP	: 03 November 2024
Imunisasi	: TT1 : 15 Februari 2024	TT2	: 05 Februari 2024

Riwayat Kesehatan

Riwayat Penyakit Yang Pernah Diderita : Ibu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menderita penyakit apapun

Ibu mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah menderita penyakit apapun

Data Obyektif

Pemeriksaan Umum

a. Tanda-tanda Vital

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi :80 kali permenit

Suhu : 36,5˚ C

Pernafasan :20 kali permenit

b.Keadaaan Umum : Baik

c. Kesadaran : Composmentis

Pemeriksaan Antropometri

a. Berat Badan : 61 kg BB sebelum hamil : 50 kg

b. Tinggi Badan : 156 cm

c. Lingkar Lengan Atas : 25 cm

Pemeriksaan Fisik

Muka :Tidak ada cloasma gravidarum, tidak pucat dan tidak terdapat oedema

Mata : Konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterus dan tidak ada oedema palpebra

Mulut dan Gigi : Bersih dan tidak ada karies gigi

Leher : Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, kelenjar limfe, tidak ada bendungan vena jugularis

Payudara : Asimetris, puting menonjol, areola mamae hiperpigmentasi, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan dan kolostrum belum keluar.

Abdomen : Tidak terdapat linea nigra dan linea alba, ada bekas operasi dan tidak ada nyeri tekan.

Leopold 1 : Teraba bagian lunak dan tidak melenting di fundus dengan

TFU : 33 cm.

Leopold 2 : Pada bagian perut sebelah kiri teraba bagian memanjang dan memapan, sedangkan pada perut sebelah kanan teraba bagian kecil janin.

Leopold 3 : Teraba bagian bulat, keras dan melenting

Leopold 4 : Bagian terbawah janin sudah masuk PAP (Divergen).

DJJ : 138 x/i

TBBJ : (33 – 12) x 155 = 3255 gram.

Puctum Max : Kuadran kiri bawah

Perineum : Bersih dan tidak ada bekas jahitan

Genetalia: Tidak terdapat oedema

Ekstermitasn: Atas : Tidak terdapat oedema

Bawah : Terdapat oedema dan tidak ada varices

II. INTERPRETASI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

A. Diagnosa

Ny. D G2P1A0, Usia kehamilan 37 minggu 2 hari, PUKI, persentase kepala,janin tunggal,divergen, janin hidup, intrauterine, ibu dan janin dalam keadaan sehat

Dasar :Data Subyektif : Ibu mengatakan HPHT 15 Februari 2024

Data Obyektif : Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TD:120/90mmHg, nadi : 82 x/i, suhu : 36,5˚ C, pernafasan : 23 x/i.

B. Masalah

"Tidak ada"

C. Kebutuhan

- KIE tentang fisiologis kehamilan TM III
- KIE Persiapan persalinan

III. ANTISIPASI MASALAH/DIAGNOSA POTENSIAL

"Tidak ada"

IV.IDENTIFIKASI KEBUTUHAN AKAN TINDAKAN SEGERA

"Pantau kehamilan secara rutin."

V. PERENCANAAN

Diagnosa : Ny. R G2P1A0, Usia kehamilan 37 minggu 2 hari, PUKI, persentase kepala, janin tunggal, divergen, janin hidup, intrauterine, ibu dan janin dalam keadaan sehat

1. **Lakukan pendekatan kepada ibu supaya terjalin hubungan yang baik tidak lupa melakukan 5 S dan menanyakan keluhan ibu**

2. **Beritahu kondisi ibu saat ini**
3. **Berittahu ibu fisiologis Kehamilan**
4. **Beritahu penyebab dan cara mengatasi semua keluhan ibu**
5. **Beritahu persiapan persalinan**
6. **Beritahu kapan tafsiran persalinan ibu**
7. **Beri semangat pada ibu serta ajak keluarga untuk memberikan support**

VI. PELAKSANAAN

1. **Melakukan pendekatan terapeutik pada ibu dengan cara memperkenalkan diri, menanyakan keluhan, menggali informasi dengan menggunakan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).**
2. **Memberitahukan kondisi ibu saat ini bahwa kondisi ibu baik begitu juga dengan kondisi bayi dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan**
3. **Memberitahukan kepada ibu fisiologis kehamilan bahwa kehamilan itu alami dimana seluruh proses fungsi tubuh untuk pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sperma hingga tumbuhlah menjadi janin dan pada waktu tertentu akan dikeluarkan dari uterus**
4. **Memberitahukan kepada ibu bahwa keluhan yang dialami ibu itu adalah fisiologis untuk TM 3 seperti sakit pada pinggang, sering kencing itu semua disebabkan karena semakin bertambahnya besar janin didalam perut ibu sehingga menekan semua organ yang ada dalam tubuh ibu seperti kandung kemih sehingga menyebabkan ibu sering kencing itu adalah fisiologis, akan tetapi jika keluhan ibu susah tidur cobalah untuk ibu tenang dang tidak stress sehingga ibu bisa isterahat, jangan membiarkan ibu tidur larut malam karna itu tidak baik untuk ibu hamil.**
5. **Memberitahukan persiapan persalinan baik materi maupun psikologis ibu, dari segi materi ibu harus mempersiapkan tabumil atau ibu jika memiliki BPJS atau KIS bisa digunakan, dalam segi psikologis ibu bisa mental dalam persalinan didukung oleh keluarga dan bidan supaya ibu tidak merasa takut dalam menghadapi persalinan serta memberitahukan**

kepada ibu apa itu persalinan karena persalinan itu adalah fisiologis jadi tidak ada yang perlu ditakutkan

6. **Memberitahukan tafsiran persalinan ibu yaitu 20 November2024 tafsiran persalinan bisa lebih atau kurang dua minggu dan usia kehamilan normal itu sampai 42 minggu**
7. **Memberikan motivasi kepada ibu serta mengajak keluarga agar selalu mensuport ibu**

VII. EVALUASI

1. **Ibu merasa nyaman dengan pendekatan yang dilakukan oleh bidan.**
2. **Ibu mengatakan sudah mengerti dengan kondisinya saat ini.**
3. **Ibu berterimakasih atas pemeriksaan yang dilakukan dan mengerti dengan penjelasan tenaga kesehatan serta keluarga akan selalu mensuport ibu**
4. **Ibu mengatakan akan melakukan kunjungan ulang**

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA
IBU BERSALIN NORMAL DI KLINIK KURNIA KECAMATAN
DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Hari/tanggal : 03 November 2024

Pukul : 08.00 WIB

Pengkajian

Data Subyektif

Identitas

Nama Ibu	: Ny. R	Nama Bapak	:Tn. V
Umur	: 28 tahun	Umur	: 28 tahun
Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia	Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta

Anamnese (Data Subjektif)

Alasan datang : Ibu merasa mules,nyeri bagian bawah perut, ingin segera melahirkan

Tanda- tanda bersalin Kontraksi: Ada sejak Pagi

Tanggal	: 05 November2024	Pukul	: 08.00 WIB
Frekuensi	: 4x setiap 10 menit	Lamanya	: 35 detik

Lokasi nyeri : Bagian bawah perut menjalar hingga kepinggang

Kekuatan : Kuat

Pengeluaran pervaginam : Keluar Lendir bercampur darah

Riwayatkehamilan sekarang

HPHT : 19 Desember 2021

ANC : Teratur dengan frekuensi : 1-2 x/bulan

Pemeriksaan Fisik (Data objektif)

Tanggal : 26 November2024 Pukul : 22.10 WIB

Penampilan fisik : Baik

Keadaan Emosional : Stabil

Pemeriksaan fisik umum

BB: 61 Kg

TB: 156 Cm

BB Sebelum hamil : 50 Kg

Tanda vital

TD : 120/70 mmHg Pernafasan : 22 X/menit

Denyut nadi : 81 X/menit Suhu : 36,6 ^{o}C

1. Pemeriksaan khusus kebidanan (Kala I)

Palpasi uterus : TFU : 31 Cm

Kontraksi : 4x10'x35"

Fetus : Letak : Memanjang, Presentase : Kepala

Posisi : Kepala berada di pintu atas panggul punctum maximum sebelah kiri (PUKI) dan , Sudah memasuki pintu atas panggul (PAP).

Penurunan : Bagian terbawah 2/5, Pergerakan : Ada & Aktif,

Tafsiran berat janin : 3255 gram

DJJ : Ada/terdengar

Frekuensi : 145x/i

Punctum maximum : Kuadran kiri bawah pusat (PUKI)

Pemeriksaan dalam : Ada

Pukul : 22.20 WIB Oleh : Bidan

Atas indikasi : Menilai pembukaan, Penurunan kepala janin, dan selaput ketuban

Dinding vagina : Mengalami perlunakan

Portio : Teraba

Posisi portio : Antefleksi

Pembukaan serviks : 6 Cm

Konsistensi : Lembek

Penurunan bagian terbawah: 2/5

Presentase fetus : UUK kiri Depan

Spina ischiadica : Tumpul/tidak teraba

Promontorium : Tidak teraba

Linea inominata : Teraba 2/3

Arcus pubis : > 90°

II. INTERPRETASI DATA, DIAGNOSA, MASALAH, DAN KEBUTUHAN

Dx : Ny. R G2P1A0, usia kehamilan 37 minggu 5 hari , intrauteri, PUKI, janin tunggal, janin hidup, persentase kepala, divergen, KU ibu baik, inpartu kala I fase aktif

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : Informed consent dan informed choice, dukungan suami, keluarga dan tenaga kesehatan serta asuhan sayang ibu.

III. IDENTIFIKASI MASALAH ATAU DIAGNOSA POTENSIAL

"Tidak Ada"

IV.ANTISIPASI DAN TINDAKAN SEGERA

"Tidak Ada"

V.PERENCANAAN

1. Informasikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik.
2. Beri dukungan pada ibu dan keluarga supaya tetap tenang dalam menghadapi persalinan.
3. Melakukan informed conset dan informed choice.
4. Beritahu ibu cara meneran yang baik dan benar.
5. Persiapan alat-alat persalinan
6. Followup TTV setiap 1 jam, pasang infus RL 500 ml.

VI.PENATALAKSAAN

1. Menginformasikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan ibu dan janin baik.

   Keadaan emosional : Stabil

   TD : 110/70 mmHg RR :22 x/menit

   HR : 82 x/ menit Temp : 36,6° C

Kontraksi: 4x10’x45” DJJ : 145 x/menit

2. Memberi dukungan pada ibu secara moral, spiritual supaya persalinan berjalan lancer tanpa suatu hambatan.
3. Memberitahu ibu cara meneran yang baik dan benar.
   - Apabila ada his anjurkan ibu untuk tarik napas panjang, tahan napas dan mengangkat kepala lalu melihatperut ibukemudian meneran seperti akan BAB dan jangan meneran pada leher.
   - Apabila tidak ada his anjurkan ibu untuk istirahat, makan, minum, dan pantau DJJ.
   - Anjurkan keluarga untuk memberi dukungan.
4. Mempersiapkan alat-alat persiapan persalinan dari saf 1, 2, 3 serta perlengkapan lainnya, Mempersiapkan alat perlengkapan ibu&bayi, Memantau kemajuan persalinan dengan partograf dan mengfollow up TTV ibu setiap satu aajam dan keadaan umum ibu serta memasang infus RL 500 mg.

VII.EVALUASI

1. Ibu dan keluarga sudah mengetahui hasil pemeriksaan keadaan ibu dan janin baik.
2. Ibu sudah mengetahui cara meneran yang baik dan benar
3. Ibu dan keluarga sudah menandatangani surat persetujuan tindakan

PENGKAJIAN KALA II

Tanggal : 03 November2024 Pukul : 11.10 WIB

Anamnese (Data subjektif)

Keinginan meneran : Ada

Perasaan adanya tekanan pada anus/vagina : Ada

Rasa nyeri : Ada

Pemeriksaan Fisik (Data objektif)

Penampilan fisik : Baik Keadaan emosional : Stabil

Tanda vital

TD: 120/80 mmHg, Nadi : 81x/i, RR : 21 x/i, Temp: 36,0 ^{o}C

Pemeriksaan kebidanan

1. Abdomen : Adanya his dengan Frekuensi : 5x10'x45", Lamanya : 45 detik, DJJ: 148 x/i Reguler
2. Genitalia : Perineum menonjol, Vulva membuka, pembukaan : 10 cm

II.INTERPRETASI DATA, DIAGNOSA, MASALAH, DAN KEBUTUHAN

Dx : Ibu inpartu kala II.

DS : Ibu mengatakan adanya perasaan ingin meneran, Ibu merasakan ada tekanan pada vulva

Ibu mengatakan rasa sakit semakin sering.

DS: Terlihat tekanan pada anus, perenium menonjol, dan vulva membuka.

Masalah : Rasa sakit menghadapi persalinan.

Kebutuhan: Dukungan suami, keluarga, dan tenaga kesehatan serta asuhan sayang ibu.

III. IDENTIFIKASI MASALAH ATAU DIAGNOSA POTENSIAL

"Tidak Ada".

IV.ANTISIPASI MASALAH DAN TINDAKAN SEGERA

"Tidak Ada".

V.PERENCANAAN

- Informasikan kepada ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik.
- Beritahu ibu macam-macam posisi bersalin yang nyaman pada saat proses persalinan.
- Persiapkan alat dan bahan untuk proses persalinan
- Persiapan kelengkapan ibu dan bayi
- Pantau kemajuan persalinan dengan partograph.

VI.PENATALAKSAAN

- Menginformasikan kepada ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan baik.

  Keadaan emosional : Stabil, TD: 120/90 mmHg, RR: 21 x/menit,

  HR : 80 x/menit, Temp : 36,5℃

  Pemeriksaan dalam : Hasil pemerikasaan dalam teraba pembukaan serviks 10 cm.
- Memberitahu ibu posisi yang nyaman yaitu Posisi berbaring dengan menarik kedua paha keatas, mukaibu aamenatap keperut ibu (litotomi). Posisi ini adalah posisi yang nyaman digunakan ibu bersalin.Posisiaberjalan, aaberdiri,bersandar efektif untuk menunda stimulasi kontraksi uterusmengurangi rasa nyeri yang hebat.Posisi aaberlutut/ merangkak dapat mengurangi rasa sakit, membantu bayi melakukan rotasi posisi yang diharapkanubun-ubun kecil berada didepan mengurangi keluhan hemoroid.Posisi duduk/ setengah duduk memanfaatkan aagaya gravitasi untuk membantu turunnya bayi, memberi kesempatan istirahat disela kontraksi.Posisijongkok, posisi ini menggunakan gaya gravitasi untuk membantu turunnya bayi melebarkan rongga panggul.Posisi berbaring kekiri dan memegang paha kearah atas dan menariknya dapat mempercepat penurunan bayi aamelebarkan rongga panggul
- Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga serta memberi dukungan pada ibu.
- Menghadirkan pendamping persalinan di dekat ibu.
- Membimbing ibu untuk meneran saat ada his dan jika ibu mempunyai dorongan meneran sembari memberi pujian pada ibu dan mengajurkan ibu istirahat apabila tidak ada his sambil memberi ibu minum
- Menolong persalinan dengan teknik APN.
- Meletakkan bayi di atas perut ibu, mengeringkannya dan melakukan pemotongan persalinan kemudian dijepit dengan umbilical cord.
- Melakukan IMD pada bayi.
-

PENGKAJIAN KALA III

Tanggal : 05 November2024 Pukul: 14.30 WIB

Anamnese (Data subjektif)

Rasa ingin meneran dan rasa mules

Pemeriksaan fisik (Data objektif)

Keadaan umum : Baik Keadaan Emosional : Stabil

Tanda Vital TD : 110/80 mmHg, Pols: 78 x/i, RR: 20 x/i, Temp: 36,6 ^{o}C

Pemeriksaan kebidanan

Abdomen : TFU setinggi pusat

konsistensi: Keras

kandung kemih: Kosong

Tali pusat: Memanjang pengeluaran darah pervaginam, semburan darah tiba-tiba

II.INTERPRETASI DATA, DIAGNOSA, MASALAH, DAN KEBUTUHAN

Dx : Ibu inpartu kala III

DS : Ibu mengatakan perutnya masih terasa mulas.

DO:

- Terlihat adanya semburan darah tiba-tiba.
- Tali pusat semakin memanjang.
- Terlihat perubahan tinggi fundus.

Masalah : Tidak ada

Kebutuhan : Manajemen aktif kala III.

III.IDENTIFIKASI MASALAH/ DIAGNOSA POTENSIAL

“Tidak Ada.”

IV.ANTISIPASI MASALAH DAN TINDAKAN SEGERA

“Tidak Ada.”

V.PERENCANAAN

- Informasikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan ibu dalam keadaan baik
- Lakukan manajemen aktif kala III.

- Periksa kelengkapan plasenta.
- Lakukan masase fundus.

VI.PENATALAKSANAAN

- Menginformasikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan ibu dalam keadaan baik. Keadaan umum baik, TTV :TD: 110/70 mmHg, R: 20 x/menit, HR: 79 x/menit, Temp: 36,0°C TFU : Setinggi pusat, Uterus: Keras
- Melakukan manajemen aktif kala III yaitu Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 3-5 cm darivulva, Letakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu ditepi atas simfisis untuk memdeteksi tangan lain menegangkan tali pusat, Setelah uterus berkontraksi tegangkan tali pusat kearah bawah sumbu tangan lain mendorong kearah atas (dorsokranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya, Lakukan penegangan atau dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar ilantai dan kemudian kearah atas mengikuti proses jalan lahir (tetap lakukan dorsokranial), Jika tali pusat bertambah panjang,pindahkan klem sejarak 5-19 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak terlepas setelah 15 menit meregangkan tali pusat, Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. selaput plasenta lahir lakukan masase fundus. Letakkan telapak tangan difundus dan lakukan masase

PENGKAJIAN KALA IV

Tanggal : 05 November2024 Pukul:14.35 WIB

Anamnese (Data subjektif)

Perasaan : Senang

Mules : Ada

Lelah : Ada

Kedinginan : Tidak ada

Nyeri : Tidak ada

Haus : Tidak ada

Lapar : Tidak ada,

Lain-lain : Tidak ada

Pemeriksaan fisik (Data objektif)

Penampilan fisik	: Baik	Pucat	: Tidak
Gelisah	: Tidak	Keringat	: Ya
Gemetar	: Tidak	Nampak takut	: Tidak
Inkoheren	: Tidak	Lain-lain	: Tidak

Tanda vital **:** TD: 120/90 mmHg, Pols: 78 x/i, RR: 20 x/i, Temp: 36,7 ^{o}C

Pemeriksaan kebidanan

Abdomen : TFU: 2 jari dibawah pusat,Konsistensi uterus : Keras,bulaat,kosong

Kandung kemih : Kosong Luka jalan lahir : Tidak ada

Pengeluaran darah pervaginam : Lochea Rubra ± 50 cc

Bayi Perempuan, PB/BB : 50 cm/ 3300 gram

II.INTERPRETASI DATA, DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Dx: Ibu inpartu kala IV.

DS: Ibu mengatakan perutnya masih terasa mulas.

DO: TFU 2 jari dibawah pusat, perut terasa tegang.

Masalah: Tidak Ada

Kebutuhan: Pengawasan perdarahan dan pemantauan kontraksi uterus

III.IDENTIFIKASI MASALAH/ DIAGNOSA POTENSIAL

"Tidak Ada"

IV.ANTISIPASI MASALAH DAN TINDAKAN SEGERA

"Tidak Ada."

V.PERENCANAAN

- Beritahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan ibu dan bayi dalam keadaan baik.
- Lakukan pemantauan kontraksi uterus pada kala IV.
- Lakukan penilaian perdarahan pada kala IV.
- Lakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir.
- Berikan suntikan vit K, Imunisasi HB 0 dan Salep mata pada bayi baru lahir.
- Berikan KIE kepada ibu dan keluarga cara masase fundus dan menilai kontraksi.
- Periksa kembali keadaan ibu dan bayi.

VI.PENATALAKSANAAN

1. Menginformasikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan ibu, bayi dalam keadaan baik.Keadaan umum ibu baik,
   TD : 120/80 mmHg, HR : 78 x/menit, RR : 20 x/menit, Temp : 36,7°C, TFU 2 jari dibawah pusatUterus : Keras, dan bulat, Lochea: Rubra, pengeluara ± 50 cc
2. Melakukan pemantauan kontraksi uterus pada kala IV dengan meraba fundus uterus, jika uterus tidak berkontraksi lakukan tindakan KBI dan KBE.Melakukan penilaian perdarahan pada kala IV apabila lebih dari 500 cc maka lakukan rujukan.
3. Melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir
   BB: 3300 gram Temp : 37°C,PB: 50 cm HR : 140 x/menit
   LK: 33 cm RR : 40 x/menit LD : 31 cm
   LILA : 12 cm Anus: + Bayi menangis kuat
4. Melakukan suntikan vit K 1 mg/IM dipaha kiri bagian luar, 1 jam kemudian lakukan penyuntikan imunisasi HB 0 secara IM dipaha kanan bagian luar dan berikan salep mata pada kedua mata bayi.
5. Memberikan KIE kepada ibu dan keluarga untuk masase uterus dan cara menilai kontraksi dengan baik. Apabila uterus terasa tegang dan keras berarti uterus berkontraksi dengan baik, namun apabila uterus teraba lembek berarti uterus tidak berkontraksi.

6. Memeriksakan kembali keadaan ibu dan bayi baru lahir.

   TTV dalam batas normal, periksa kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan sekitar 30 menit selama jam ke 2 selama persalinan.Keadaan bayi untuk memastikan bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh bayi normal (36,5℃-37,5℃) dan membuat bayi rooming in atau rawat gabung antara ibu dan bayi untuk meningkatkan bounding attachment antar ibu dan bayi.

VII.EVALUASI

1. Ibu dan keluarga sudah mengetahui hasil pemeriksaan dalam keadaan baik Uterus berkontraksi dengan baikTidak ada perdarahan ubnormal
2. Bidan sudah melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir
3. Bidan sudah memberikan suntikan vit K, imunisasi HB 0 dan salep mata pada bayi baru lahir.
4. Bidan sudah memberikan KIE kepada ibu dan keluarga dan Ibu juga keluarga sudah mengerti cara masase fundus dan menilai kontraksi
5. Keadaan ibu dan bayi dalam keadaan baik.

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS PADA NY. R P2A0
DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Hari/Tanggal : 20 November 2024
Jam : 08.05 WIB

I. PENGUMPULAN DATA

A. Identitas Biodata

Nama Ibu	: Ny. R	Nama Bapak	:Tn. V
Umur	: 28 tahun	Umur	: 28 tahun
Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia	Suku/Bangsa	: BatakIndonesia
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta

B. Anamnese (Data Subjektif)

1. Keluhan Utama : Perut masih Mules
2. Riwayat persalinan
    - Tempat melahirkan : Puskesmas
    - Tanggal melahirkan : 05 November2024
    - Jenis persalinan : spontan / normal
    - Penolong : Bidan
    - Lama persalinan : 10 Jam
3. Bayi
    - Lahir : 05 November2024
    - BB : 3255 gram
    - PB : 50 cm
    - Cacat bawaan : Tidak ada
    - Masagestasi : Tidak ada
    - Bayi rawat gabung dengan ibunya : Iya
4. Riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu : P2A0
5. Pola makan/minum

- Frekuensi : 1 x (4 jam yang lalu) biasa 3x sehari
- Jenis makanan : sayur,ikan,nasi,susu,buah,air putih
- Porsi : 1 porsi
- Keluhan : Tidak ada

6. Pola eliminasi
   - BAK : 1x (jam 08.00 WIB tadi) biasa 2x/h
   - Warna : kuning jernih
   - Frekuensi : 4x sehri
   - BAB : Sekarang belum ada(biasa 1 x sehari)
   - Keluhan : Tidak ada
7. Pola istirahan/Tidur
   - Tidur malam : 8 jam
   - Tidur siang : 3 jam
   - Gangguan tidur : tidak ada
8. Status psikologi
   - Respon ibu pengalaman persalinan : Baik
   - Respon ibu terhadap bayi : Baik
   - Hubungan ibu dan bayi : Baik
   - Kekhawatiran khusus : Tidak ada
   - Taking in : Sudah dilakukan
   - Taking hold : Belum dilakukan
9. Mobilisasi : Sudah dilakukan Baik

C. Data Objektif

1. Keadaan umum : Baik
   - Kesadaran : Compos mentis
   - Keadaan emosional : Stabil
2. Tanda-tanda vital
   - TD : 120/80 MmHg
   - Nadi : 80 x/menit

- Suhu : 36,7^{o}C
- Pernafasan : 19 x/menit

3. Mata
   - Kelopak mata : Baik
   - Konjungtiva : Tidak anemis (baik)
   - Sklera : Tidak ikterik (baik)
4. Mammae
   - Colostrum : Ada
   - Puting susu : Menonjol
   - Pembengkakan : Tidak ada
   - Rasa nyeri : Tidak ada
   - Kebersihan : Baik
   - Warna : Hyperpigmentasi
5. Abdomen
   - Bekas luka oprasi : Tidak ada
   - TFU : 2 jari dibawah pusat
   - Uterus : Baik
   - Kandung kemih : Kosong
6. Genitalia
   - Perenium
     - ✓ Robekan perenium : Tidak ada
     - ✓ Varises : Tidak ada
   - Pengeluaran pervaginam
     - ✓ Lochea : Rubra
     - ✓ Bau : Tidak ada
     - ✓ Warna lochea : Merah
7. Ekstremitas
   - Oedeme : Tidak ada
   - Varices : Tidak ada
   - Reflex patella : (+)

D. Pemeriksaan penunjang

- Hb : -
- Gol.darah : -
- Rhesu : -
- Dll : -

II. INTERPRESTASI DIAGNOSA, MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa : Ny. R 28 tahun post partum normal

Data Subjektif : Ibu mengatakan ini anak ke dua

Ibu mengatakan bahagia melahirkan bayinya

Ibu mengatakan khawatir bayinya tidak ASI Ekslusif

Data Objektif : Keadaan umum ibu baik

TD : 120/80 MmHg

HR : 80 x/menit

RR : 19 x/menit

T : 36,7^{0}C

Lochea : Rubra

Masalah : Tidak ada

III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH

"Tidak Ada"

IV. TINDAKAN SEGERA

"Tidak Ada"

V. PERENCANAAN

1. **Beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan**
2. **Nilai tanda bahaya Masa nifas**
3. **Memberitahukan cara menilai kontraksi**
4. **Memberikan penkes tentang ASI Eksklusif/ ASI awal**
5. **Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi**
6. **Memberikan penkes posisi dan teknik pemberian ASI**

VI. **PELAKSANAAN**

1. **Memberitahu ibu bahwa keadaannya baik dan dalam batas normal**
2. **Memberikan penkes tanda bahaya nifas seperti pendarahan rasa pusing pada ibu, pucat tidak BAK, TFU tidak berubah, rasa sakit di perut seperti dikoyak, dan uterus tidak berkontraksi.**
3. **Memberitahukan kepada keluarga cara menilai kontraksi ibu yaitu jika perut ibu tegang dank eras maka sedang terjadi kontraksi dimana kontraksi ini bertujuan untuk pengembalian uterus kebentuk semula atau involusi uterus**
4. **Memberikan penkes tentang ASI awal pada ibu bahwa pemberian ASI itu sangat penting dan diberikan saat habis melahirkan kalau bisa ibu harus ASI eksklusif bahwa bayi harus diberikan ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan penamping ataupun air putih.ASI sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan system syaraf.**
5. **Menjaga bayi tetap hangat agar terhindar dari hipotermi dengan cara selalu membedong bayi dengan kain kering dan bersih dan hindarkan bayi dari benda-benda sekitar yang dapat menyebabkan bayi kehilangan panas tubuhnya.**
6. **Memberitahukan teknik dan posisi menyusui yang baik seperti kepala bayi jika menyusui harus lebih tinggi dari kaki dan saat menyusui bayi usahakan untuk melakukan posisi menyusui secara duduk dan saat menyusui mulut bayi harus sampai areola.**

VII. EVALUASI

1. Ibu mengeatakan senang dan legah mengetahui hasil pemeriksaannya
2. Ibu sudah tau tanda bahaya masa nifas dan akan memanggil bidan jika terjadi hal tersebut
3. Keluarga sudah mengetahui cara menilai kontraksi
4. Ibu mau memberikan ASI pada bayinya

5. Bayi sudah dibedong dan dijaga tetap hangat
6. Ibu sudah tau teknik dan posisi menyusui

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR NY. R DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal Pengkajian : 05 November2024 Pukul : 14.05 WIB

I. PENGKAJIAN

A. Data Subyektif

1. Identitas

Nama Ibu	: Ny. R	Nama Bapak	:Tn. V
Umur	: 28 tahun	Umur	: 28 tahun
Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia	Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA	Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta

Biodata Bayi

Nama Bayi : Bayi Ny. R

Umur : 8 Jam

2. Alasan Datang

Bayi baru lahir dengan berat badan 3255 gram, umur kehamilan 37 minggu 2 hari, dan apgar score 8/9

3. Riwayat Antenatal

$G_2P_1A_0$ UK 37 minggu 2 hari dengan partus spontan, Hidup, Intrauterine.

Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas lalu

Umur Anak	Usia khmlan	Jenis Prslnan	Tmpt	Komplikasi		Pnlong	Bayi		Nifas
				Ibu	Bayi		jk	Pb/bb	
4 Tahu	39 mg 2 hari	Spontan	BPM	-	-	BDN	pr	50/3000	Normal

n									
H	A	M	I	L		I	N	I	

Riwayat ANC : Tidak teratur, dan di posyandu.

Keluhan saat Hamil : Emesis gravidarum

Penyakit Selama Kehamilan : Ibu tidak pernah menderita penyakit Hipertensi, DM, dan Anemia.

Kebiasaan makan : Makan 3 kali sehari (menu nasi, lauk pauk, Sayur).

Jamu : Tidak ada.

Merokok : Tidak ada.

Komplikasi Ibu : Tidak Ada.

Komplikasi Janin : Tidak Ada

4. Riwayat Intranatal

Lahir : 05 November2024 pukul 14.05 WIB

Jenis Persalinan : Spontan

Penolong : Bidan

Komplikasi

Ibu : Tidak ada

Janin : Baik

5. Keadaan Bayi

Keadaaan bayi tampak baik.

Caput Succadaeneum : Tidak ada

Cephal hematoma : Tidak ada

Cacat bawaan : Tidak ada

Inisiasi munyusui dini : Sudah dilakukan

DATA OBJEKTIF

A. Pemerikasaan umum

1. Pernafasan : Pernafasan reguller, RR 38 kali/menit.
2. Warna kulit : Halus, terdapat lanugo pada lengan atas dan punggung, serta Terdapat gambaran vena.

3. Denyut Jantung : Reguler, 138 kali/ menit.
4. Suhu Aksiler : 37^0C
5. Tonus otot : Baik
6. Kesadaran : Tangisan dan motorik Baik.
7. Ekstermitas : Gerakan Baik.
8. Tali pusat : Masih basah.
9. BB Sekarang : 3255 gram.

B. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Tidak terdapat caput succadaeneum, tidak terdapat cephal Hematoma.
2. Muka : Simetris, tidak oedema.
3. Mata : Simetris, tidak terdapat sekret, sklera tidak ikterus, Konjungtiva tidak pucat.
4. Telinga : Simeris dan sejajar dengan mata, tidak ada pengeluaran Cairan abnormal.
5. Hidung : Simetris, lubang hidung ada dua, tidak ada pengeluaran cairan Abnormal.
6. Mulut : Tidak sianosis, tidak ada labioskisis, dan labioplatoskisis.
7. Leher : Tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, Limfa.
8. Klavikula : Simetris.
9. Lengan tangan : Sama panjang, tidak ada polidaktili dan sindaktil, Ujung jari terlihat sianosis.
10. Dada : Bergerak bersamaan dengan dinding dada, areola Tampak Jelas.
11. Abdomen : Gerak abdomen simetris, tidak terdapat kelainan, Tali pusat masih basah.
12. Genetalia : Labia mayora dan labia minora ada, tetapi belum menutup sempurna.
13. Tungkai dan kaki : sama panjang, tidak terdapat polidaktili dan Sindaktili, ujung jari terlihat sianosis.

14. Anus : Berlubang.
15. Nilai APGAR : 8/9

C. Reflek

1. Moro : Ada
2. Rooting : Ada
3. Walking : Ada
4. Graphs : Ada
5. Sucking : Ada
6. Tonicneck : Ada

D. Antropometri

Panjang Badan : 50 cm
Lingkar Kepala : 30 cm
Lingkar Dada : 32 cm
Lingkar lengan : 12 cm

E. Eliminasi

Miksi : +, warna kekuningan.
BAB : +, konsistensi kehitaman

II. INTERPRETASI DIAGNOSA, MASALAH, DAN KEBUTUHAN

a. Diagnosa Kebidanan

Bayi baru lahir normal cukup bulan dengan Baik

Dasar Subjektif :

- **Bayi baru lahir pada tanggal 05 November2024 jam 14.05WIB**
- **HPHT ibu 15Februari 2024.**

Dasar Objektif

Keadaan umum Baik, nadi 138 kali/menit, suhu 37^0C, RR 38 kali/menit, berat badan 3255 gram.

b. Masalah

Tidak ada

c. Kebutuhan

Jaga kehangatan

III. ANTISIPASI MASALAH DAN DIAGNOSA POTENSIAL

"Tidak ada"

IV. TINDAKAN SEGERA

"Tidak ada"

V. PERENCANAAN

Tanggal : 05 November2024 Jam : 14.15 WIB

Diagnosa : bayi baru lahir cukup bulan

1. **Jaga kehangatan bayi**
2. **Lakukan pemeriksaan fisik bayi**
3. **Rawat tali pusat**
4. **Ajak ibu memberikan ASI pada bayi**
5. **Berikan imunisasi HB0**

VI. PENATALAKSANAAN

Tanggal : 05 November2024 Pukul : 14.05 WIB

1. **Menjaga kehangatan bayi mencegah terjadinya Hipotermi dengan membedong bayi dengan kain kering dan bersih serta menjauhkan bayi dari benda-benda yang dapat membuat bayi kehilangan panas**
2. **Melakukan pemeriksaan fisik bayi dari kepala sampai kaki melihat apakah ada kelainan atau tidak untuk mencegah komplikasi pada bayi**
3. **Melakukan perawatan tali pusat seperti mengeringkan tali pusat dan membungkus dengan kasa steril**
4. Mengajak ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya serta memberitahukan kepada ibu apa saja yang akan didapat jika ibu memberikan ASI kepada bayinya baik keuntungan yang didapat ibu dan bayi
5. Memberikan imunisasi HB0 pada bayi

VII. EVALUASI

Tanggal : 05 November 2024 Pukul : 14:35 WIB

S : -

O : Keadaan umum baik, pernafasan 40 kali/menit, nadi 120 kali/menit, suhu 37.2^{o}C BB 3255 gram.

A : bayi baru lahir cukup bulan dengan usia 8 jam.

P : 1. Melakukan penghangatan.

E/ mencegah terjadinya hipotermi

2. melakukan perawatan tali pusat.

E/ membungkus tali pusat dengan menggunakan kasa kering dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi melalui tali pusat.

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY. R DI KLINIK KURNIA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

I. **PENGUMPULAN DATA**

A. **Identitas/ Biodata**

Nama : Ny. R
Umur : 28 Tahun
Status : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Gedung Johor

B. **Anamnesa (Data Subjektif)**

1. **Alasan datang : Ingin menggunakan KB, Ibu sedang Menyusui anaknya, dan belum mendapat haid sama sekali**
2. **Yang mengantar : Suami**
3. **Riwayat menstruasi**
   a. **Menarche : 13 Tahun**
   b. **Siklus : 28 Hari**
   c. **Lamanya : 6-7 Hari**
   d. **Banyaknya : 2-3 x ganti doek**
   e. **Sifat darah : Encer**
   f. **Warna : Merah**
4. **Riwayat perkawinan**

   Kawin ke : 1
5. **Riwayat kehamilan yang lalu**
   a. **Gravida : 2 kali**
   b. **Partus : 2 kali**
   c. **Abortus : 0 kali**
   d. **Lahir hidup : 2 orang**
   e. **Lahir mati : 0 kali**
6. **Riwayat KB sebelumnya**

   Dalam 1 tahun terakhir apakah memakai kontrasepsi

Ya

Bila ada, jelaskan masing-masing

No	Metode	Lama Pemakaian	Alasan Penghentian metode Kontrasepsi
	Pil	**6 bulan**	**Ingin punya anak lagi**
	IUD		
	Injeksi		
	Kondom		
	DLL		

7. Riwayat medis sebelumnya

Sedang mendapatkan pengobatan jangka panjang : Tidak

Saat ini sedang menderita sakit kronis : Tidak

8. Riwayat sosial

a. Merokok : Tidak

b. Minuman keras : Tidak

9. Riwayat ginekologi

a. Tumor ginekologi : Tidak ada

b. Operasi ginekologi yang pernah dialami : Tidak ada

c. Penyakit kelamin : Tidak ada

d. GO : Tidak ada

e. Sipilis : Tidak ada

f. Herpes : Tidak ada

g. Keputihan : Tidak ada

h. Perdarahan tanpa sebab yang jelas : Tidak ada

C. **Pemeriksaan Fisik**

1. Status generalis : Baik

2. Tanda vital

TD : 120/70 mmHg

Nadi : 81 x/menit

RR : 22 x/menit

Suhu : 36.4˚C

TB : 156 cm

BB : 58 kg

3. **Abdomen**

- **Perut : Baik, tidak ada pembesaran pada fundus, tidak ada bekas luka operasi**

4. **Genetalia**

Inspeksi : Tidak dilakukan

VT : Tidak dilakukan

Inspekulo

- ✓ **Tanda-tanda peradangan : Tidak dilakukan**
- ✓ **Tanda-tanda kehamilan : Tidak dilakukan**
- ✓ **Perdarahan : Tidak dilakukan**
- ✓ **Panjang uterus : Tidak dilakukan**

D. **Pemeriksaan Laboratorium**

- **Planotes : Tidak dilakukan**
- **HB : 11 gr%**
- **HT : Tidak dilakukan**

E. **Data Psikologis**

- **Pengertian ibu tentang efek samping alat kontrasepsi : Baik**
- **Pengaruh alat kontrasepsi dengan agama yan di anut : Tidak ada**
- **Pengaruh alat kontrasepsi dengan hubungan suami : Tidak ada**

II. **Interpretasi Data, Diagnosa, Masalah dan Kebutuhan**

Dx :

Ny. R umur 28 tahun P2A0 akseptor KB MAL

Ds :

- **Ibu mengatakan bernama Ny. R dan berumur 28 tahun**
- **Ibu mengatakan telah memiliki 2 anak**
- **Ibu mengatakan ingin menggunakan KB**

Do :

- **K/U ibu baik**

TD : 120/70 mmHg RR : 22x/menit

HR : 81 x/menit T : 36,4˚C

- **Ibu tidak dalam kondisi hamil**

Tanggal kunjungan 20 November2024

- **Tidak ada pembesaran pada abdomen**
- **Tidak ada tanda- tanda chadwick pada genetalia ibu**

Masalah

Tidak ada

Kebutuhan

Penkes tentang KB

III. **Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial**

Tidak ada

IV. **Antisipasi Masalah dan Tindakan Segera**

Tidak ada

V. **Perencanaan**

1. **Beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan**
2. **Beritahu ibu tentang Jenis jenis KB**
3. **Jelaskan Cara pemakaian KB yang dipilih ibu**
4. **Beritahu ibu tentang keuntungan menggunakan KB yang diinginkan**
5. **Jelaskan cara kerja KB yang dipilih**
6. **Anjurkan ibu untuk kontrol ulang**

VI. **Penatalaksanaan**

1. **Memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu baik dan bisa menggunakan KB apapun**
2. **Memberitahu kepada ibu jenis-jenis KB baik itu yang hormonal maupun yang tidak serta KB alamiah yang bisa digunakan oleh Ibu**

E:/Ibu ingin memakai KB MAL

3. **Menjelaskan cara pemakaian MAL yaitu dengan memberikan bayinya ASI saja tanpa memberikan makanan tambahan lain kepada bayi bahkan air putih sekalipun pemakaian MAL ini dilakukan dengan memberi ASI selama 6 bulan dan secara on demand atau terus menerus**
4. **Keuntungan menggunakan metode KB ini adalah :**
    a. **Efektifitasnya tinggi jika dilakukan secara baik dan benar**
    b. **Segera efektif**
    c. **Tidak mengganggu seksual**
    d. **Tidak ada efek samping secara system**
    e. **Tidak perlu pengawasan medis**
    f. **Tidak perlu obat atau alat**
    g. **Tanpa biaya**
5. **Menjelaskan Cara Kerja KB MAL adalah Metode KB ini mengandalkan manajemen laktasi atau menyusui yang dimana ibu harus menyusui secara penuh, belum haid sejak masa nifas selesai dan umur bayi kurang dari 6 bulan jadi bayi harus terus menyusui untuk meningkatkan kadar hormone prolactin dalam tubuh ibu untuk mencegah ovulasi.**
6. **Menganjurkan ibu untuk melakukan control ulang dan mengunjungi tenaga kesehatan apabila ibu mengalami haid dalam melakukan metode ini**

VII. **Evaluasi**

1. **Ibu sudah mengetahui tentang hasil pemeriksaan**
2. **Ibu sudah memilih kontrasepsi yang ingin digunakan**
3. **Ibu sudah mengetahui keuntungan serta cara pemakaian KB MAL yang telah dipilih**
4. **Ibu sudah mengetahui cara kerja KB MAL**
5. **Ibu bersedia melakukan kunjungan ulang**